

Онкология и радиология Казахстана

№3 (20) 2011

Қазақстан онкология және радиология журналы

Главный редактор
К.Ш. Нургазиев, д.м.н.

Редакционная коллегия

Абисатов Х.А., Адильбаев Г.Б., Есентаева С.Е. (зам. главного редактора), Жолдыбай Ж.Ж., Ижанов Е.Б., Имангалиева Н.Т., Кайрбаев М.Р. (административный редактор), Ким В.Б., Нурғалиев Н.С., Сейтказина Г.Д., Талаева Ш.Ж., Чичуа Н.А.

Редакционный совет

Давыдов М.И. (Россия)	Ш. Фуджи (Япония)
Мусулманбеков К.Ж. Казахстан	В. Кешич (Сербия)
Шарман А.Т. (Казахстан)	М.А. Мур (США)
Алчинбаев М.К. (Казахстан)	Р. Якез (Австрия)
М. Россели (Италия)	К. Нарайян (Австралия)

Ответственный секретарь

Кабдрахманов К.Б.

Редакторы переводов

Галушкин М.А., Утельбаева А.Е., Шалбаева Р.Ш.

Адрес редакции

г. Алматы, 050022, пр. Абая, 91

Казахский НИИ онкологии и радиологии МЗ РК

Тел. (327) 292 10 63

«Онкология и радиология Казахстана», №3 (20), 2011 г.

Собственник - РГКП «Казахский НИИ онкологии и радиологии МЗ РК»

Свидетельство о регистрации - №10248-ж от 14.07.2009 г.

Тип. «Идан», ул. Коммунальная, 39

Тираж 200 экз.

Журнал выпускается 1 раз в 3 мес.

Содержание

Скрининг онкозаболеваний

Национальная скрининговая программа: реализация скрининговых осмотров по раннему выявлению рака молочной железы, шейки матки, колоректального рака. *Нургазиев К.Ш., Кулкаева Г.У., Жылкайдарова А.Ж.* (3)

Проведение скрининговых осмотров по раннему выявлению онкологических заболеваний в Павлодарской области в 2011 году. *Жылкайдарова А.Ж., Баймаханов Т.Б., Сулейменов М.К.* (7)

Информационное обеспечение скрининга. *Абдикаримов А.М., Мустафина Б.К.* (10)

Скрининг рака шейки матки. *Аубакирова А.Т.* (12)

Перспективы скрининга рака пищевода и желудка в РК. *Ахметжанов О.Т.* (14)

Цитологический скрининг в Семейском регионе. *Байпеисов Д.М., Бекетова Б.Б., Бань Т.П., Манамбаева З.А., Сулейменова А.Т., Жабагин К.Т., Муслимова З.Р.* (19)

Результаты цитологического скрининга рака шейки матки 2006-2010 гг. по Семейскому региону. *Бань Т.П., Шалаганова К.Б., Кыдырбаева Ж.Н., Суртаева Ж.Д., Карипова М.К.* (20)

Результаты маммографического скрининга по данным ГККП «Областной онкологический диспансер» г.Талдыкорган. *Бектурсынов С.М., Голованев Г.А., Есимханова С.Н.* (21)

Алгоритм проведения маммографического скрининга. *Жакенова Ж.К., Хамзин А.Х., Ткачева А.М.* (22)

Ақмола облысындағы қатерлі ісіктердің қауіп факторлары, аурудың таралуы және оны ерте анықтау. *Жантемирова Д.А.* (24)

Информация как средство профилактики. *Жантемирова Д.А.* (26)

Этапные данные скрининга рака молочной железы. *Сандыбаев М.Н., Кузнецова Т.В., Кротова А.Г., Уразалин А.М., Муздыбаев Р.А., Абылченова А.Р., Манамбаева З.А.* (27)

Результаты целевого маммографического обследования в Семейском регионе Восточно-Казахстанской области. *Сандыбаев М.Н., Манамбаева З.А., Байпеисов Д.М., Абылченова А.Р., Карипова М.К., Жабагин К.Т.* (28)

Организация скрининга рака шейки матки в Республике Казахстан. *Шибанова А.И., Каирбаев М.Р., Жылкайдарова А.Ж., Кусаинова Б.Т., Ольшевская Н.В., Якупова Л.М., Мухаметгалиев Н.А., Тюменева Ф.Х., Рубцова Л.Н., Тихонова Т.А.* (29)

Эндоскопическая тактика в рамках программы скрининга колоректального рака в РК. *Ахметжанов О.Т., Калиева Ж.Ж.* (30)

Результаты маммографического исследования женщин в Кызылординской области. *Толеутайұлы К., Байкадамов А.Х., Толеутай У.К., Кайнарбаева Л.К., Ербошаев С.У., Абдикерова А.Е.* (31)

Цитологический скрининг по ранней диагностике рака шейки матки. *Якупова Л.М.* (33)

Эпидемиология

Распространенность основных форм злокачественных опухолей у детей в Казахстане. *Жумашев У.К.* (35)

Заболеваемость раком молочной железы в Южно-Казахстанском регионе. *Досанова Р.Е.* (38)

Динамика показателей онкологической заболеваемости области. *Бектурсынов С.М., Голованев Г.А.* (40)

Организация деятельности специализированных консультативно-диагностических отделений онкологических диспансеров. *Нургазиев К.Ш., Байпеисов Д.М., Сейтказина Г.Д., Жылкайдарова А.Ж.* (41)

Вопросы диагностики

Программа ранней диагностики рака простаты в РК. *Нургазиев К.Ш., Нурғалиев Н.С., Ишкинин Е.И.* (43)

Программа ранней диагностики колоректального рака в РК. *Нургазиев К.Ш., Ижанов Е.Б., Кузиков М.У., Лашкул С.В., Джуманов А.И.* (47)

Цитологический метод в ранней диагностике рака молочной железы. *Якупова Л.М.* (49)

Итоги работы передвижной маммографической установки по Семейскому региону. *Кузнецова Т.В.* (51)

Концептуальный взгляд на оптимизацию дифференциальной диагностики карциномы и опухолеподобных патологий поджелудочной железы. *Бердаuletов С.Б., Аязбаев Ш.У.* (52)

Компьютерная и магнитно-резонансная томография в уточняющей диагностике рака пищевода. *Аязбаев Ш.У., Бердаuletов С.Б., Шантемиров С.Б., Мукантаев Т.Е.* (53)

Диагностическая колоноскопия в амбулаторной практике. *Бектурсынов С.М., Менисов Б.К.* (54)

Первичная и отсроченная хирургическая реабилитация больных раком молочной железы. *Танжарыков Е.С.* (55)

Анестезиология

Трудная интубация трахеи. Пути решения проблемы. *Кусаинов Б.Р.* (56)

Эпидуральная анестезия при операциях на толстом кишечнике у онкологических больных. *Кусаинов Б.Р.* (59)

Клиническая фармакология

Применение Севофлурана в хирургии опухолей головы и шеи. *Кусаинов Б.Р.* (60)

Национальная скрининговая программа: реализация скрининговых осмотров по раннему выявлению рака молочной железы, шейки матки, колоректального рака

Нургазиев К.Ш., Кулкаева Г.У., Жылкайдарова А.Ж.

Министерство здравоохранения РК, Казахский НИИ онкологии и радиологии

Актуальность

Смертность от злокачественных новообразований занимает второе место в структуре общей смертности населения Республики Казахстан. Мероприятия, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний (скрининговые исследования), а также обеспечение химиопрепаратами, укрепление материально-технической базы медицинских организаций позволили снизить показатель смертности от злокачественных новообразований с 122,6 на 100 тысяч населения в 2005 году до 103,9 в 2010 году (данные КазНИИОиР). За этот же период отмечается снижение показателя заболеваемости злокачественными новообразованиями — со 192,5 на 100 тыс. населения в 2005 году до 181,2 в 2010 году. При этом самый высокий уровень данного показателя стабильно регистрируется в регионах, где развита промышленность — в Северо-Казахстанской (282,6), Восточно-Казахстанской (272,3) и Павлодарской (270,4) областях.

Реализуемые в Республике с 2008 года скрининговые исследования по раннему выявлению рака молочной железы и рака шейки матки позволили выявить за три года и 3 месяца 2011 года 1950 случаев рака молочной железы (или 0,15% из числа осмотренных, европейский стандарт — 0,2-0,3%) и 509 случаев рака шейки матки (0,03%, что соответствует европейскому стандарту проведения скрининговых осмотров). В то же время в регионах с высокой онкологической заболеваемостью (Восточно-Казахстанская, Павлодарская области) уровень выявления злокачественных образований молочной железы и шейки матки во время скрининговых осмотров был ниже республиканских показателей.

Государственной программой развития здравоохранения «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 гг. предусмотрено дальнейшее расширение Национальной скрининговой программы за счет увеличения перечня нозологий с ежегодным охватом не менее 30% от общей численности населения, подлежащего скрининговым осмотрам, разработкой и внедрением целевых индикаторов, отражающих эффективность проводимых мероприятий по профилактике, ранней диагностике злокачественных новообразований, выявления лиц с предопухолевой патологией и факторами риска, основанных на доказательной медицине.

Материалы и методы

В работе представлены результаты скрининговых исследований за 6 месяцев 2011 года.

За первое полугодие 2011 года маммографические исследования проведены 156 623 женщинам в возрасте 50, 52, 54, 56, 58 и 60 лет, что составило 35,6% от запланированного объема.

Наибольший процент охвата от запланированного количества женщин отмечен в Павлодарской (обследовано

Жұмыста сүт безі, жатыр мойны мен колоректалды рагын анықтау бойынша 2011 жылдың 6 айында Ұлттық скринингтік бағдарламасын жүзеге асырудың қорытындылары ұсынылған. Сүт безі рагын анықтау бойынша мақсатты топтың 156 623 әйел азаматы қаралып, 75 ауру жағдайы анықталған (тексерілгендердің 0,05%). Жатыр мойнының қатерлі ісігіне 218 830 әйел қаралып, 86-сында ЖМР анықталды, бұл 0,04% үлесін құрады. Колоректалды скрининг бойынша гамокульт тестпен тексерілуі тиесілі азаматтардың 1 222 707-сі қаралды (әйелдер мен ер адамдар). Рак ауруы 1 адамда, рак алды 17 адамда анықталды. Ұлттық скрининг бағдарламасын жетілдіру бойынша ұсыныстар да жазылған.

В работе представлены результаты реализации Национальной скрининговой программы по раннему выявлению рака молочной железы, шейки матки, колоректального рака за 6 месяцев 2011 года. По скринингу РМЖ осмотрено 156 623 женщин целевой группы, выявлено 75 случаев РМЖ (0,05% от числа обследованных). По скринингу РШМ осмотрено 218 830 женщин, РШМ установлен у 86 женщин, что составляет 0,04%. По колоректальному скринингу гемокульт тест проведен 1 222 707 мужчинам и женщинам целевой группы, рак был выявлен у 1 пациента, предрак — у 17. Представлены предложения по дальнейшему совершенствованию Национальной скрининговой программы.

The results of the National Cancer Screening Program for 6 months 2011 are presented. Breast cancer screening involved 156 623 women from target group. 75 cases of a breast cancer (0,05 %) are detected. Cervical cancer screening involved 218 830 women, 86 women (0,04%) had diagnosis of cancer. Colorectal screening by haemocult-test involved 218 830 patients. The 1 case of colorectal cancer and 17 cases of precancerous lesions are detected. Offers for further improvement of the National Cancer Screening Program are suggested.

7276 женщин — 52,7%), в Западно-Казахстанской (8316 или 51,3%) областях и г.Астана (4862 и 50,3%), наименьший — в Алматинской (12079 — 25,7%), Мангистауской (2168 — 22,1%), Южно-Казахстанской (17976 — 29,5%) областях.

За первое полугодие 2011 года в рамках скрининга на раннее выявление предопухолевых и злокачественных новообразований шейки матки проведено цитологическое исследование мазков 218830 женщинам в возрасте 30, 35, 40, 45, 50, 55 и 60 лет, что составило 42,9% от числа

запланированного контингента. Наибольший процент охвата цитологическим скринингом отмечен в Алматинской (88,5%), Западно-Казахстанской (65,9%), г.Астана (57%) и г.Алматы (55,4%), менее трети от плана – в Атырауской (23,2%), Южно-Казахстанской (28,9%), Кызылординской (31,3%), Мангистауской (31,5%), Восточно-Казахстанской (31,6%) областях.

В рамках скрининга на раннее выявление предопухолевых и злокачественных новообразований толстой и прямой кишки проведен гемокульт-тест (тест на скрытую кровь) 1222707 мужчинам и женщинам в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 и 70 лет. По данным 7 регионов охват составил 16% от числа запланированного контингента – от 6,5% в Акмолинской области до 23,9% в г.Астана.

Результаты. Скрининг на раннее выявление доброкачественных и злокачественных новообразований молочной железы.

Рак молочной железы (РМЖ) выявлен в 75 случаях, что составило 0,04% от числа обследований (таблица 1). Самый высокий процент выявления РМЖ в Южно-Казахстанской (0,1%), Западно-Казахстанской (0,1%) областях. Ни одного случая рака за 6 месяцев не выявлено в Актыбинской, Атырауской, Карагандинской и Кызылординской областях.

На рисунках 1 и 2 представлены распределение выявленного РМЖ в зависимости от размеров опухолевого узла – до 1 см и более 1 см.

Таблица 1 - Информация по маммографическому обследованию с целью выявления рака молочной железы (РМЖ) за 6 месяцев 2011 года.

№	Регионы	План на 2011 г.	Выполнено		РМЖ	
			абс.	%	абс.	%
1	Акмолинская	22448	7337	32,7	4	0,05
2	Актыбинская	20570	9925	48,2	-	-
3	Алматинская	47000	12079	25,7	4	0,03
4	Атырауская	11627	2063	17,7	-	-
5	ВКО	41176	11629	28,2	7	0,06
6	Жамбылская	23150	8615	37,2	3	0,03
7	ЗКО	16234	8316	51,3	8	0,1
8	Карагандинская	52772	17591	33,3	-	-
9	Кызылординская	13131	4546	34,6	-	-
10	Костанайская	27 551	11149	40,5	17	0,15
11	Мангистауская	9816	2168	22,1	1	0,04
12	Павлодарская	13842	7276	52,7	2	0,03
13	СКО	20496	9116	44,5	3	0,03
14	ЮКО	61109	17976	29,5	17	0,1
15	г. Алматы	49294	21975	44,5	7	0,03
16	г. Астана	9662	4862	50,3	2	0,04
Итого		4 3 9 838	1 5 6 623	35,6	75	0,04

РМЖ менее 1 см чаще выявлялся в Западно-Казахстанской (0,06%), Южно-Казахстанской (0,05%) областях и г.Астана (0,04%), более 1 см – в Костанайской области (0,14%). В целом по стране выявление РМЖ до 1 см составило 41,3% (европейский стандарт 60-80%). Наибольший процент малой формы РМЖ (до 1 см) выявлен в г.Астана (100%), Северо-Казахстанской (66,7%), Жамбылской (66,7%) областях.

Скрининг на раннее выявление предопухолевых и злокачественных новообразований шейки матки.

На рисунке 3 представлено распределение выявленных доброкачественных заболеваний молочной железы в разрезе по регионам. Высокий уровень выявления доброка-

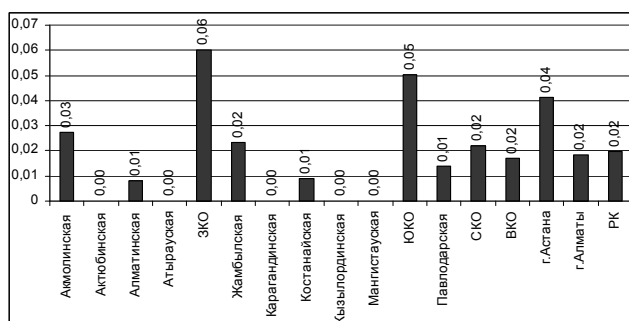


Рисунок 1. Результаты маммографических исследований за 6 месяцев 2011 года – опухолевый узел до 1 см (%)

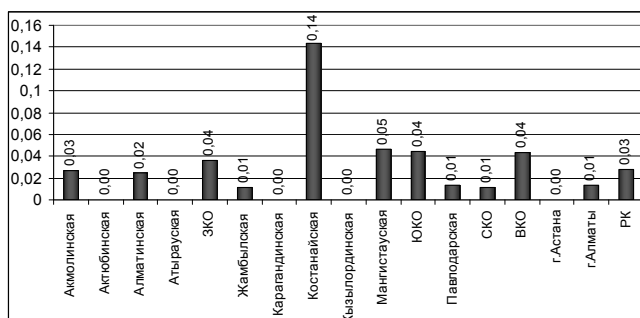


Рисунок 2. Результаты маммографических исследований за 6 месяцев 2011 года – опухолевый узел до 1 см (%)

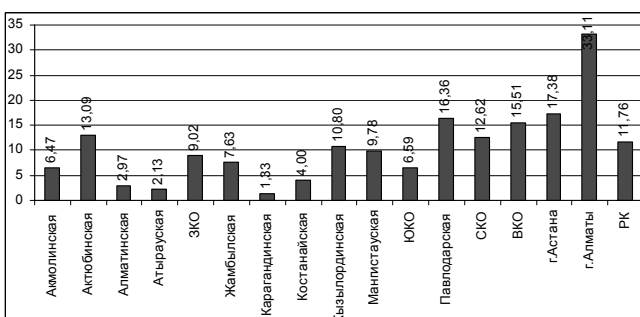


Рисунок 3. Процент выявленных доброкачественных заболеваний молочной железы по результатам маммографических исследований за 6 месяцев 2011 года.

чественной патологии отмечен в г.Алматы (33,1% от числа обследований), г.Астана (17,4%), Павлодарской (16,4%), Восточно-Казахстанской (15,5%), Актыбинской (13,1%), Северо-Казахстанской (12,6%) областях, низкий уровень – в Карагандинской (1,3%), Атырауской (2,1%), Алматинской (3%) областях при среднестрановом уровне 11,8% от числа проведенных маммографий (18417 из 156623).

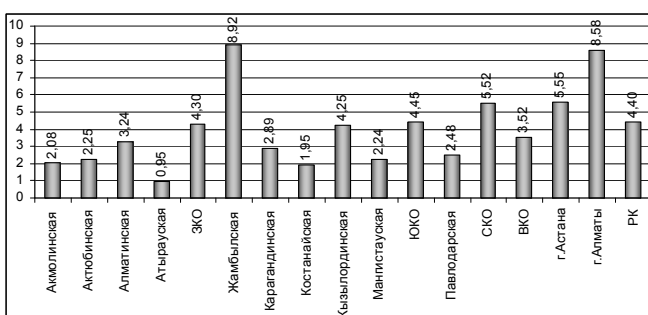


Рисунок 4. Процент больных с заболеваниями шейки матки по результатам 6 месяцев 2011 года в разрезе по регионам.

Как представлено на рисунке 4, у 4,4% обследованных женщин выявлена различная патология шейки матки.

Наиболее чаще патология выявлялась в Жамбылской (8,9%) области и г.Алматы (8,6%), реже всего – в Атырауской (1%), Костанайской (2%), Акмолинской (2,1%), Мангистауской (2,2%), Актыбинской (2,3%) и Павлодарской

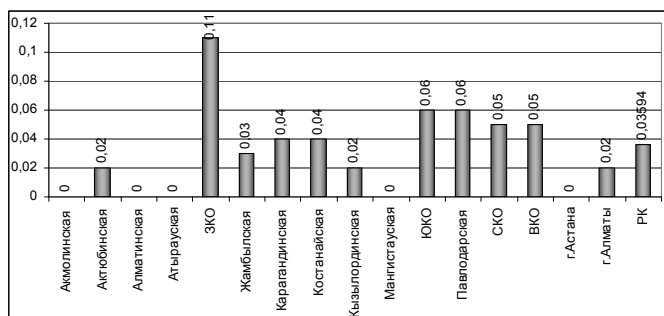


Рисунок 5. Процент больных с выявленным раком шейки матки по результатам 6 месяцев 2011 года в разрезе по регионам.

(2,5%) областях.

Рак шейки матки (РШМ) выявлен в 86 случаях, что составило 0,04% к числу проведенных обследований (рисунок 5). Это превышает Европейский стандарт (0,01-0,02%). Наиболее высокий уровень выявления РШМ отмечается в Западно-Казахстанской (0,1%), Южно-Казахстанской (0,06%), Павлодарской (0,06%), Северо-Казахстанской (0,05%), Восточно-Казахстанской (0,05%) областях. В абсолютных цифрах наибольшее количество случаев отмечено в Южно-Казахстанской (23), Западно-Казахстанской (13), Карагандинской и Восточно-

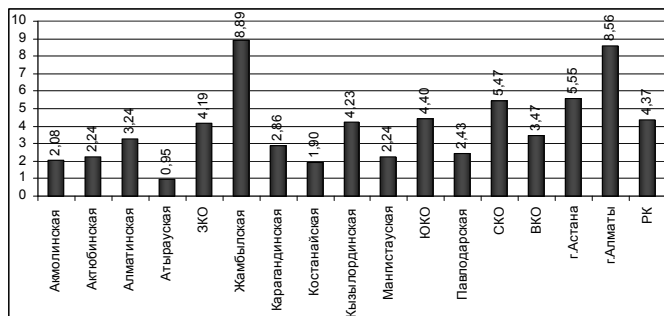


Рисунок 6. Процент больных с выявленной предопухоловой патологией шейки матки по результатам 6 месяцев 2011 года в разрезе по регионам.

Казахстанской (по 9 случаев) областях.

Предопухоловая патология выявлена у 10448 женщин, что составило 4,4% (рисунок 6). Наиболее чаще патология выявлялась в Жамбылской (8,9%) области и г.Алматы (8,6%), реже всего – в Атырауской (1%), Костанайской (1,9%), Акмолинской (2,1%), Мангистауской (2,2%) областях.

Из числа предопухоловой патологии следует выделить тяжелую дисплазию шейки матки (HSIL) – 2335 случаев (0,95%) и легкую дисплазию (LSIL) – 15083 случая (6,15%). Высокий уровень выявления HSIL отмечен в Северо-Казахстанской (8,6%) и Акмолинской (2,6%) областях, LSIL – также в Северо-Казахстанской (74,8%), Южно-Казахстанской (3,6%), Восточно-Казахстанской (3,2%), Павлодарской (3,2%) областях. В связи с высоким уровнем выявления дисплазии в Северо-Казахстанской области необходимо определить, не имеет ли место гипердиагностика.

Скрининг на раннее выявление предопухоловых и злокачественных новообразований толстой и прямой кишки.

Гемокульт-тест в основном проводился бензидиновой пробой, что не соответствует методике скрининга. Положительный результат гемокульт-теста отмечен в 5,4% случаях, что соответствует международным данным

(2-10%). Как представлено на рисунке 7, у каждого второго в Атырауской (304 из 635 – 47,9%), у каждого четвертого (27%) в Южно-Казахстанской, у каждого пятого (21,7%) в Акмолинской областях тест на скрытую кровь был положительным. Эти данные значительно превышают результаты зарубежных исследований и доказывают необходимость придерживаться рекомендуемой методики скрининга на раннее выявление колоректального рака с использованием иммунохимического теста (i-FOBT).

Колоректальный рак был выявлен только у одного пациента из Северо-Казахстанской области, еще у 17 была выявлена предопухоловая патология.

Обсуждение

С целью повышения эффективности профилактических

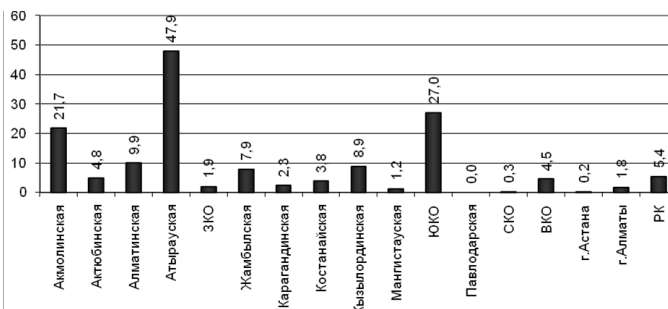


Рисунок 7. Процент пациентов с положительным гемокультур-тестом по результатам 6 месяцев 2011 года в разрезе по регионам.

медицинских осмотров (скринингов) была совершенствована нормативно-правовая база: приняты приказы МЗ РК от 5 января 2011 года № 7 «Об утверждении Положения о деятельности организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь», от 5 января 2011 года № 10 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2010 года № 238 «Об утверждении типовых штатов и штатных нормативов организаций здравоохранения», от 16 марта 2011 года № 145 «О внесении изменений в приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 ноября 2009 года № 685 «Об утверждении Правил проведения профилактических медицинских осмотров целевых групп населения» и другие. Согласно приказа МЗ РК от 1 марта 2011 года № 107 «О проведении выездных республиканских семинаров для специалистов первичной медико-санитарной помощи» было проведено 5 республиканских семинаров с общим охватом 1080 специалистов ПМСП, онкологической службы, специалистов ФЗОЖ с распространением раздаточных материалов. В дальнейшем на местах были проведены кустовые семинары для врачей, средних медицинских работников ПМСП. В сентябре 2011 года рамках консорциума АГИУВ-НИИ было подготовлено 120 преподавателей медицинских ВУЗов страны для дальнейшего каскадного обучения работников ПМСП по внедрению скрининговых обследований, повышению онконастороженности и раннему выявлению визуальных локализаций злокачественных новообразований на уровне.

Во всех регионах приказами Управлений здравоохранения были созданы Рабочие группы по мониторингу скрининговых осмотров. Управлениями здравоохранения, руководителями организаций ПМСП была проведена работа по обеспечению оборудованием и расходными материалами, формированию новых структурных подразделений согласно приказу МЗ РК от 5 января 2011 года № 7 и т.д.

Была проведена определенная работа по повы-

шению информированности населения о проводимых профилактических медицинских осмотрах, а именно: на сайтах управлений здравоохранения, центров формирования здорового образа жизни размещена информация «Минздрав предупреждает: позаботьтесь о своем здоровье – пройдите профосмотр», подготовлен и растиражирован информационно-образовательный материал для населения, в том числе адресное уведомление о необходимости прохождения скрининговых осмотров, в организациях ПМСП у входа и в местах ожидания пациентов установлены стенды с информацией о скрининговых осмотрах. В регионах созданы и утверждены медиа-планы об освещении процесса реализации Национальной скрининговой программы с запланированными выступлениями различных специалистов на местных радио и телеканалах, в печатных СМИ. Совместно со службой ФЗОЖ принимаются меры по повышению мотивации и вовлечению работодателей в прохождение скрининговых осмотров их сотрудниками.

По результатам проведенных скрининговых осмотров за 6 месяцев 2011 года выявлен целый ряд нерешенных проблем как по организационным вопросам, так по внедрению и качеству проведения скринингов.

По оснащению:

1. Острая нехватка маммографов в Алматинской (3), Карагандинской (2), Костанайской (1), Северо-Казахстанской (2) областях, устаревание и нехватка маммографов в Восточно-Казахстанской области (4). Требуют ремонта 1 маммограф в Алматинской (г.Талдыкорган), Восточно-Казахстанской (г.Риддер) областях.

2. Отсутствие передвижного маммографа в Кызылординской области.

3. Не все передвижные медицинские комплексы оборудованы маммографами, вследствие чего имеют место трудности с проведением маммографического скрининга в отдаленных сельских населенных пунктах.

4. Проблема с техническим обслуживанием маммографов в регионах РК.

5. Необходимо установить цифровые маммографы с цифровыми стереотаксическими приставками в онкологических диспансерах станы (19) для проведения уточненной диагностики и выявления малых форм РМЖ.

6. Отсутствие автоматов для окраски по методу Папаниколау в Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской областях, гг.Астана и Алматы.

7. Недостаточная обеспеченность цитологических лабораторий реактивами для проведения PAP-тестов.

8. Поздний закуп гемокульт-тестов. Практически все регионы используют бензидиновую пробу вместо иммуноферментного iFOBT теста, что противоречит методологии скрининга и оказывает существенное влияние на результаты колоректального скрининга.

10. Недостаточная обеспеченность организаций ПМСП ректоскопами.

11. Недостаточная обеспеченность организаций ПМСП колоноскопами и отсутствие видеоскопических стоек с колоноскопами в онкологических диспансерах.

12. Недостаточная обеспеченность организаций ПМСП аппаратами для экспресс-диагностики уровня холестерина крови, сахара крови, а также расходными материалами (полосками для аппаратов экспресс-диагностики).

По кадровому обеспечению:

Отсутствие отдельно выделенных штатов рентгенологов для проведения «вторых читок» в онкологических диспансерах.

Отсутствие отдельно выделенных штатов врачей-цитологов, цитотехников для проведения цитологического скрининга в онкологических диспансерах.

Недоукомплектование и неполное приведение в соответствие с приказом МЗ РК от 5 января 2011 года № 7 штатов и структуры ПМСП в части создания отделений профилактики и социально-психологической помощи с выделение достаточного количества ставок медицинского персонала (второй/третьей медсестры, для доврачебного кабинета и т.д.), участвующего в скрининговых осмотрах.

Недостаточная подготовка медицинских работников ПМСП по внедрению скрининговых осмотров, например, по методике опроса, что отражается на результатах распространенности поведенческих факторов риска, других результатах скрининговых осмотров.

Рекомендации

1. Проводить дальнейшее обучение специалистов ПМСП по проведению скрининговых осмотров, в том числе среди средних медицинских работников, руководителей отделений профилактики и социально-психологической помощи, а также врачебного персонала ПМСП, вовлеченного в скрининг.

2. Проводить обучение медицинских работников специализированных служб (рентгенологов, цитологов, офтальмологов, кардиологов, эндокринологов, акушер-гинекологов, маммологов, хирургов, проктологов) вопросам проведения скрининга.

3. Осуществлять работу по повышению информированности и мотивации населения, работодателей, других представителей гражданского общества о необходимости прохождения скрининговых осмотров.

4. Управлениям здравоохранения областей, гг.Астана, Алматы:

4.1. решить в кратчайшие сроки проблемы по кадровому, структурному и материально-техническому оснащению организаций ПМСП, специализированных служб для реализации приказов МЗ РК по проведению профилактических медицинских осмотров;

4.2. определить количественные показатели целевых групп населения, подлежащих скрининговым осмотрам;

4.3. возложить на руководителей организаций ПМСП ответственность за передачу в РИАЦ проверенной базы данных о прошедших скрининговый осмотр пациентов, прикрепленных к данному ЛПУ.

5. ТОО «Мединформ»: сформировать и обеспечить территориальные РИАЦ программным обеспечением по обработке результатов скрининговых осмотров в соответствии с рекомендациями Рабочей группы по научно-методическому сопровождению профилактических медицинских осмотров.

6. Рабочей группе по научно-методическому сопровождению профилактических медицинских осмотров: организовать выезды в регионы для мониторинга организации и проведения скрининговых осмотров на местах с разработкой дальнейших предложений по совершенствованию скрининговых осмотров.

Проведение скрининговых осмотров по раннему выявлению онкологических заболеваний в Павлодарской области в 2011 году

Жылкайдарова А.Ж., Баймаханов Т.Б., Сулейменов М.К.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, Павлодарский областной центр формирования здорового образа жизни, Павлодарский областной онкологический диспансер

Актуальность

Одним из направлений Государственной программы развития здравоохранения на 2011-2015 гг. является усиление профилактических мероприятий, скрининговых исследований, совершенствование диагностики, лечения и реабилитации основных социально-значимых заболеваний. В этой связи запланировано развитие Национальной скрининговой программы. Ее реализация позволит спасти жизни тысячи наших соотечественников и сделать существенный вклад в экономику нашей страны в виде сокращения прямых и косвенных потерь общества от болезней и преждевременной смерти граждан.

Скрининговые осмотры по раннему выявлению рака молочной железы и шейки матки внедряются с 2008 года. В течение этого времени принимаются меры по совершенствованию программ раннего выявления злокачественных новообразований.

Материалы и методы

Проведен анализ результатов скрининговых осмотров за 6 месяцев 2011 года. За отчетный период было осмотрено 7307 женщин в возрасте 50, 52, 54, 56, 58 и 60 лет, что составляет 52,7% к запланированному числу. Три четверти (5513 женщин) составили жительницы гг. Павлодар, Аксу и Экибастуза (рисунок 1). Наибольшее количество сельских

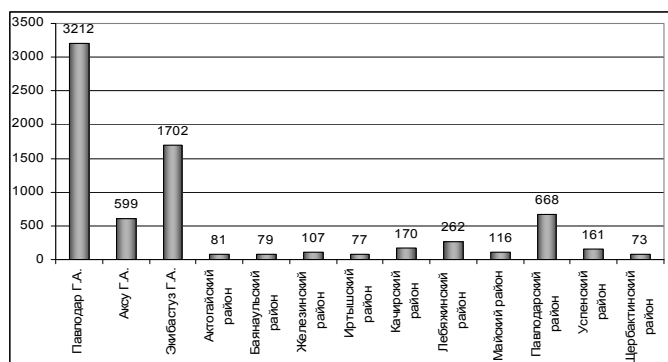


Рисунок 1. Количество осматриваемого населения в ходе скринингового обследования на раннее выявление заболеваний молочной железы за 6 месяцев 2011 года в разрезе по Павлодарской области.

жителей, прошедших маммографическое обследование, проживали в Павлодарском (668) и Лебяжинском (202) районах. Реже всего маммографический скрининг проходили жительницы Щербактинского (73), Иртышского (77), Баянаульского (79) и Актогайского (81) районов.

За 6 месяцев 2011 года осмотрено 10636 женщин в возрасте 30, 35, 40, 45, 50, 55 и 60 для выявления заболеваний шейки матки, что составило 52,9% к запланированному объему. Из числа осматриваемых 72,2% (7681) составили городские жительницы. Наибольшее количество сель-

В работе представлены результаты проведения скринингов в Павлодарской области за 6 месяцев 2011 года. По скринингу РМЖ осмотрено 7307 женщин целевой группы, выявлено 2 случая рака молочной железы (0,3% от числа обследованных). По скринингу РШМ осмотрено 10636 женщин, РШМ установлен у 4 женщин, что составляет 0,04%. По колоректальному скринингу гемокульт тест проведен лишь 342 пациентам, у всех тест был отрицательным. Представлены предложения по дальнейшему совершенствованию скрининговых осмотров в регионе.

Жұмыста 2011 жылдың 6 айында Павлодар облысында өткізілген скрининг қорытындылары ұсынылған. Сүт безі рагы бойынша мақсатты топтың 7307 әйелі қаралып, сүт безі қатерлі ісігінің 2 жағдайы анықталған (бұл тексерілгендердің 0,3% үлесін құрайды). Жатыр мойны рагына 10636 әйел тексеріліп, ауру 4 әйелде анықталды, яғни пайыздық үлесі - 0,04%. Колоректалды қатерлі ісігін анықтау бойынша гемокульт тест тек 342 емделушіге жасалып, ауру анықталмады. Сонымен бірге мақалада аймақта скринингтік тексерісті жетілдіру бойынша ұсыныстар да келтірілген.

The results of cancer screening in Pavlodar oblast for 6 months 2011 are presented. Breast cancer screening involved 7307 women from target group. 2 cases of a breast cancer (0,3 %) are detected. Cervical cancer screening involved 10636 women, 4 women (0,04%) had diagnosis of cancer. Colorectal screening by haemocult-test involved only 342 patients, the test was negative in all cases. Offers for further screening improvement in region are suggested.

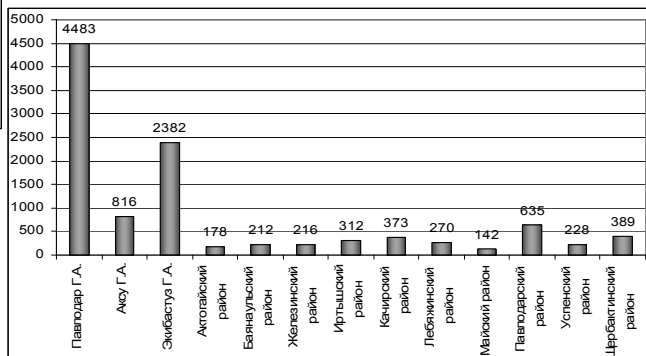


Рисунок 2. Количество осматриваемого населения в ходе скринингового обследования на раннее выявление заболеваний шейки матки за 6 месяцев 2011 года в разрезе по Павлодарской области.

ских жительниц было осмотрено в Павлодарском (635), Щербактинском (389), Качирском (373) и Иртышском (312)

районах. Наименьшее количество прошедших цитологический скрининг было в Майском (142) и Актогайском (178) районах (рисунок 2).

За отчетный период обследование по раннему выявлению заболеваний толстой и прямой кишки путем определения скрытой крови в кале проведено 342 пациентам в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 и 70 лет. Исследование проведено путем использования бензидиновой пробы, что не соответствует требованиям приказа МЗ РК от 16 марта 2011 года № 145 по проведению скрининговых осмотров. Согласно данного приказа, определение скрытой крови в кале (гемокульт-тест) должен проводиться иммунохимическим методом (iFOBT-тест).

Результаты

Скрининг на раннее выявление доброкачественных и злокачественных новообразований молочной железы.

У 8,5% из числа обследованных женщин была выявлена опухолевая патология молочной железы различного характера. Как представлено на рисунке 3, наиболее часто данная патология выявлялась у жительниц г.Экибастуза (26,7%), Железинского (15,9%), Успенского (11,8%) и Качирского (10%) районов. Ни одного случая патологической маммографии не было отмечено в Актогайском, Иртышском, Майском, Щербактинском районах.

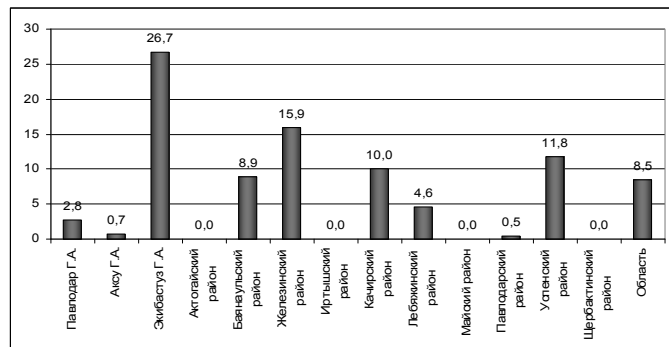


Рисунок 3. Процент выявленных больных с доброкачественными и злокачественными новообразованиями молочной железы по результатам 6 месяцев 2011 года, в разрезе по Павлодарской области.

По данным маммографического скрининга за 6 месяцев 2011 года выявлено 2 случая рака молочной железы (0,3% от числа обследованных). Из них у одной женщины выявлена опухоль до 1 см, у другой – свыше 1 см.

Скрининг на раннее выявление предопухолевых и злокачественных заболеваний шейки матки.

В целом по области выявлено 264 случая патологии шейки матки, что составило 2,5% к числу осматриваемого населения (рисунок 4). Самый высокий уровень данной патологии выявлен в Баянаульском районе – 40 женщин из 212, то есть почти каждая пятая женщина имеет заболевание шейки матки (18,9%). Несмотря на большой объем осматриваемых женщин, уровень выявляемости в гг.Павлодар, Аксу и Экибастуз составил от 1,3% в г.Павлодаре, что ниже среднеобластного значения, до 4% в г.Экибастузе. Среди сельских районов Высокий уровень выявления патологии шейки матки, после Баянаульского района, отмечен в Качирском районе (3,2%), далее следуют Щербактинский (2,1%), Железинский (2%) и Иртышский (1,6%) районы.

В таблице 1 представлена информация о результатах цитологического скрининга. Как видно из представленной таблицы, наибольший процент патологии приходится на воспалительные заболевания шейки матки (18,2%).

По результатам проведенного цитологического скрининга патология HSIL выявлена у 43 женщин (0,4%), LSIL – у 346 (3,2%).

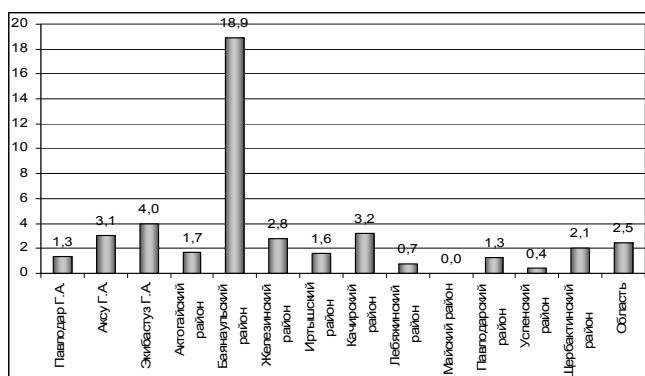


Рисунок 4. Процент выявленных больных с доброкачественными и злокачественными новообразованиями шейки матки по результатам 6 месяцев 2011 года, в разрезе по Павлодарской области.

Таблица 1 - Выявленная патология шейки матки по результатам 6 месяцев 2011 года.

Патология шейки матки	В ы я в л е н а патология, абс.число	% к числу осматриваемых
Дисплазия I ст	346	3,2%
Дисплазия II ст	43	0,4%
Дисплазия III ст	1	0,01%
Подозрение на рак	0	
Рак	4	0,04%
Воспалит. заболевания шейки матки	1987	18,2 %
Пролиферация железистого эпителия	98	0,9%

Рак шейки матки установлен у 4 женщин, что составляет 0,04% и соответствует республиканскому показателю за отчетный период (0,04%). Процент выявленной патологии был бы выше при соблюдении правил забора и фиксации мазков в ЛПО области. При посещении ЛПО выявлено отсутствие мединструментария для забора мазков и факты неправильной фиксации их. Все женщины с выявленной тяжелой дисплазией вызываются к гинекологу областного онкодиспансера, проводится биопсия и санация.

Скрининг на раннее выявление предопухолевых и злокачественных заболеваний толстой и прямой кишки.

В результате использования бензидиновой пробы ни у одного из 342 обследованных не было выявлено положительной пробы.

Обсуждение

Несмотря на проведенные организационно-методические мероприятия, информационную работу с населением и медицинскими работниками ПМСП, существуют следующие проблемы, которые необходимо решить для повышения результативности скринингов и показателей раннего выявления злокачественных новообразований..

Во-первых, не определены количественные показатели целевых групп, подлежащих скрининговому осмотру до конца текущего года. В связи с этим, не представляется возможным оценить полноту охвата целевой группы населения. Исключение составляют целевые группы по скринингу заболеваний шейки матки и молочной железы.

Во-вторых, не в полной мере обеспечены скрининговые осмотры соответствующим оборудованием и расходными материалами. Нехватка штатов (рентгенологов для «вто-

рой» читки маммограмм, цитологов) в онкологическом диспансере являются серьезным сдерживающим фактором в повышении эффективности скрининговых осмотров.

В-третьих, не до конца сформировано программное обеспечение обработки результатов скрининговых осмотров, что не позволяет дать более развернутый анализ и характеристику результатов обследований.

В-четвертых, следует продолжать процесс обучения специалистов, участвующих в скрининговых осмотрах. Так, например, некачественное взятие материала при цитологическом скрининге, значительно увеличивает время проведения обследования и в целом негативно влияет на имидж скрининговых осмотров.

Правила оформления рукописей для журнала «Онкология и радиология Казахстана»

- Формат рукописи - А4.
- Текст должен быть написан в программе Word с использованием шрифта Times New Roman, кеглем 14, с пробелами полуторными.
- Статья подается на CD-диске со вкладышем, на котором обозначается имя автора и название статьи.
- Объем рукописи: научная статья - до 5 стр, случай из практики - 3-4 стр.; обзор, лекция - не более 8 стр.
- Список литературы - минимально необходимый.
- Рукопись визируется руководителем учреждения (кафедры), научным руководителем, скрепляется печатью.
- К рукописи прилагается резюме на казахском, русском, английском языках, ключевые слова, УДК.
- В конце рукописи - сведения об авторах: степень, должность, количество имеющихся публикаций.
- Адрес, телефоны (можно и мобильный), электронная почта.
- Рукопись подписывается лично автором как свидетельство полной аутентичности данных материала, ответственности автора за содержание рукописи.

Информационное обеспечение скрининга

Абдикаримов А.М., Мустафина Б.К.

ГККП «Городской онкологический диспансер», г.Астана

Введение

Среди разнообразных заболеваний молочной железы у женщин рак (РМЖ) представляет важнейшую проблему из-за высокой заболеваемости и смертности от него. В последние годы РМЖ прочно занимает первое место в структуре заболеваемости и смертности от злокачественных заболеваний женского населения Казахстана. Выявляемость заболевания на профосмотрах в целом по стране остается низкой, а показатель запущенности (III-IV стадии), который является критерием качества диагностики, напротив, высоким - около 40%.

Цель исследования

Улучшить показатели скрининга РМЖ, путем укрепления сознания граждан, через средства массовой информации.

Материалы и методы исследования. Как известно, снижение смертности от рака молочной железы и успехи в лечении во многом определяются ранней диагностикой заболевания: при I стадии 5-летний срок переживают 90-95% больных; при IV – менее 10% [1]. Однако, большинство заболевших сами обнаруживали у себя опухоль; выявленные таким путем новообразования, к сожалению, не соответствовали ранним стадиям процесса. Очевидно, что для улучшения результатов диагностики и лечения скринингу (массовому обследованию здорового населения) нет альтернативы. Так, до 1980-х гг. рост заболеваемости и смертности от рака молочной железы наблюдался как в развивающихся, так и в экономически развитых странах. Затем, по мере внедрения маммографического скрининга, улучшения результатов диагностики и лечения, в экономически развитых странах Запада, произошло замедление, а затем и снижение смертности, в то время как в странах Восточной Европы и Латинской Америки, напротив, смертность от рака молочной железы продолжала возрастать. В странах Западной Европы и Северной Америки достигнута возможность выявления I стадии заболевания у 70-80% и, соответственно, выздоровления от рака молочной железы 60-80% женщин [7,8]. Маммографический скрининг, таким образом, позволил уменьшить смертность от рака молочной железы на 30% через 5-7 и на 20% через 15-20 лет от начала скрининга [2].

Учитывая это, основным направлением маммологии, по-прежнему, является поиск путей раннего выявления рака и предопухолевых заболеваний молочной железы. Проведение маммографического скрининга предполагает решение многих организационных задач. Кроме обеспечения финансирования, необходимо добиться активного и добровольного участия в скрининге самих женщин. Следует отметить существенные различия в психологии обследуемых в странах Западной Европы и Северной Америки, сравнительно с «установками» пациенток в Казахстане. В отличие от рационального, прагматичного отношения к своему здоровью на Западе, наш контингент обследуемых часто не уделяет должного внимания состоянию здоровья, не осознает важности, значимости своевременной диагностики и лечения (в том числе – и по стоимости затрат на обеспечение здоровья). Так, анализируя результаты прошлых лет, оказалось что в г.Астана в 2008 году по программе скрининга осмотрено 10902 женщин

Проведен анализ предпосылок для применения скрининга в клинической онкологии. Определены основные проблемы скрининга и рассмотрены подходы к устранению некоторых из них. Продемонстрирована возможность улучшения показателей выявляемости путем укрепления сознания граждан через средства массовой информации. Подчеркнута роль журналистов, психологов, социологов, непосредственное участие которых необходимо для максимального качества скрининга. Выделено понятие «информационное обеспечение» как раздел в комплексе скрининговых мероприятий.

Скринингтің мәліметімен қамтамасыз ету

А.М. Абдикаримов, Б.К. Мустафина

ММҚК «Қалалық онкология диспансері», Астана қ.

Қорытынды: Клиникалық онкологиядағы скринингтің қолдануы үшін алғышарттардың талдауы жүргізілген. Скринингтің негізгі мәселелері анықталған және кейбіреулерді жоюға жолдар қаралған. Табылудың көрсеткіштерінің жақсартуы бұқаралық ақпарат құралдан азаматтардың сананың күшейтуі мүмкіндік жолымен көрсеткен. Журналистердің, психологтердің, социологтердің рөлі көрсетілген және олардың қатысуы скринингтің максимал сапасы үшін керек. «Мәліметпен қамтамасыз ету» ұғым скрининг шараларының кешеніндегі бөлім ретінде ерекшеленген.

Information Support Of Screening

A.M.Abdikarimov, B.K. Mustafina.

SCCE "City oncology hospital", Astana.

Summary: The analysis of the preconditions for the application of screening in clinical oncology was conducted. The main problems of screening and approaches to address some of them was determined. The possibility of improvement in detection by enhancing the consciousness of the citizens through the media is demonstrated. The role of journalists, psychologists, sociologists, direct participation is required to maximize the quality of screening. "Information management" is highlighted as a part of complex screening activities.

и выявлено 18 случаев злокачественных новообразований молочной железы, что составило 0,17%, а в 2009 году осмотрено уже 10161 и выявлено 11 случаев рака молочной железы (0,10%). При этом всего впервые установлен диагноз РМЖ в 2008 и 2009 годах у 177 и 171 женщин соответственно. Из них с первой и второй стадией заболевания выявлено всего лишь 114 (64,4%)-2008г и 119 (69,9%)- в 2009 годах. Тогда возникает вполне разумный вопрос: «В чем же причина? Почему, при таком широком охвате населения РМЖ обнаружен в основном вне программы?»

Проблемой являются мотивы, которые заставляют «асимптоматическое» население принимать участие в скрининге. Рассчитанный биологический цикл развития

большинства злокачественных новообразований длится 8-15 лет [3,4]. Вопрос о том, какие именно предпосылки должен заставить человека, считающего себя практически здоровым, проходить регулярное обследование для исключения (или подтверждения?) наличия рака, практически не изучено. Проводимые по этому вопросу сведения имеют несистематизированный характер. Но, например, от участия в бесплатном скрининге отказываются от одной трети до 79% женщин [5,6]. Таким образом, возникает следующая проблема- информирование населения о проведении скрининга. Казалось бы, этот вопрос прямо не входит в задачи клинической онкологии. Однако любые материальные затраты на организацию скрининга могут оказаться бессмысленными при отсутствии у населения стимулов к участию в скрининге. При построении стратегии информационного обеспечения скрининга необходимо учитывать: доступность средств массовой информации для населения, интеллектуальный уровень потребителей информации, социальные стереотипы проведения в отношении представляемой проблемы, культурные, религиозные и этнические традиции, кратность и объем поступления информации, форму и стиль изложения. В отличие от научно- исследовательских моделей скрининга проведение рутинного скрининга должно предусматривать вариабельность и нестабильность контингентов входящих и выходящих из системы скрининга. Необходимо учитывать еще один критерий скрининга - безопасность. Форма подачи материалов не должна провоцировать потребителей на необдуманные и опасные действия- отказ от посещения врача, или, тем более, на суицид. Следует учитывать также и то, что часть населения, с уже установленным диагнозом, может воспользоваться системой скрининга для «проверки» правильности диагноза.

Результаты исследования

Важнейшая мотивация активного и добровольного участия в профилактических обследованиях – сохранение собственной жизни и здоровья – не укрепляется в сознании граждан средствами массовой информации (телевидение, радио, пресса). Для максимального качества информационного обеспечения необходима стабильная многолетняя работа ряда специалистов- журналистов, психологов, социологов, имеющих соответствующее образование и владеющих перечисленными формами работы. Таким образом, информационное обеспечение скрининга является одним из важных разделов в комплексе скрининговых мероприятий.

Список использованной литературы

1. Ганцев Ш.Х. Онкология (учебник для медицинских вузов). 2-е издание- Москва: МИА 2006, 255с.
2. Семиглазов, В.В., Семиглазов, В.Ф. Клинико-морфологические особенности и методы лечения неинвазивного рака молочной железы /Вопросы онкологии.- 2001.-Т.47,- №3.- С.278-287.
3. Стариков В.И. Общая онкология.- Харьков, 2000.- 120 с.
4. Дильман В.М. Эндокринологическая онкология (руководство для врачей). 2-е издание- Москва: Медицина 1983, 211с.
5. Левшин В.Ф., Федичкина Т.П., Дрожжачих В.Г. и др. Исследование возможностей внедрения и эффективности различных видов маммографического скрининга.- Маммология 1997;(4): 25-31.
6. Eddy D.M., Yasselbled V., McGiveney W., Hendee W. The value of mammography screening in women under age 50 years. JAMA 1988; (11): 1512-9.
7. Hopper J.L., Chenevix-Trench G., Jolley D.J. et al. // J. Cancer Natl. Inst. — 1999. — N 26. — P. 95—100.
8. Kelsey J.L., Gammon M.D. // A cancer journal for clinicians. — 1991. — V. 41, N 3. — P. 146—165.

Скрининг рака шейки матки

Аубакирова А.Т.

Астраханская районная поликлиника (Акмолинская область)

Рак шейки матки занимает второе место по распространенности среди онкологических заболеваний в мире и первое место среди причин женской смертности от рака в развивающихся странах. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) в мире ежегодно регистрируется около 500 тысяч случаев рака шейки матки, каждый второй из которых заканчивается смертью пациентки в течение первого года после постановки диагноза. РШМ имеет тенденцию к омоложению, также выросла заболеваемость у женщин репродуктивного возраста.

Основным этиологическим фактором РШМ является вирус папилломы человека (ВПЧ) — вирус, способный поражать клетки эпителия эктодермального происхождения (кожа, слизистые половых органов, ротовой полости). По определению ВОЗ скринингом является идентификация невыявленного заболевания с помощью быстрых и массовых тест-исследований. Широкое внедрение скрининговых программ во многих развитых странах позволило значительно снизить заболеваемость и смертность от РШМ за счет своевременного выявления предопухолевых состояний шейки матки. Цитологический скрининг особенно эффективен при ранней диагностике РШМ, так как позволяет обнаружить злокачественное поражение на клеточном уровне.

Согласно приказу №196 от 01.04.2011г. «О проведении медицинских осмотров целевых групп населения» в Казахстане разработан организованный скрининг на государственном уровне для раннего выявления предраковых заболеваний РШМ. Скрининговый тест должен быть простым, неинвазивным, чувствительным и специфичным, безопасным и доступным. Таковым является выбранный метод — взятие мазка на цитологию по Папаниколау, так как цитология как метод позволяет обнаружить предраковые изменения за 3-5 лет до развития РШМ. При условии внедрения скрининга на постоянной основе прерывается патогенетическая последовательность предрак-рак, что в последствии приводит к снижению показателей заболеваемости и смертности от РШМ.

Согласно приказу №196 от 01.04.2011г. «О проведении медицинских осмотров целевых групп населения» Астраханская районная поликлиника Акмолинской области проводит скрининговое обследование рака шейки матки. В Астраханском районе Акмолинской области население составляет 26 388 человек, из них женщин - 13 966, женщин фертильного возраста - 7 936 человек. Заболеваемость онкопатологией за 6 месяцев 2011 года составляет 72,1% (областной показатель — 104,3%), смертность — 60,7% (областной показатель — 66,2%), болезненность 782 (областной показатель — 976).

По Астраханскому району в течение 2011 года подлежит обследованию на РШМ 1225 женщин.

Диагностическая точность цитологического исследования материала шейки матки во многом определяется качеством полученного материала. Материал является адекватным для исследования, если в мазках имеются клетки плоского эндцервикального эпителия с небольшим количеством элементов крови, т. е. материал должен быть получен их участка, где наиболее часто возникает опухоль. Отсутствие эндоцервикального и плоского эпителия, большое количество крови говорит о том, что материал является недостаточно адекватным. Неадекватный материал представлен мазками со скудным числом клеток, по

Статья посвящена проведению скрининга рака шейки матки в Астраханском районе Акмолинской области методом цитологии по Папаниколау. Скрининг требует дальнейшего обследования женщин в течение последующих лет и проведение анализа полученных результатов для снижения смертности от рака шейки матки.

Мақала Ақмола облысы Астрахан ауданында жатыр мойыншығы обыры скринингін Папаниколау бойынша цитология әдісімен өткізуге арналған. Жатыр мойыншығы обырынан болатын өлім-жітімді азайту үшін скрининг алдағы жылдар аралығында әйелдерді зерттеуді және алынған нәтижелерді талдауды қажет етеді.

This article devoted to cervical cancer screening in the Astrakhan region of Ak-mola by cytology method of Papanicolaou. Screening requires further examination of women in subsequent years and carrying out an analysis of the results for reduction in mortality from cervical cancer.

Результаты цитологического обследования

	Целевые группы (возраст)							
	30	35	40	45	50	55	60	Всего
Количество подлежащих обследованию	153	169	183	185	205	199	131	1225
Количество обследованных	152	167	183	180	201	198	130	1211
Недостаточно адекватный материал	4	2	3	4	2	4	2	21
Неадекватный материал	2	1	2	2	1	1	2	11
Адекватный материал	146	164	178	174	198	193	126	1179

которым невозможно оценить цитологическую картину.

Из таблицы видно, что обследовано 98,8%, из них 97,3% мазков были адекватные, 0,9% - неадекватные, 1,7% - недостаточно адекватные. Одним из главных причин неадекватности мазков является неправильный забор материала.

Выявленные заболевания

	Целевые группы (возраст)							
	30	35	40	45	50	55	60	Всего
Количество обследованных	152	167	183	180	201	198	130	1211
Норма	101	85	117	116	139	126	73	757
Легкая дисплазия	0	1	0	1	0	1	1	4
Умеренная дисплазия	0	0	0	0	1	0	0	1
Тяжелая дисплазия	0	0	1	0	1	0	1	3
Carcinoma in situ	0	0	0	0	0	0	0	0
Рак	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие заболевания	51	81	65	63	61	71	55	447

При анализе результатов обследования используется международная цитологическая классификация, разработанная в 1988 г. (США) — TBS, с изменениями, внесенными в 1991, 2001 гг., в которой выделяют плоскоклеточные поражения низкой и высокой степени и инвазивный рак, включая CIN I, CIN II, CIN III, carcinoma in situ.

Из обследованных женщин у 757 из них не выявлена патология, что составляет 62,5%, у 4 женщин — легкая дисплазия, у одной женщины — умеренная дисплазия, у трех женщин — тяжелая дисплазия, что означает, что риск возникновения РШМ у них значительно выше чем у остальных. Переход выраженной дисплазии эпителия в carcinoma in situ длится 3-8 лет, еще 10-15 лет проходит до развития микроинвазивного рака.

В приведенных исследованиях другие заболевания шейки матки диагностированы в 447 случаях (36,9%) и представлены гиперкератозом эпителия, атипической

железистой гиперплазией эндоцервикального эпителия, возрастным кольпитом. Результаты скринингового обследования женщин от 30 лет через каждые пять лет, дают возможность сформировать группы риска, позволяющие расширить эффективность ранней диагностики РШМ.

Литература

1. Приказ №196 01.04.2011г. «О проведении медицинских осмотров целевых групп населения»
2. Х.Абисатов: Клиническая онкология, г.Алматы, 2007 г.
3. Вопросы онкологии. Научно-практический журнал, 2004 г., том 50, № 4
4. М.Г.Абрамов: Клиническая цитология, 1974 г., М: Медицина
5. И.Б.Макухин: Проблемы и перспективы цервикального скрининга. Акушерство и гинекология. 2006 г. (приложение)

Перспективы скрининга рака пищевода и желудка в РК

Ахметжанов О.Т.

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Введение

Широкое распространение рака пищевода и желудка (РПИЖ) ставит его в ряд наиболее важных социальных проблем современности. Существует настоятельная необходимость в разработке методов, которые могли бы снизить заболеваемость и обеспечить раннее выявление заболевания и значительно повысить эффективность лечения. Надежды сократить число смертей от рака пищевода и желудка основаны на двух тактиках: ранней диагностике и эффективном лечении болезни в ее начальной стадии.

Заболеваемости раком желудка в мире максимальная – 114,7 на 100 тыс. населения (отмечен у мужчин Японии), минимальная – 3,1 на 100 тыс. населения (у белых женщин США). В мире ежегодно погибает до 800.000 человек. В Казахстане заболеваемость раком желудка за 2010 год – 16,3 на 100 тыс. населения. Смертность от рака желудка в Казахстане за 2010 год составила 13,3 на 100 тыс. населения (2167 человек по Республике) [1]. В течение последних 50 лет заболеваемость и смертность от рака желудка снизилась во всем мире, особенно в экономически развитых странах. Причиной тому улучшение социально-экономических условий и увеличение употребления в пищу свежих фруктов, витаминов и овощей, также на уменьшение заболеваемости и смертности от рака желудка повлияло улучшение эффективности диагностики и лечения. Наиболее впечатляющие успехи в улучшении выживаемости больных в Японии и Корее, где более 40% опухолей выявляются на ранних этапах благодаря широкому внедрению скрининговых программ.

Особенностью мировой структуры заболеваемости раком пищевода является то, что ни у одной другой опухоли нет такой большой географической зависимости. При сравнении разных стран цифры могут отличаться до 100 раз. Самый высокий показатель заболеваемости раком пищевода в Китае, Иране, государствах Центральной и Средней Азии – там ежегодно заболевает около 100 человек на 100 тысяч населения. В регионах с наиболее низким уровнем (Армения, Мали, Израиль, Вьетнам) этот показатель ниже почти в 100 раз и составляет примерно 1,7-2,2 случая на 100 тысяч населения в год. В мире ежегодно погибает около 800.000 человек. В Казахстане заболеваемость раком пищевода за 2010 год – 8,1 на 100 тыс. населения. Смертность от рака пищевода в Казахстане за 2010 год составила 6,5 на 100 тыс. населения (1062 человек по Республике) [1]. Рак пищевода – заболевание, отличающееся высокой смертностью. Около 70 процентов больных умирают в течение 1 года после постановки диагноза. Уровень смертности лишь немного меньше уровня заболеваемости. Эти грустные цифры связаны в первую очередь с тем, что в 70 – 80 процентах рак пищевода выявляется уже на поздних стадиях развития, когда надеяться на успешный исход лечения и длительную жизнь пациента уже очень сложно.

Международный опыт проведения скрининговых исследований

Мультицентровых доказательств эффективности скрининга

В последние годы отмечается рост интереса к разработке и проведению широкомасштабных скрининг-программ, направленных на раннюю диагностику рака желудка. Ее целью является снижение заболеваемости путем выявления предраковых заболеваний и их лечения, а также снижение смертности через повышение ранней диагностики и улучшения результатов лечения. В данной статье представлено обоснование программы ранней диагностики рака пищевода и желудка, ее характеристика, а также ожидаемые результаты.

рака желудка нет. Страны, где проводится скрининг рака желудка, являются Япония и Корея.

Японские ученые высоко оценивают эффективность национальной скрининговой программы, в которой принимают участие многие миллионы японцев. Например, в 1997 году обследованию подверглись более 11 миллионов человек старше 50 лет, однако эта колоссальная цифра составила лишь 9% населения в этой возрастной группе.

В Японии увеличилась доля ранних форм рака (более 50%), выросла 5-летняя выживаемость с 20% до 40%, в то время как в других развитых странах этот показатель остается ниже 20% в течение последних 2-3 десятилетий.

Показатель 5-летней выживаемости у больных раком желудка, выявленным при скрининге, достиг почти 100%.

Скрининг, скорее всего, объясняет снижение смертности (но не заболеваемости) от рака желудка. По данным японских авторов, чувствительность и специфичность метода фото-флюорографии с двойным контрастированием составляют 89% и 92% соответственно. Однако необходимо заметить, что подобные результаты не удалось повторить ни одному западному исследователю, у которых доля ложно-отрицательных результатов при гастроскопии достигает 20%, а при фото-флюорографии – 40%. Так что успешный скрининг рака желудка остается сугубо японским феноменом.

Внедрение в 70-х годах прошлого века гастроскопии, значительно улучшившей диагностику РЖ и предраковых заболеваний, что кардинально изменило структуру заболеваемости и позволило понять этапность развития рака. Продолжительность этапов развития РЖ достаточно велика и составляет 10 - 25 лет, но при появлении дисплазии высокой степени риск развития рака повышается до 96% и здесь фактор времени приобретает совершенно иное значение, счет идет не на годы, а на месяцы, (дисплазия высокой степени может перейти в рак уже через 3 мес.). Поэтому при обнаружении дисплазии высокой степени повторную биопсию необходимо выполнять через 3 мес. и ставить вопрос об эндоскопической мукоэктоми. В то же время, несмотря на разработку новых методов диагностики и лечения РЖ, более 50% опухолей диагностируется в 3 - 4 стадии, а 5 летняя выживаемость в США и странах Западной Европы не превышает 5 - 15%. Единственной формой злокачественной опухоли желудка, дающей возможность добиться стопроцентного излечения, является ранний РЖ. Итак, очевидно, для того чтобы снизить смерт-

ность от РЖ, помимо разработки новых схем и подходов в лечении, необходимо выявление ранних форм заболевания. Учитывая бессимптомный характер течения раннего РЖ, единственным инструментом его выявления является скрининг здорового населения. Стратегия популяционного скрининга рака желудка (СРЖ) существует лишь в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, где заболеваемость превышает 40 на 100000 населения. Стратегия популяционного скрининга рака желудка (СРЖ) существует лишь в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, где заболеваемость превышает 40 на 100000 населения. Для изучения скрининга рака желудка создана специальная международная, мультидисциплинарная экспертная группа (APWGGS), включающая специалистов из 8 стран: Япония, Корея, Китай, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Тайвань, Таиланд. Целью данной группы является изучение эпидемиологии, скрининга и профилактики РЖ [30]. Хотя рандомизированные контролируемые исследования считаются наиболее достоверными, к сожалению, на данный момент не опубликовано результатов ни одного рандомизированного исследования, оценивающего СРЖ. Поэтому эффективность различных программ скрининга оценивается с помощью других эмпирических эпидемиологических исследований — проспективных (когортных) и ретроспективных (методом «случай - контроль»). На основании данных эпидемиологических исследований и данных APWGGS оптимальным возрастом начала скрининга рака желудка является 40 - 45 лет. Говоря о методах скрининга, необходимо отметить, что на сегодняшний день активно используются либо проходят апробацию следующие инструменты СРЖ:

1. Фотофлюорография с двойным контрастированием;
2. Эндоскопия;
3. Определение сывороточного пепсиногена 1.

Фотофлюорография с двойным контрастированием

В Японии — стране с самой высокой в мире заболеваемостью РЖ 114,7 на 100 тыс. населения — удалось добиться 50% 5-летней выживаемости, причем за счет выявления и успешного лечения раннего РЖ [24]. В этой стране с 1983 г. существует государственная программа СРЖ, что дало возможность добиться столь впечатляющих результатов. В 1960 г. в префектуре Миагаги был начат скрининг рака желудка с помощью ежегодной фотофлюорографии с двойным контрастированием (барий и воздух) [27]. Методика исследования заключается в следующем: начальное («непрямое исследование») состоит из 8 мелкокадровых рентгенограмм желудка методом двойного контрастирования; при выявлении каких-либо изменений выполняется более детальное обследование («прямое исследование»), состоящее из 11 последовательных рентгенограмм, при выявлении подозрительных на рак участков слизистой оболочки выполняется гастроскопия с биопсией. В 1983 г. данный метод был полностью интегрирован в национальную систему здравоохранения. Популяция, включенная в программу, состояла из лиц старше 40 лет. К 2004 году 4,4 миллиона жителей участвовало в скрининге, что составило 13% от всех жителей старше 40 лет. В результате с 1980 и по 2004 г. смертность удалось снизить почти в 2 раза — с 69,9 до 34,4 на 100000 населения. Число выявленных случаев РЖ составило 6248, причем у 66,7% больных были диагностированы ранние формы заболевания. Чувствительность и специфичность метода фотофлюорографии с двойным контрастированием составила 89% и 92% соответственно [13, 17, 23]. На сегодняшний день опубликовано 4 когортных и 5 ретроспективных (методом «случай-контроль») исследования фотофлюорографиче-

ского СРЖ [5]. Большинство работ продемонстрировало снижение смертности от РЖ на 40-60%. Tsubono с соавторами (1999) провел метаанализ выше перечисленных исследований и подтвердил снижение смертности от РЖ в группе скрининга на 49% [26]. Чувствительность колебалась в пределах 60-80%, специфичность 80-90% (табл. 1) [5]. Хотя выживаемость не является критерием скрининга, в проведенном метаанализе 5-летний показатель у больных, выявленных в результате скрининга, составила 74-80%, а у выявленных в результате обращаемости — 45 - 56%, что говорит об эффективности скрининга в выявлении ранних форм РЖ. Согласно данным Японской группы по изучению скрининга РЖ фотофлюорография остается единственным рекомендуемым методом популяционного СРЖ [5]. Несмотря на столь впечатляющие результаты, в Европе и США массовый скрининг РЖ не проводится. Причина тому, прежде всего, низкая заболеваемость и высокая стоимость подобных исследований. Чаще используются индивидуальные программы и программы скрининга групп риска. В России, на базе МОНИКИ, в течение 20 лет проводился рентгенологический скрининг РЖ в специально отобранной группе риска. За это время обследовано 45000 пациентов, выявлено 880 (1,96%) случаев РЖ, из них у 180 (20,1%) больных заболевание диагностировано на ранних стадиях [2, 21]. При анализе данной работы бросается в глаза высокая выявляемость РЖ — 1,96%, по сравнению с популяционным скринингом, проводимым в Японии, где данный показатель не превышает 0,2%. Однако доля ранних раков почти в 3 раза меньше в программе скрининга группы риска (20,1% по сравнению с 66,7% при популяционном скрининге), поэтому здесь вряд ли можно будет говорить о кардинальном снижении смертности и влиянии скрининга на естественную историю развития РЖ.

Эндоскопия

Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) является единственным методом, дающим возможность подтвердить или опровергнуть наличие РЖ у пациента. С помощью хромогастроскопии (рис. 3) с высоким разрешением удается выявить ранние формы заболевания и путем мукоэктомии добиться полного излечения, т. е. прекратить естественную историю развития столь агрессивного рака. В Японии хромогастроскопия с высоким разрешением является стандартом при индивидуальном скрининге населения. Работы по внедрению ЭФГДС для скрининга РЖ ведутся как в Японии, так и в Корее. С 1999 г. Министерством здравоохранения Республики Корея начат эндоскопический скрининг РЖ. В программу включено население старше 40 лет. Интервал обследования составляет 2 года [33]. Исследования, проводимые в Корее и Японии, демонстрируют высокую эффективность данного метода в выявлении ранних раков. Tashiro A. с соавторами (2006) провел сравнительный анализ эффективности различных методов скрининга для выявления раннего рака, а также сравнил экономические затраты на рентгенологический и эндоскопический методы скрининга [25]. При ЭФГДС ранний РЖ был выявлен в 0,87% случаев, что превышало в 2,7 раза количество выявленных ранних форм при флюорографии (табл. 2). Затраты на выявление одного больного были в разы ниже при эндоскопическом скрининге, по сравнению с рентгенологическим. Однако камнем преткновения адаптации ЭФГДС для всей популяции являются сложность исследования, требующая высокой квалификации врачей-эндоскопистов. Даже в Японии, где выявляемость раннего РЖ лучшая в мире, уровень «пропущенных» случаев оценивается в 19% [9].

Несмотря на все преимущества гастроскопии в качестве инструмента скрининга, нет ни одной публикации, демонстрирующей снижение смертности в исследуемой

популяции, а также не ясны чувствительность и специфичность ЭФГДС при скрининге РЖ. Единственное когортное исследование, посвященное эндоскопическому СРЖ, проводилось в Китае в провинции Линку. С 1989 по 1999 гг. эзофагогастродуоденоскопия выполнялась 4394 жителям провинции. Заболеваемость и смертность прослежена до 2000 г. За этот период выявлено 85 (1,9%) случаев РЖ, из них у 29 (34,1%) исследованных выявлены ранние формы. В то же время снижения риска смертности у когорты, подвергшейся скринингу, отмечено не было [22]. Чувствительность гастроскопии на уровне 77,84% продемонстрирована всего лишь в двух исследованиях, без оценки специфичности метода [9, 19]. Таким образом, объективно высказаться об эффективности и целесообразности эндоскопического скрининга рака желудка не представляется возможным. Актуальным является использование хромогастроскопии в программах индивидуального скрининга, а также в качестве скринингового инструмента в заранее определенных группах риска развития РЖ. Решающим фактором для отбора соответствующих групп пациентов может быть не-эндоскопическая скрининговая диагностика атрофического гастрита.

Таблица - Стоимость и выявляемость РЖ при гастроскопии и флюорографии [25]

	Вид исследования	Годы		
		2002	2003	2004
Исследуемые	Флюорография	28332	20058	1901
	Гастроскопия	-	8118	11679
Частота выявления(%)	Флюорография	0,33	0,31	0,32
	Гастроскопия	-	0,81	0,87
Частота выявления раннего РЖ(%)	Флюорография	40,8	56,5	63,9
	Гастроскопия	-	74,2	75,5
Стоимость (Йены)	Флюорография	5113000	4365000	4177000
	Гастроскопия	-	1683000	1608000

Определение сывороточного Пепсиногена 1

Учитывая патогенетическую связь атрофического гастрита и РЖ, логичным является скрининг с использованием биохимических маркеров атрофического гастрита. В связи с этим, за последние 20 лет была проведена большая работа по разработке таких биомаркеров. В настоящее время установлена высокая корреляция гистологически подтвержденного атрофического гастрита с уровнем Пепсиногена 1 (ПГ1) в сыворотке крови и соотношением между концентрацией ПГ1 и ПГ2. Чувствительность и специфичность этого метода в выявлении атрофического гастрита составляет 93% и 88% соответственно [15, 16]. С 1990 года в Японии сывороточный ПГ как маркер атрофического гастрита в тестовом режиме включен в программы СРЖ [12]. Результаты показали высокую эффективность этого теста в выявлении раннего рака. При исследовании 4876 здоровых лиц у 911 установлены серологические признаки атрофического гастрита, после ЭФГДС рак подтвержден у 18 исследованных.

Совокупная частота обнаружения РЖ составила 2,76% [8,15]. На основании обследования популяции в 300000 человек уровень чувствительности и специфичности в выявлении РЖ составил 77 и 74% соответственно (при ПГ1 менее 70 мкг/л, отношение ПГ1/ПГ2 менее 3), что для непрямого метода диагностики является очень хорошим показателем [11]. Однако необходимо отметить, что данный подход приемлем только для дистальных РЖ, возникающих на фоне атрофического гастрита. При кардиоэзофагеальном раке атрофический гастрит не является обязательным атрибутом и, соответственно, эффективность скрининга

методом определения сывороточного ПГ1 будет очень низкой.

Цель исследования

- разработка и внедрение в клиническую практику программ ранней диагностики РПЖ.

За последние годы затраты на лечение РПЖ только возросли. Поэтому является не только важной медицинской, но большой социальной и экономической задачей государственного значения. В соответствии с Государственной программой развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011 – 2015 годы, утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 29 ноября 2010 года № 1113 «усиление профилактических мероприятий, скрининговых исследований, совершенствование диагностики, лечения и реабилитации основных социально-значимых заболеваний». а также учитывая общую ситуацию по выявляемости рака предстательной железы в РК (тенденция к росту заболеваемости, высокая запущенность, низкие показатели 5-летней выживаемости) необходимо начать подготовку к проведению программы по ранней диагностике (скрининга) рака пищевода и желудка в нашей республике.

Материалы и методы исследования

- Вид скрининга: Непопуляционный скрининг
- Метод скрининга: ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ.
- Интервал: 1 раз в 2 года
- Срок действия: постоянно

Целевой группой являются мужчины и женщины в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 50 лет.

Данная целевая группа формируется на уровне ЦРБ - районным онкологом в согласовании с участковым эндоскопистом, средним медицинским персоналом на уровне СВА и МП.

Методы исследования:

- всем мужчинам и женщинам целевой группы проводят ФЭГДС, по результатам которой эндоскопист выставляет соответствующий код при эндоскопическом исследовании желудка:

- 1 – без патологии (EG1);
- 2 – атрофический и гиперпластический гастрит (EG 2);
- 3 – хронические язвы желудка (EG 3);
- 4 – полипы желудка (EG 4);
- 5 – подслизистые образования желудка (EG 5);
- 6 – сомнительные случаи без морфологической верификации (EG 6);
- 7 – ранний рак желудка (до 2 см) (EG 7);
- 8 – рак желудка, верифицированный патоморфологически (EG 8) (более 2 см).

Далее в зависимости от выставленного кода предпринимаются действия:

Выводы

Были сделаны важные выводы, имеющие и клиническое и экономическое значение:

Скрининг РПЖ снижает смертность от социально-значимого заболевания

Скрининг РПЖ экономически эффективен, несмотря на затраты;

Скрининг РПЖ и выявление заболевания на ранних стадиях экономически эффективнее лечения РПЖ на поздних стадиях;

Лечение РПЖ, эффективное с позиций медицины, приводящее к сохранению жизни и восстановлению работоспособности, экономически целесообразно.

Код при эндоскопии	Действия
EG1	фэгдс один раз в два года
EG 2, EG 3, EG 4	определение Нр доступными методами, проведение эрадикации Нр; фэгдс 2 раза в год со взятием биопсии, направление в онкодиспансер для удаления полипа (эндоскопическое или хирургическое)
EG 5	До 2 см – биопсия, наблюдение в динамике Более 2 см и рост в динамике – биопсия, направление на хирургическое лечение в онкологический диспансер
EG 6	Направляются в онкологический диспансер для уточняющей диагностики
EG 7	Направляются в онкологический диспансер, где решается вопрос о направлении в КазНИИОиР для эндоскопической резекции с.о.
EG 8	Направляются в онкологический диспансер, где решается вопрос о лечении данного заболевания.

Преимущества скрининга РПЖ для РК

Снижение смертности от рака пищевода и желудка.

Совершенствование подготовки медицинских кадров, развитие медицинской науки

Повышение онконастороженности, доступности, качества, преемственности медицинской помощи на уровне ПМСП

Усиление межсекторального и межведомственного взаимодействия по вопросам охраны здоровья граждан

Преимущества скрининга РПЖ для медицинских организаций

Улучшение материально-технической базы организаций здравоохранения

Выявление ранних стадий РПЖ, снижение уровня выявляемых поздних стадий.

Выявление и учет прочих заболеваний пищевода и желудка

Преимущества скрининга РПЖ для пациентов

Если опухоль будет обнаружена на ранней стадии и лечение будет успешным, есть вероятность того, что удастся избежать развития метастазов опухоли

Ожидаемые результаты скрининга РПЖ

Достоверного изменения структуры заболеваемости следует ожидать не ранее, чем через 5 лет планомерного осуществления программы.

Реального уменьшения смертности от РПЖ можно добиться не менее чем через 10 лет планомерного скрининга.

Рост уровня 5-летней выживаемости

В первые годы скрининга увеличение числа пациентов с РПЖ и, соответственно, возрастают затраты на их лечение. В последующем в основном выявляются локализованные формы. Доля локализованных форм РПЖ увеличится до 60-80% и выше, а суммарные затраты на лечение последовательно снизятся.

При повторных скринингах – тенденция к смещению более благоприятных стадий заболевания и морфологических степеней злокачественности

Уменьшение частоты осложнений и инвалидности от РПЖ

Список использованной литературы

1. Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Ж. и соавт. Показатели онкологической службы Республики Казахстан, статистические материалы. 2010гг.

2. Портной Л.М., Статник Г.А. Нужна ли современная диагностика рака желудка? // Медицинская визуализация. – 2001. – №3. – С. 23-34
3. Allum W.H., Powell D.J., McConkey C.C. et al. Gastric cancer: a 25 year review // Brit. J. Surg. – 1989. – Vol.76. – P.535-540.
4. Blot W.J., Devesa S.S., Kneller R.W., Fraumeni J.F. Rising incidence of adenocarcinoma of the esophagus and gastric cardia // JAMA. – 1999. – Vol.265. – P.1287.
5. Chisato H., Daisuke S. The Japanese Guidelines for Gastric Cancer Screening // Jpn. J. Clin. Oncol. – 2008. – Vol.38(4). – P.259-267.
6. Choi M.G., Lee J.H., Park K.J., Yang H.K., Park J.G., Lee K.U. et al. Chronological changes of clinicopathologic features in gastric cancer // J. Korean. Surg. Soc. – 1999. – Vol.57. – P.514-522.
7. Crew K.D., Neugut A.I. Epidemiology of gastric cancer // World J. Gastroenterol. – 2006. – Vol.12. – P.354-362.
8. Hattori Y., Tashiro H., Kawamoto T. et al. Sensitivity and specificity of mass screening for gastric cancer using the measurement of serum pepsinogens // Jpn. J. Cancer Res. – 1995. – Vol.86. – P.1210-1215.
9. Hosokawa O., Hattori M., Takeda T., Watanabe K., Fujita M. Accuracy of endoscopy in detecting gastric cancer // J. Gastroenterol. Mass. Surv. – 2004. – Vol.42. – P.33-39 (in Japanese).
10. Jemal A., Siegel R., Ward E., Murray T., Xu J., Thun M.J. Cancer statistics, 2007 // CA Cancer J. Clin. – 2007. – Vol.57. – P.43-66.
11. Kitahara F., Kobayashi K., Sato T. et al. Accuracy of screening for gastric cancer using serum pepsinogen concentrations // Gut. – 1999. – Vol.44. – P.693-697.
12. Kodoi A., Yoshihara M., Sumi K. et al. Serum pepsinogen in screening for gastric cancer // J. Gastroenterol. – 1995. – Vol.30. – P.452-460.
13. Kunisaki C., Ishino J., Nakajima S. et al. Outcomes of mass screening for gastric carcinoma // Ann. Surg. Oncol. – 2006. – Vol.13. – P.221-228.
14. Martin S. Karpeh, David P. Kelsen, Joel E. Tepper. Cancer of the Stomach: Principles and Practice of Oncology, 7th Edition Published by Lippincott Williams & Wilkins, Copyright. – 2005.
15. Miki K. Gastric cancer screening using the serum pepsinogen test method // Gastric Cancer. – 2006. – Vol.9. – P.245-253.
16. Mukoubayashi C., Yanaoka K., Ohata H. et al. Serum pepsinogen and gastric cancer screening // Intern. Med. – 2007. – Vol.46. – P.261-266.
17. Murakami R., Tsukuma H., Ubukata T., Nakanishi K., Fujimoto I., Kawashima T. et al. Estimation of validity of mass screening program for gastric cancer in Osaka, Japan // Cancer. – 1990. – Vol.65. – P.1255-1260.
18. Oishi Y., Kiyohara Y., Kubo M. et al. The serum pepsinogen test as a predictor of gastric cancer // Amer. J. Epidemiol. – 2006. – Vol.163. – P.629-637.
19. Otsuji M., Kouno Y., Otsuji A., Tokushige J., Shimotata K., Arimura K. et al. Assessment of small diameter panendoscopy for diagnosis of gastric cancer: comparative study with follow-up survey data // Stomach and Intestine. – 1989. – Vol.24. – P.1291-1297.
20. Parsonnet J., Friedman G.D., Vandersteen D.P. et al. Helicobacter pylori infection and the risk of gastric carcinoma // N. Engl. J. Med. – 1991. – Vol.325. – P.1127.
21. Portnoi L.M., Kazantseva I.A., Isakov V.A. et al. Gastric cancer screening in selected population of Moscow region: retrospective evaluation // Europ. Radiol. – 1999. – Vol. 9, №4. – P.701-705.
22. Riecken B., Pfeiffer R., Ma J.L., Jin M.L., Li J.Y., Liu W.D. et al. No impact of repeated endoscopic screens on gastric cancer mortality in a prospectively followed Chinese population at high risk // Prev. Med. – 2002. – Vol.34. – P.22-28.
23. Statistics and Information Department, Ministry of Health, Labour and Welfare // Report on the health services for the elderly. – 2002.
24. Tajima K., Kuroishi T., Oshima A., eds. Cancer mortality and morbidity statistics: Japan and the world 2004. Tokyo: Japan Scientific Societies Press, 2004. Japanese cancer association Gann monograph on cancer research no.
25. Tashiro A., Sano M., Kinameri K., Fujita K., Takeuchi Y. Comparing mass screening techniques for gastric cancer in Japan // World J. Gastroenterol. – 2006. – Vol.12(30). – P.4873-4874.
26. Tsubono Y., Hisamichi S. Case-control studies of screening for gastric cancer in Japan // J. Gastroenterol. Mass. Surv. – 1999. – Vol.37. – P.182-185.
27. Tsubono Y., Hisamichi S. Screening for gastric cancer in Japan // Gastric. Cancer. – 2000. – Vol.3. – P.9-18.
28. Tsukuma H., Oshima A., Nakahara H., Morii T. Natural history of early gastric cancer: a non-concurrent, long term, follow up study //

Gut. – 2000. – Vol.47. – P.618-621.

29. Uemura N., Okamoto S., Yamamoto S. et al. *Helicobacter pylori* infection and the development of gastric cancer // *N. Engl. J. Med.* – 2001. – Vol.345. – P.784-789.

30. Wai K. Leung, Ming_shiang Wu, Yasuo Kakugawa. Screening for gastric cancer in Asia: current evidence and practice // *Lancet. Oncol.* – 2008. – Vol.9. – P.279-287.

31. Watabe H., Mitsushima T., Yamaji Y., Okamoto M., Wada R., Kokubo T. et al. Predicting the development of gastric cancer from

combining *Helicobacter pylori* antibodies and serum pepsinogen status: a prospective endoscopic cohort study // *Gut.* – 2005. – Vol.54. – P.764-768.

32. Yamagata H., Kiyohara Y., Aoyagi K. et al. Impact of *Helicobacter pylori* infection on gastric cancer incidence in a general Japanese population // *Arch. Intern. Med.* – 2000. – Vol.162-1968.

33. Young Min Kwon, Hyung Taek. Lim Factors associated with use of gastric cancer screening services in KoreaWorld // *J. Gastroenterol.* – 2009, August 7. – Vol.15(29) . – P.3653-3659.

Цитологический скрининг в Семейском регионе

Байтеисов Д.М., Бекетова Б. Б., Бань Т. П., Манамбаева З. А., Сулейменова А. Т., Жабалин К.Т.,
Муслимова З.Р.

Региональный онкологический диспансер г. Семей.
Государственный медицинский университет г.Семей

О необходимости мер, направленных на снижение заболеваемости раком шейки матки, свидетельствует тот факт, что рак этой локализации занимает восьмое место по частоте среди раковых заболеваний женщин в западных странах и второе место среди таких болезней в мире. Хотя смертность от него в целом снижается, среди женщин в возрасте от 30 до 40 лет наблюдается ее увеличение. Внедрение цитологического метода скрининга (ПАП-теста) в США, Европе, Австралии за последние 40–50 лет позволило снизить заболеваемость РШМ на 80–90%. Цитологический скрининг признан классическим методом и рекомендован ВОЗ для проведения в масштабах национальных программ. Чувствительность цитологического метода исследования, по данным разных авторов, составляет 66–83%, специфичность – 60–85%. Подсчитано, что скрининг женщин в возрасте 25–64 лет с интервалом в 5 лет может привести к снижению смертности от РШМ на 84%. Информативность цитологического метода определяется уровнем подготовки специалистов, а также качеством забора материала для цитологического исследования, так как неправильный забор материала повышает частоту ложноотрицательных результатов. Полноценное взятие мазка с использованием специальных инструментов (цитобраши, цервикс-браши) позволило значительно повысить информативность цитологического метода.

В Казахстане в структуре онкологической заболеваемости у женщин рак шейки матки находится на 3 месте и составляет 8,1 на 100000 населения, ежедневно от этой патологии в республике погибает 2 женщины. Метод цитологического скрининга позволяет выявить предраковые изменения шейки матки, которые при отсутствии своевременного лечения могут привести к развитию злокачественного заболевания шейки матки.

Цель исследования

- изучить эффективность цитологического скрининга в Семейском регионе за 4 года.

Материалы и методы исследования

Всего в 2008 году по Семейскому региону скринингом было охвачено 22630 (98,4 %) женщин, 2009 году – 18311 (98 %), 2010 году – 17852 (92,7 %). Из всего количества женщин, охваченных цитологическим скринингом, злокачественных процессов выявлено в 2008 году – 16 (0,07 %), 2009 – 29 (0,15 %), 2010 – 18 (0,1 %) - по сравнению с 2006 и 2007 гг. – по 0,01 %. Возрастные группы определены приказом МЗ РК от 16.03.2011 № 145 «О внесении изменений в приказ и.о. Министра Здравоохранения РК от 10.11.2009 г № 685 «Об утверждении правил проведения профилактических медицинских осмотров целевых групп населения»: 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 лет.

Результаты исследования

При анализе заболеваемости РШМ в РОД г. Семей с 2004 г по 2010 г (активно проводится скрининг) наблюдается рост заболеваемости с 8,9 в 2004 г до 11,2 в 2010 г. Это

Был проведен анализ клинической эффективности проводимого цитологического скрининга в регионе г.Семей Восточно-казахстанской области. Внедрение новых скрининговых технологий открывает новые возможности для диагностики опухоли на ранней стадии и эффективного лечения рака шейки матки.

Шығыс - Қазақстан облыстың Семей қаласының өлкедегі өткізілетін цитологиялық скринингтің клиникалық тиімділігінің талдауы жүргізілді. Жаңа скрининг технологияларының енгізуі жатырдың шейктері кезең және шаянның тиімді емдеуі ісінң диагностика үшін ерте жаңа мүмкіншіліктің көзін табады.

– закономерный процесс начала любой скрининговой программы, чем качественней проводится скрининг, тем больше выявляется патологии.

Выявление заболевания в преклинической стадии дает возможность излечить больных «сберегающими хирургическими методами», сократить сроки лечения, снизить случаи инвалидизации и смертности, т.е. дает определенный экономический эффект.

Так, в РОД г. Семей в настоящий период наблюдается постепенное увеличение удельного веса пациентов раком шейки матки I-II стадий с 69,1 % в 2004 г. до 73,9 % в 2010 г. из них количество больных, подвергшихся радикальной операции составляет 67 %. Необходимо отметить факт увеличения процента выполнения органосохраняющего объема оперативного вмешательства у категории больных, которые были взяты на учет по результатам выполнения программы цитологического скрининга рака шейки матки, что является безусловным, поскольку увеличивается процент больных с ранними стадиями патологического новообразования.

Полученные данные и опыт проведения скрининга показывают, что качество мазков и правильность цитологического диагноза имеют большее значение для снижения заболевания раком шейки матки, по сравнению с увеличением частоты численности скрининга или началом скрининга в более раннем возрасте.

Программа цитологического скрининга, имеющая общегосударственное значение и большую социальную значимость, является долгосрочным проектом. Правильная реализация программы является действенным средством контроля над РШМ, способствует снижению заболеваемости и смертности от РШМ и поддержанию этих показателей на низком уровне.

Вывод

Таким образом, внедрение новых скрининговых технологий открывает новые возможности для диагностики опухоли на ранней стадии и эффективного лечения рака шейки матки, что является основой для снижения заболеваний в целом и открывает новые перспективы в сохранении здоровья женщин.

Результаты цитологического скрининга рака шейки матки 2006-2010 гг. по Семейскому региону

Бань Т.П., Шалаганова К.Б., Кыдырбаева Ж.Н., Суртаева Ж.Д., Карипова М.К.

Региональный онкологический диспансер г. Семей

Проведен анализ результатов цитологического скрининга рака шейки матки 2006-2010 гг. по Семейскому региону. Работа показала рост выявляемости рака по скринингу в 15 раз 0,01%-2007 г., 0,07%-2008 г., 0,15%-2009 г., 0,1%-2010 г. Этому способствовало проведение обучающих семинаров, тренингов для гинекологов и акушеров и позволило получить более качественный материал. Все ранние раки были выявлены по методу Папаниколау. Метод Папаниколау имеет больше преимуществ при проведении скрининга.

В мире накоплен большой опыт по проведению цитологического скрининга рака шейки матки (РШМ). Проведение организованного скрининга РШМ способствовало снижению заболеваемости и смертности от РШМ на 70-80%.

Цель исследования

- провести анализ эффективности диагностики поражений шейки матки у женщин во время скрининга 2006-2010гг.

Материал и методы исследования

В Казахстане цитологический скрининг рака шейки матки проводится с 2005 года.

2005 год: 20 – 34 года

2006 и 2007 гг.: 18 – 49 лет.

С 2008 года: 35, 40, 45, 50, 55, 60 лет.

Обследовано в 2006 г. - 145249 женщин, 2007 г. - 138684 женщин, 2008 г. - 22630 женщин, 2009 г. – 18311 женщин, 2010 г. – 17852 женщин. Материал для исследования получали из шейки матки при помощи Cervix-Brush. Метод окраски препаратов - по Романовскому в 2006, 2007 гг. В 2008 году - 60% всех исследований окрашены по методу Папаниколау и 40% по Романовскому. С 2009 года все скрининговые исследования 100% окрашиваются по методу Папаниколау (Пап-тест).

Обсуждение и результаты исследования

Установлено, что решающим фактором, влияющим на эффективность скрининга, является широта охвата скринингом женского населения. Для решения проблемы охвата скринингом женского населения проводили разъяснительную работу, привлечение средств массовой информации, издания популярных печатных материалов. Вторым не менее важным фактором эффективности проведения скрининга является адекватность мазка. Точность цитологического исследования определяется качеством полученного материала (клеточным составом мазка). Материал расценивался, как адекватный для исследования, если в мазке имелись клетки плоского, метаплазированного и эндоцервикального эпителия, т.е. материал должен быть получен из зоны трансформации (зона стыка плоского и цилиндрического эпителия, где наиболее часто возникает опухоль). Для получения адекватного материала мазки рекомендовались брать шеткой - браш. Самую «опасную» категорию женщин представляет именно «недостаточно адекватный материал» т.к. гинеколог не всегда посчитает нужным «перебрать» материал и при наличии невидимой визуальной патологии у такой женщины большая вероятность развития предрака (дисплазии), а затем и рака.

Семей өңірі бойынша 2006-2010 жылдарға жатыр мойны обырына цитологиялық скринингтің нәтижелеріне талдау жүргізілді. Жұмыс обырдың анықталу өсімінің скрининг бойынша 15 есе 0,01%-2007 ж., 0,07%-2008 ж., 0,15%-2009 ж., 0,1%-2010 ж. өскенін көрсетті. Бұған гинекологтар мен акушерлерге арналған оқыту семинарлары, тренингтердің өткізілуі ықпал етті және неғұрлым сапалы материал алуға септігін тигізді. Бұрынғы барлық обырлар Папаниколау әдісі бойынша анықталған болатын. Скрининг жүргізу барысында Папаниколау әдісінің артықшылығы көп.

Проведение обучающих семинаров, тренингов для гинекологов и акушеров позволило снизить количество неинформативных мазков (с 20.3% в 2007 году до 1,36% в 2010 году), а значит получить более качественный материал, следовательно, диагностировать больше ранней патологии шейки матки. Что касается злокачественных процессов, то наблюдается рост выявляемости рака по скринингу в 12,5 раз (0,01% в 2007г, 0,07% в 2008 г, 0,15% в 2009г, 0,1% в 2010г.)

	2007	2008	2009	2010
Ca in situ	2	6	4	5
микроинв	1	2	14	3
инвазивн	17	8	11	10
всего	20	16	29	18
% ранних раков	15	50	62	44

Все ранние раки были выявлены по методу Папаниколау, что еще раз подтверждает преимущество данной методики при проведении скрининговых программ. Очень важным фактором эффективности цитологического скрининга является адекватное обследование и лечение выявленных больных. Женщины с выявленной патологией (цитологические заключения даются по терминологии Бетесда) ASCUS (атипия неясного значения), LSIL (легкая степень дисплазии) наблюдались у участкового гинеколога по месту жительства с последующим цитоконтролем. Женщины с более серьезной выявленной патологией - умеренная, тяжелая степень дисплазии (HSIL), подозрение на злокачественный процесс направлялись в онкодиспансер для углубленного обследования (кольпоскопия, биопсия) и лечения. За 2010 год 50% впервые взятые на учет женщины по раку шейки матки были выявлены при профилактическом осмотре.

Выводы

Для эффективного проведения скрининга необходимо соблюдение трех основных факторов - широта охвата женского населения подлежащего исследованию, полноценность полученного цитологического материала, обследование и лечение выявленных больных. Метод окраски цитологических препаратов по Папаниколау показал себя как метод более эффективный при диагностике патологии шейки матки, имеет больше преимуществ при проведении скрининга.

Результаты маммографического скрининга по данным ГККП «Областной онкологический диспансер» г.Талдыкорган

Бектурсынов С.М., Голованев Г.А., Есимханова С.Н.
ГККП «Областной онкологический диспансер» г.Талдыкорган

Актуальность

Внедрение в практическое здравоохранение эффективной скрининговой диагностики рака молочной железы (РМЖ) - это один из возможных путей уменьшения результатов данной патологии. Эффективность его определяется снижением смертности и уменьшением общих затрат на лечение.

Цель работы

Изучить эффективность маммографического скрининга рака молочной железы (РМЖ) по данным ГККП «Областной онкологический диспансер» г.Талдыкорган (областной онкодиспансер).

Материал и методы

С 2008 года в областном онкодиспансере проводятся маммографические скрининговые обследования женщин в возрастной группе от 50 до 60 лет с интервалом 1 раз в 2 года. Данные обследования проводятся на основании Приказа № 605 Министерства Здравоохранения Республики Казахстан от 15.10.2007 г. Обследования осуществляются на маммографах «Alpha – ST», (Финляндия, 2006г.). Исследование менструирующих женщин выполняются с 5 по 12 день менструального цикла.

Маммографическому исследованию за 2008-2010 года были подвергнуты 43028 женщин (96,4%) из запланированных 44640 женщин. Патологии молочных желез не обнаружено у 25374 (54 %) женщин.

Патологические образования в ткани молочной железы выявлены у 17374 женщин (46%). У 10029 женщин (69,31%) эти образования имели диффузный характер, им требовалось дообследование и рекомендовано диспансерное наблюдение у маммолога. Для уточнения характера патологического процесса в дополнительном обследовании нуж-

Сүт безінің қатерлі ісігін алдын ала қамтау мақсатында Қазақстан Республика Денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығымен № 605 15.10.2007 ж. Алматы облысы бойынша 2007 жылдан бастап профилактикалық тексеру жүргізілуде.

Мақсаты-Маммографиялық скринингінің нәтижесін бақылау.

Материалдары және әдістері.Онкология орталығында 2008-2010 жылдары аралығында 50-60 жас аралығындағы 43028 азаматшалары тексерілді.Қатерлі ісіктің I-II сатысымен 53 азаматшадан анықталды.

дались 7305 женщин (37,24%). В областной онкодиспансер для дальнейшего обследования обратились 2529 женщин (34,6%). В результате при дополнительном исследовании диффузные изменения были отмечены у 1533 женщин (62%). Чаще всего они были представлены диффузной фиброзно – кистозной мастопатией. Узловые образования диагностированы у 459 женщин (30%), из них фиброаденома у 313 женщин, узловая мастопатия у 146 женщин.

Секторальная резекция молочной железы проведена 375 женщинам (81,7%), при которой данных, подтверждающих злокачественный процесс не получено.

Подозрение на рак молочной железы на основании маммографического исследования выявлено у 84 женщин (0,8%), из них у 53 (0,1%) женщин диагноз был подтвержден морфологически.

За 3 года в РК конечно же делать выводы еще рано, однако уже сейчас видно, что выявляемость ранних стадий РМЖ стала больше.

Таким образом, проведение маммографического скрининга, несомненно является неотъемлемым мероприятием в борьбе с раком молочной железы.

Алгоритм проведения маммографического скрининга

Жакенова Ж.К., Хамзин А.Х., Ткачева А.М.

Казахский НИИ Онкологии и Радиологии

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

Актуальность

Во всем мире рак молочной железы (РМЖ) – наиболее распространенное злокачественное заболевание и ведущая причина смертности среди женщин (Семиглазов В.Ф. и соавт., 2007, Benson J.R. et al., 2009). В Республике Казахстан РМЖ стабильно занимает первое место в структуре онкологической заболеваемости женщин, начиная с середины 90-х годов XX века (Сейтказина Г.Д., 2005), а с 2007г. вышел на второе место в общей структуре онкологических заболеваний населения Казахстана (Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Д. и соавт., 2008).

Маммография остается ведущим методом распознавания рака молочной железы, она не только позволяет выявлять самые ранние формы рака молочной железы, но также является информативным средством оценки местной распространенности опухоли и микрокальцинатов и дает возможность одновременно с диагностикой определять тактику лечения. Наряду с маммографией получила широкое распространение в маммологии и ультразвуковая диагностика (Weismann C.F. et al., 2007, Taplin S. et al., 2008). Внедрение и выдвижение новых правил проведения маммографического скрининга в РК требует объединения маммографии, УЗИ и трепанбиопсии молочных желез в руках одного специалиста – врача-рентгенолога, занимающегося маммографией и диктует необходимость использования единого алгоритма обследования молочных желез.

Материал и методы

Разработанный алгоритм проведения маммографического скрининга включает в себя проведение профилактического маммографического обследования женщин в возрасте 50, 52, 54, 56, 58, 60 лет в районных, городских поликлиниках области/города/региона с двойной интерпретацией и архивацией скрининговых маммограмм в областных/городских/региональных онкологических диспансерах.

Алгоритм

Маммограммы, сделанные в процессе скрининга женщинам в возрасте 50, 52, 54, 56, 58, 60 лет, из районных и городских поликлиник области/города/региона вместе с заполненной формой и результатом первой читки маммограмм поступают в областные/городские/региональные онкологические диспансеры, где проводится повторная интерпретация скрининговых маммограмм врачами-рентгенологами диспансера (вторая читка). Это значит, что каждая скрининговая маммограмма, сделанная в районных и городских поликлиниках области/города/региона, должна быть повторно сынтипретирована врачами-рентгенологами областного/городского/регионального диспансера по международной классификации BI-RADS. Если случай вызывает подозрение на злокачественный процесс по данным маммографии (М3 – больше данных за доброкачественный процесс, М4 – больше данных за злокачественный процесс, М5 – злокачественный процесс без патоморфологической верификации) у одного

Дан алгоритм проведения маммографического скрининга в РК с использованием «двойной читки» маммограмм и объединением маммографии, УЗИ и трепанбиопсии молочных желез в руках одного специалиста.

«Қос оқу» әдісін қолдану және маммография, УДЗ және сүт бездерінің трепанбиопсиясын біріктіріп, бір маман қолынан өткізу арқылы ҚР маммографиялық скринингтің өткізілу алгоритмы ұсынылған.

The algorithm mammography screening in Kazakhstan with additional “double reading» of screening mammograms and combination of mammography, ultrasonic and trepan-biopsy of breast tumors by one specialist is given.

из рентгенологов, то такой случай выносится на совместное обсуждение с другими рентгенологами диспансера, специалистами по заболеваниям молочных желез, для определения необходимости дальнейшего обследования. Если случай вызывает подозрение на злокачественный процесс по данным маммографии (М3 – больше данных за доброкачественный процесс, М4 – больше данных за злокачественный процесс, М5 – злокачественный процесс без патоморфологической верификации) у обоих врачей, то такая пациентка приглашается в диспансер на дальнейшее обследование – маммограммы прицельные и с увеличением, физикальный осмотр молочных желез, ультразвуковое исследование (УЗИ) молочных желез, пункция образования молочных желез под контролем УЗИ, стереотаксическая пункция микрокальцинатов. Все процедуры – интерпретация скрининговых маммограмм, по показаниям – прицельная маммография, физикальный осмотр молочных желез, УЗИ молочных желез, пункция под контролем УЗИ, стереотаксическая пункция проводятся только врачом-рентгенологом маммографического кабинета онкологического диспансера, имеющим сертификат тематического усовершенствования по лучевой диагностике молочных желез. Результаты маммографии после двойной интерпретации заносятся в бланк и вклеиваются в амбулаторную карту пациентки. Врачами-рентгенологами диспансера оценивается качество скрининговых маммограмм, сделанных в районных и городских поликлиниках и вносятся коррективы по улучшению качества маммограмм в работу маммографических кабинетов поликлиник области/города/региона путем выезда специалистов диспансера на места, проведением обучающих семинаров с врачами и рентгенолаборантами уровня первичного медико-санитарной помощи (ПМСП). Маммограммы архивируются в рентгенархиве диспансера и сохраняются на протяжении жизни женщины. План лечения женщин, у которых выявлен рак молочной железы при маммографическом скрининге, обсуждается на заседаниях мультидисциплинарной группы диспансера по диагностике и лечению рака молочной железы, которые организованы для повышения качества диагностики и лечения пациенток с заболеваниями молочной железы и для мониторинга маммографического скрининга в области/

городе/регионе.

Эффективность

Разработанный алгоритм проведения маммографического скрининга с повторной интерпретацией скрининговых маммограмм на уровне маммографического кабинета онкологического диспансера врачами-рентгенологами, которые по показаниям проводят прицельную маммографию, УЗИ молочных желез и инвазивные процедуры, позволит улучшить качество маммограмм, повысить выявляемость рака молочной железы в ранних стадиях на 20%, повысить качество лечения с использованием мультидисциплинарного подхода, сократить время с момента проведения скрининговой маммографии до оказания специализированной помощи. Мультидисциплинарный подход к лечению рака молочной железы, выявленного в процессе скрининга, позволит увеличить безрецидивный период течения данного заболевания.

Вывод

Правильно организованный и проведенный алгоритм маммографического скрининга в областных и региональных

онкологических диспансерах с использованием «двойной читки» маммограмм и объединением маммографии, УЗИ и трепанбиопсии молочных желез в руках одного специалиста – врача-рентгенолога онкологического диспансера позволит повысить эффективность скрининга и увеличить выявление рака молочных желез в ранних стадиях на 10-20% и более.

Литература

1. Семиглазов В.Ф., Семиглазов В.В., Нургазиев К.Ш. Обоснование стандартов лечения рака молочной железы. – Алматы, 2007. – 364 с.
2. Benson J.R., Jatoi I., Keisch M. et al. Early breast cancer // *Lancet*. – 2009. – Vol. 373. – P. 1463–79.
3. Сейтказина Г.Д. Особенности распространенности рака молочной железы в Западно-Казахстанской области // Сборник научных трудов Республиканского научно-практического семинара «Актуальные проблемы онкопатологии репродуктивной системы женщин». – Астана, 2005. – С. 42 – 43.
4. Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Д., Игисинов С.И. и др. Показатели онкологической службы Республики Казахстан в 2007 году: статистические материалы. – Алматы, 2008. – 52 с.

Ақмола облысындағы қатерлі ісіктердің қауіп факторлары, аурудың таралуы және оны ерте анықтау

Жантемірова Д.А.

Ақмола облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы

Бүгінгі күнде онкологиялық аурулардың мәселесі әлемде және Қазақстан елі үшін аса өзекті болып тұр. Жыл сайын аурудың 3000 жағдайы тіркелетінін айтсақ та жеткілікті. Бүгінгі таңда онкологиялық аурулардың қауіп факторларына медициналық проблемалармен қатар экологиялық ахуалы мен жұртшылық арасында құлықтылық факторларының таралу үрдісі де жатады. Сол себептен қатерлі ісіктердің алдын алу амалдарына, біріншіден, ауруды уақытында анықтап, халық арасында зиянды әдеттер таралуының алдын алу, экологиялық факторлардың жақсаруына барынша ден қою.

Аталған жұмыстың мақсаты – Ақмола облысында жүргізілген скринингтік тексерістің ақпаратын ұсынумен қатар, аймақтар арасында көрсеткіштерді салыстыру және қатерлі ісік ауруларының пайда болу қауіп факторларына сараптама жасап көру.

Пайдаланған қайнар көздер – Республикалық денсаулық сақтау дамыту орталығының Ақмола облысы бойынша филиалының статистикалық мәліметтері мен өткізілген скринингтік тексеріс бойынша сараптамалық анықтама, Степногорск қалалық емханасының онкологиялық қызметі туралы анықтамасы, Ақмола облысының ресми сайты.

Онкологиялық аурулардың алдын алу шараларының негізгісі – ауруды уақытында анықтап, уақытында шара қолдану. Ауруды дер кезінде анықтауда скринингтік медициналық тексеріс маңызды роль атқарады.

Жыл басынан бұл бағытта Ақмола облысы бойынша да бірқатар жұмыс атқарылды.

2011 жылдың 1 қаңтар - 1 қыркүйек аралығында облыста жүргізілген тексеріс нәтижесінде мақсатты топтың 49,6 % қаралған болатын. Бұның ішінде қан жүйесі аурулары, диабет, офтальмологиялық аурулармен қатар онкологиялық ауруларға баса назар аударылды. Айта кететіні, скринингтік тексерілуден өткен тұрғындардың 61,9 %-ы сау.

Скринингтік тексерістер нәтижелеріне көшпес бұрын, жалпы облыстағы онкологиялық ауруларының жағдайларына назар аударайық.

Ақмола облысының денсаулық сақтау дамыту орталығының мәліметтері бойынша, 2011 жылдың 1-жартыжылдығында облыста онкологиялық ауру 100 мың тұрғынға шаққандағы көрсеткіші 104,3–ті құрады. 2010 жылдың 1-жартыжылдық бұл көрсеткіш 108,4 болатын. Аймақаралық деңгейде үстіміздегі жылдың 6 айында онкологиялық аурулар жағдайларының жоғары көрсеткіштері Сандықтау ауданы (170,9) мен Степногорск (157,9), Көкшетау (135,7) қалаларында тіркелген.

Өлім жағдайлары бойынша: 1000 тұрғынға шаққандағы облыс бойынша 2011 жылдың 1-жартыжылдық көрсеткіші – 65,7 (2010 жылдың үйлес мерзімінде – 63,4). Аймақаралық тұрғыдан (2011 жылы) Сандықтау (118,7), Зеренді (92,0) аудандары мен Степногорск (88,5) қаласының өлім структурасы жоғары болып қалып тұр.

Сонымен онкологиялық ауруларды анықтауға бағытталған скринингтік тексерістер негізгі 3 локализация бойынша өткізіліп келеді: сүт безі рагы, жатыр мойын рагы мен тік ішек пен тоқ ішек рагы.

В данном материале изложены данные результатов скрининговых обследований в Акмолинской области и приведены данные по распространению факторов риска, способствующих развитию онкологических заболеваний.

Аталған мақалада Ақмола облысында жүргізілген скринингтік тексерістің ақпаратын ұсынумен қатар, аймақтар арасында көрсеткіштерді салыстыру және қатерлі ісік ауруларының пайда болу қауіп факторлары жайында пікір жинақталған.

This paper presents outcomes of cancer screening and prevalence of risk factors for cancer in Ak-mola oblast.

Жалпы облыс бойынша сүт безі ісігін (СБР) анықтауға арналған тексеріске 22448 адам тиесілі, 2011 жылдың 1 қыркүйегіне олардың 12440-ы қаралды.

Аталған назоологияны анықтауда қолданған зерттеу тәсілі – маммография. Барлығы аталмыш тәсілмен – 12440 әйел тексеріліп, патологиясыз 11159 адам (81,9%) анықталды. 1196 әйелде, яғни 8,8%-да, сүт безінің зарасыз (қатерсіз) ісігі анықталса, қатерлі ісік – 16 адамда табылды (0,12%).

Аймақтарды салыстырсақ, бұл ретте Атбасар (қаралған әйелдердің 23,8 % СБР анықталған), Есіл (35,8%) аудандары мен Көкшетау қаласы (20,1%)

Өлбетте қатерлі ісікке қарағанда, қатерсіз ісікке заманауи медицина төтеп бере алатыны анық, алайда кейбір зарасыз болып саналатын ісіктердің уақыт өте келе қатерліге ауысуы мүмкін екенін естен шығармаған жөн. Мәселен, көптеген зерттеулерге қарағанда, сүт безінің қатерсіз ісігі анықталған әйелдерде обыр ауруының даму қауіпі 50-60 процентке өседі.

Жатыр мойнының рагын анықтау арналған тексерістен 17669 әйел өтті. Текеріс кезінде қолданылған әдістер: кольпоскопия, цитология, жатыр мойнының биопсиясы. Кольпоскопиялық әдіспен 83,4%, цитологиялық зерттеуден қаралғандардың 86,7%-ы тексерілді. Нәжесінде жатыр мойын қатерлі ісігі – 2 адамда анықталды (0,02%). Жатыр мойнының биопсиясы 2390 адамға (9,90%) жасалып, қатерлі ісік – 5 (0,01%) жағдайда анықталды.

Жалпы облыс бойынша тексеруге тиесілі тұрғындардың 61,6 % қаралып, аурадың 433 жағдайы тіркелді, бұл қаралғандардан 2,5 % құрайды.

Аймақаралық тұрғыдан жатыр мойнының рагы Есіл ауданында 8 % жағдайда анықталса, өзге аудандарда бұл көрсеткіш 6 %-тен аспады.

Тоқ және тік ішек рагын анықтауда әйелдер мен ер адамдар арасында медициналық тексеріс гемокультурлық тест, ректороманоскопия, колоноскопия әдістері арқылы жүргізіледі. Гемокультурлық тест жүргізу нәтижесінде 8,7% жағдайда анықталды; ректороманоскопия әдісі аурудың – 2 (0,01%), ал колоноскопия қатерлі ісіктің 5 (0,02%) жағдайын көрсетті.

Ендігі кезекте жалпы жаңа өспелердің пайду болу себептеріне назар аударып, Ақмола облысының қауіп факторларына сарапатама жүргізіп көрейік.

Білетініміздей, рак жасушалары әр адамның ағзасында бар, бірақ олардың өзін көрсетіп, ауру туғызуы бірқатар факторларға тәуелді.

Әлбетте, өспелер мен ісіктердің пайда болу себептеріне көз жүгіртсек, бұл көп жағдайда ілеспелі аурулар. Мәселен, тік ішек рагының негізгі қауіп факторына созылмалы қабыну процестері (жара колиті, гемморой т.б.) жатады.

Қатерлі ісіктердің енді бір қауіп факторлары - вирустық инфекциялар. 16 және 18 типтегі адам папилломасының вирусы жатыр мойны ісігінің туындауына әсер етсе, В гепатитінің вирусы бауыр обырының қауіпін арттырады.

Сонымен бірге қатерлі ісіктердің пайда болуына салауатты өмір салтының ережелерін ұстанбау, яғни құлықтылық факторлар да әсер ететіні екені көпшілікке мәлім. Бұл темекіге деген тәуелділік, алкогольді мөлшерінен артық тұтыну, гиподинамия, дененің артық салмағы, тиімсіз тамақтану сияқтылар.

Айтқандай, жатыр мойын қатерлі ісігінің дамуына темекішегушілік тікелей әсер етеді. Жатыр мойны каналының шырышы мен қынабында катонини, никотин түрінде қалатын темекішегушіліктің өнімі әйел ағзасына зиянын тигізеді.

Қозғалыс енjarлығы, яғни дененің белсенділігі, артық салмақ сүт безі мен тоқ ішек рагына әкеп соғуы мүмкін.

Скринингтік бағдарламысының және бір мақсаты, ауруларды анықтап, уақытында медициналық көмек көрсету ғана емес, жұртшылық арасында қауіп факторларының таралу үрдісін де анықтау. Тексерістен өткен облыс тұрғындарының арасында арнайы сауалнама жүргізіліп келесі фактілер тіркелді. Қаралғандардың 5,6% темекі шегеді; 0,7% ішімдікті мөлшерден артық тұтынады; қаралғандардың 2,87%-де дене салмағы индексі дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы белгілеген нормадан асқан; және 2,62% тұрғынның дене белсенділік көрсеткіші тым төмен көрінеді.

Ауданаралық тұрғыдан: темекішегушілік Қорғалжын және Есіл аудандары тұрғындары арасында көбірек тараған –31,2% және 19,39 % сәйкесінше; Ішімдікті артық тұтыну – Қорғалжын ауданы (5,9%); дененің артық салмағы – Аршалы ауданында артып тұр (12,32%); дене белсенділігінің төмендігі – Жарқайың (52,3%) мен Қорғалжын (41,7%) аудандарында.

Дегенмен осы тұста айта кететін жайт, 2011 жылдың басында Ақмола облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы алғашқы медициналық-санитарлық жәрдем мекемелерінің емделушілері арасында жүргізген сауалнама нәтижелерінде айтарлықтай айырмашылық бар. Мысалы, сауалнамаға қатысқандардың темекі

шегетіндерінің үлесі -21 %, ішімдікті тұтынатындар – 38,2 % (артық тұтыну бойынша арнайы сауалнама жүргізілмеді), және дене белсенділігіне мүлдем көңіл аудармайтандары -36,9 %.

Аудандарды өзара салыстырсақ, темекішегушілер қатары Атбасар ауданында көбірек, алкогольді тұтыну бойынша – Ақкөл ауданы мен Сандықтау ауданы алдыңғы қатарда қалып отыр.

Онкологиялық аурулар қолайсыз экологиялық жағдаймен де байланысты.

Ақмола облысының экологиялық жағдайына келсек, Қ.Сатпаев атындағы қазақ ұлттық техникалық университетінің жүргізген зерттеулеріне қарағанда, облыстың көптеген жерлерінде топырақ пен тау жыныстары жоғары табиғи радиациялық фонмен ерекшеленеді. Мәселен, облыс қалалары мен ауыл үйлеріндегі радон концентрациясы шегі мүмкін шамасынан асып тұр - 200 Бк/м³

(куб метрге Биккерель). EVS 839:2009 «Ішкі климат» стандартына сәйкес тұрғын үйлердегі, жұмыс орындарында радонның ортажылдық 200 Бк/м³-ден аз болуы тиіс.

Ондай жерлер тізімінде – ал зерттеулерге сүйенсек, радон бойынша қауіпті зоналарға облыстың 64 тұрғынды мекені жатады - Сандықтау ауданының Балкашино поселкісі де бар. Химия курсынан білетініміздей, радон өкпе обырының дауымына әсер етуші қауіп факторларының бірі деп саналады. Әсіресе темекішегушілікпен қосылғанда тіпті қауіпі артады. Жоғарыда көрсетілгендей, Сандықтау ауданы онкологиялық аурулар бойынша жайсыз болып отыр.

Әрине, аймақтағы экологиялық проблемалар рак ауруының таралуына тікелей әсер етіп, таукен байыту және өндірістің онкологиялық аурулардың туындауына сөзсіз байланысты екенін пайымдау дұрыс болмас. Себебі қандай да болсын мәселе арнайы зерттеу мен анықтауды талап етеді.

Степногорск қаласы бойынша онкологиялық аурулар жағдайына тағы бір оралсақ. 2011 жылдың басынан онкопатологиямен алғаш рет 101 адам тіркелді, олардың 4 стадияда 9 жағдай, көзге көрінетін 3 стадияда 10 жағдай тіркелді. Степногорск мамандарының жүргізген сараптамасы бойынша, 3 стадиядағы асқынған жағдайлардың негізгі себебі – аурудың сыр бермей ағыу (3 жағдай), кеш қаралу (4). Яғни экологияның әсерінен басқа азаматтардың кеш қаралып, медицина қызметкерлерінің көмегіне дер кезінде жүгінбеуі обырдың асқынған жағдайларына әкеледі. Ал бұл профилактикалық тексеріс мағыздылығының қажеттілігін дәлелдеуі түседі.

Айтылғандай қатерлі ісіктің алдын алуда зиянды әдеттерден арылып, экологиялық жағдайд жақсарту да маңызды.

Информация как средство профилактики

Жантемирова Д.А.

Акмолинский областной центр формирования здорового образа жизни

Вопрос профилактики онкологических заболеваний является одним из главных среди проблем социально-значимых заболеваний современного здравоохранения. Ситуация по случаям заболеваемости и смертности по причине от онкопатологий остается тревожной. Так, заболеваемость по Акмолинской области за 1-полугодие 2011 года составила 104,3 на 100 тысяч населения (108,4 - за аналогичный период 2010 года). Показатель смертности по причине онкологических заболеваний по области на 1-полугодие текущего года – 65,7 на 1000 населения (63,4 – в 2010 году). В разрезе регионов, по-прежнему, одними из высоких показателей как по заболеваемости, так и по смертности наблюдаются в г.Кокшетау.

Одно из наиболее распространенных онкозаболеваний, поражающих женщин, на сегодня остается рак молочной железы. Как известно, рак молочной железы в структуре заболеваемости онкопатологиями лидирует (ежегодно в Казахстане регистрируется 19,5 случаев рака молочной железы на 100 тысяч населения.) Ежегодно в Акмолинской области регистрируются около 200 женщин с диагнозом рак молочной железы и более 250 женщин с доброкачественными заболеваниями. Так, за 8 месяцев 2011 года в области было выявлено 88 женщин с раком молочной железы (102 – за 8 месяцев 2010 года).

В рамках национальной скрининговой программы за 8 месяцев т.г. было обследовано методом маммографии на выявление рака и предопухолевых состояний молочной железы (РМЖ) – 12440 женщин, из них без патологий выявлено – 11159, что составляет – 81,9%, доброкачественные заболевания молочной железы выявлены у 1196 человек, что составляет – 8,8%, злокачественные образования молочной железы – 16, что составляет – 0,12%.

На раннее выявление предопухолевых и опухолевых заболеваний шейки матки (РШМ) всего в области было обследовано 11885 женщин, из них методом кольпоскопии – 9914, что составляет – 83,4%; цитологии – 10371, что составляет – 86,7%, выявлено злокачественные образования шейки матки – 2 (0,02%); биопсия шейки матки – 2390, что составляет – 9,90 %, выявлено злокачественные образования шейки матки – 5 (0,01%).

В числе профилактических мероприятий важную роль играет повышение уровня информированности населения о тех или иных проблемах. Так как обладание достаточной информацией может способствовать выработке навыков ведения здорового образа жизни, в аспекты которого в свою очередь входит обязательное прохождение медицинского профилактического осмотра и своевременного обращения за медицинской помощью.

В целях анализа уровня информированности населения о мерах профилактики онкологических заболеваний Акмолинский ОЦФЗОЖ провел опрос в форме анкетирования. В анкетировании принимали участие представительницы слабого пола в возрасте 29-59 лет, так как в анкетах речь шла о женских болезнях.

Начнем с того, что свое здоровье учителя, индивидуальные предприниматели, продавцы, официанты и парикмахеры в большинстве случаев оценивают, как «хорошее» - 41% респондентов и как «удовлетворительное» - 38,7%. Всего 15,7 % опрошен-

В данной статье приведены результаты скрининговых исследований на раннее выявление рака молочной железы и рака шейки матки по Акмолинской области по состоянию за 8 месяцев 2011 года, а также данные результата опроса среди женщин, проведенного в г.Кокшетау с целью выявления уровня информированности респондентов о факторах риска онкологических заболеваний.

Аталған мақалада сұт безі мен жатыр мойынының рагын анықтауға арналған скринингтік тексерістің Ақмола облысы бойынша 2011 жылдың 8 айлық қорытынды деректері және онкологиялық аурулардың қауіп факторлары туралы білім деңгейлерін анықтау үшін Көкшетау қаласы әйелдері арасында жүргізілген сауалнама нәтижелері ұсынылған.

ных считают, что с их здоровье «отличное»; 4,5% оценивают свое состояние, как «неудовлетворительное».

Что касается медицинской активности, то 46,2 % наших женщин на приеме у врача бывают ежегодно. 41,5 % прием к врачу к врачу сделали ежеквартальной привычкой. Но это скорее необходимость, ведь как было указано выше, далеко не все могут похвастать хорошим здоровьем. 12,3 % не посещают медицинские организации. Среди причин такой пассивности, кроме занятости и отсутствия жалоб, есть и недоверие к медицинским работникам. Судя по ответам на вопросы, касательно болезней, кокшетауские жительницы имеют общее представление о злокачественных новообразованиях. Так, на вопрос, «какие визуальные формы рака вы знаете», ответили практически все респонденты. По выбору ответов на первом месте – рак кожи, на втором – рак губы и на третьем - рак молочной железы.

О причинах возникновения рака шейки матки 36% респондентов не знают, 64% респондентов отвечают утвердительно, указывая следующие причины: на первое место ставят хроническую эрозию шейки (данный фактор указали 44% респондентов), на второе – аборты (32,2%), на третье - случайные половые связи и раннюю половую жизнь (23,8%). Как известно, фактически все перечисленное может привести к нежелательным последствиям.

Еще несколько вопросов анкеты касались рака молочной железы. Здесь респонденты также проявили свои неплохие знания. 58,7 % опрошенных указали мастопатию, как фактор риска развития РМЖ; 9,9% - отказ от кормления грудью; 16,5% - отягощенная онконаследственность по матери и 5,9% - поздняя менопауза. Отметим, что 37% не знают о факторах риска,

Итак, в целом информацией об онкозаболеваниях респонденты опроса обладают на достаточно удовлетворительном уровне. Однако тот факт, что более 10% опрошенных не посещают медицинские организации с целью профилактического осмотра и в среднем 36,5% респондентов не могут назвать факторы риска онкологических заболеваний указывает на одну из причин развития запущенных форм рака – это несвоевременное и позднее обращение за помощью.

Этапные данные скрининга рака молочной железы

Сандыбаев М.Н., Кузнецова Т.В., Кротова А.Г., Уразалин А.М.,

Муздыбаев Р.А., Абылченова А.Р., Манамбаева З.А.

Региональный онкологический диспансер г.Семей

Государственный медицинский университет г.Семей

Как известно в нашей стране введен в действие метод скринингового обнаружения заболеваний молочных желез на ранних стадиях развития.

Данный метод позволяет обнаруживать заболевания молочной железы путем рентгенологического контроля каждой женщины конкретно с интервалами в 2 года. Динамическое наблюдение помогает выявить малейшие изменения в структурах молочных желез, своевременно оценивать их тяжесть и, при необходимости, рекомендовать адекватное лечение, не доводя процесс заболевания до запущенной формы.

Подлежащая осмотру женская часть населения нашего региона насчитывает на 2011 год 16564 человека нечетного года рождения в возрасте от 50-60 лет.

Данное количество людей, в свою очередь, территориально разбито на меньшие группы, каждая из которых приписана к одному из пунктов медико-санитарной помощи, где имеются маммографические кабинеты. Полученные от них сведения и снимки поступают в РОД г. Семей для повторного чтения врачами – рентгенологами, согласно приказа МЗ РК №145 от 16 марта 2011 г., где подтверждается или дополняется первоначальное заключение.

Цель данной работы

- определить эффективность рентгенологической маммографии как основного метода ранней диагностики рака молочной железы.

Материалы и методы исследования

Использовался метод рентгенологического скрининга рака молочной железы.

В процессе работы было использовано следующее оборудование:

1 стационарный маммограф «Alpha-ST» 2006 г/в, производство Финляндия

2 стационарный маммограф «Melody-B» 2004 г/в

3 стационарный цифровой маммограф на передвижной платформе

« Mammomat -1000» 2010 г/в.

Результаты исследования

Данные скрининга по Семейскому региону.

Год	Выполнено	Выявлено всего РМЖ	Выявлено в 1 и 2 стадии
2008	8224	37	15
2009	7405	41	20
2010	8677	33	26
2011	5971	17	3

2008,2009,2010 жылдар және 2011 жылдың жарты жылдығы ішінде Семей қаласы бойынша СБО скринингінсінің анализі жүргізілді. Барлығы 30277 адам тексеруден өткізілді. Оның ішінде 128 әр түрлі даму кезеңіндегі қатерлі ісік анықталды.Ерте кезеңде байқалған қатерлі ісік анықталу жиілігінің өзгеруі жасалған зерттеу жұмысының маңыздылығын көрсетеді.

In our research work analysis of Mammary Glands Cancer screening in Semey Region during 2008,2009,2010,half year of 2011 was done. There are 30277 women had been observed. There were revealed 128 cases of cancer in different stages of development. Analysis of quantity changes, which were revealed on the early stages, makes us able to do conclusion about expediency of this research method.

За прошедшее время нами (РОД) обследовано 30277 женщины. Из числа обследованных выявлено РМЖ - 128 случаев. Жалоб со стороны прошедших обследование не поступало. Все женщины, которым было выставлено заключение РМЖ, были в дальнейшем дообследованы (УЗИ с биопсией, с последующим цитологическим исследованием). После чего РМЖ подтвердился в 113 случаях, что составляет 88 % от числа выявленных РМЖ при маммографии, из них 64 на 1-2 стадии, что составляет 50 % от числа выявленных. В остальных 15 случаях при дообследовании оказалось у 6 женщин - узловая мастопатия (8,2%), у 4 женщин ДФКМ (5,4 %), у 5 женщин фиброаденомы (6,8 %). При анализе 58 подтвержденных РМЖ была выявлена стадийность заболевания:

1-2 стадия- 64

3 стадия - 9

4 стадия - 3

Вышеуказанные данные убедительно подтверждают основную концепцию скрининга – обнаружение РМЖ на самых ранних стадиях, позволяет менять прогноз заболевания и влиять на течение и основные результаты лечения заболевания. Однако приходится отметить, что проведение скрининга не будет достаточно эффективным без последующих дополнительных методов исследований, потому что существуют известные патологии и состояния, при которых рентгенологический метод не может быть основополагающим и достаточно достоверным. В некоторых случаях приходится констатировать тот факт, что двухгодичный интервал между исследованиями слишком долг, и частота возникновения интервальных раков могла бы значительно сократиться, возможно, за счет более гибкого подхода в рассмотрении конкретных случаев. Тем не менее, мы можем быть уверены в правильности выбранного стратегического направления для ранней диагностики РМЖ.

Результаты целевого маммографического обследования в Семейском регионе Восточно-Казахстанской области

Сандыбаев М.Н., Манамбаева З.А., Байпеисов Д.М., Абылченова А.Р., Карипова М.К., Жабагин К.Т.

Региональный онкологический диспансер г.Семей

Введение

Рак молочной железы на данный момент является актуальной проблемой в современной онкологии. К сожалению, отмечается рост частоты заболеваемости и смертности женщин от данной патологии.

В практику развитых стран прочно вошло понятие скрининг. Скрининг-это массовое периодическое обследование здорового населения с целью выявления онкологического заболевания, в данном случае рака молочной железы. Идея скрининга основана на том факте, что обычное клиническое обследование не обеспечивает выявление рака молочной железы на ранних стадиях. Скрининг должен отвечать следующим требованиям: обладать высокой чувствительностью и специфичностью, приносить минимальный вред здоровью обследуемых; оборудование должно быть простым в эксплуатации и содержании, стоимость затрат должна быть приемлемой. Указанным требованиям соответствует маммографический скрининг, позволяющий выявить значительный спектр новообразований – от микро-фокусов *carcinomae in situ* до крупных инвазивных очагов поражения. Установление размера диагностируемых опухолей является важным критерием оценки качества скрининга и определения возможностей маммографии выявлять не пальпируемые опухоли. Проведение маммографического скрининга показано, с периодичностью один раз в два года, в возрасте 40 и более лет, так как именно в этой возрастной группе отмечена наиболее высокая заболеваемость.

Цель

- изучить эффективность маммографического скрининга в регионе г.Семей Восточно-Казахстанской области.

Материалы и методы

Учитывая высокие показатели заболеваемости и смертности от РМЖ, издан приказ МЗ РК №607 от 15.10.2007 «о совершенствовании профилактических осмотров отдельных категорий взрослого населения». Начиная с 2006 года введен скрининг для раннего выявления предопухолевых и опухолевых заболеваний молочной железы. С 2006 по 2009 года целевой группой являлись женщины в возрасте от 35 до 49 лет, выявлено 23 женщины с РМЖ. С I-II стадией выявлено 17 случаев, с III стадией - 6 случаев. Результаты исследования: в Семейском регионе в разрезе заболеваний среди женского населения РМЖ занимает первое место, а в разрезе общей онкологической патологии второе место. Ежегодно более 150 женщин выявляются со злокачественным заболеванием молочной железы, и среди них около 40% с запущенной формой.

Проведен анализ клинической эффективности целевого маммографического скрининга в регионе г.Семей Восточно-Казахстанской области. Результаты свидетельствуют о повышении числа больных с ранними клиническими стадиями в средней возрастной группе, в тоже время увеличение процента запущенности в старшей возрастной группе.

Шығыс Қазақстан Облысының Семей өңірі бойынша көзделген маммографиялық скринингтің клиникалық тиімділігінің анализі жүргізілді. Жасалған жұмыс қорытындысы орта жастағы науқастар ішінде аурудың ерте клиникалық кезеңі және егде жастағы топтарда аурудың асқындырылған кезеңі пайызының артқанын байқалтады.

In Semey city of East Kazakhstan Region analysis of clinical effectiveness of mammographic screening was done. Results of research work shows us increasing of quantity of middle age patients with early clinical stages, also increasing of percentage of abandonment in old age patients.

Начиная с 2009 года целевой группой по программе скрининга являются женщины в возрасте 50-60 лет. За 2 года выявлено 46 женщин с РМЖ. С I-II стадией -34 случаев, с III стадией - 12 случаев. В 2009 году отмечаются высокие показатели запущенности, это связано с профилактическим осмотром женщин в возрасте от 50-60лет. На сегодняшний день на базе РОД создана мультидисциплинарная группа. В состав группы входят: маммолог, врач рентгенолог, статист, патоморфолог. Целью функционирования настоящей группы является дообследование пациенток с выявленной на маммографии патологией.

Таким образом, данная программа дает возможность выявления рака молочной железы на ранних стадиях, что в свою очередь увеличивает процент выздоровления: в группе женщин, которым проводилась маммография один раз в 2-3 года отмечено достоверное снижение смертности на 24-30%. Причем повышение риска отмечено только у женщин в возрасте старше 50 лет. Результаты свидетельствуют о повышении числа больных с ранними клиническими стадиями в средней возрастной группе, в тоже время увеличение процента запущенности в старшей возрастной группе, так как обследованию подвергается категория женщин пенсионного возраста, которые длительное время не обследовались.

Организация скрининга рака шейки матки в Республике Казахстан

Шибанова А.И., Каирбаев М.Р., Жилкайдарова А.Ж., Кусаинова Б.Т., Ольшевская Н.В., Якупова Л.М., Мухаметгалиев Н.А., Тюменева Ф.Х., Рубцова Л.Н., Тихонова Т.А.

КазНИИОиР, онкологические диспансеры г. Алматы, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Южно-Казахстанской областей

Введение

В Республике Казахстан рак шейки матки занимает второе место в структуре заболеваемости женщин злокачественными новообразованиями, и удельный вес больных выявляемых на поздних стадиях остается высоким.

Это явилось основанием включения в Государственную программу реформирования и развития Здравоохранения страны, проведение профилактических осмотров женщин в целевой группе от 30 до 60 лет. (Приказы МЗ РК от 15.10.2007 №607; № 164 от 30.03.2009; № 685 от 10.11.2009). В Казахском НИИ онкологии и радиологии разработана и внедрена во всех онкологических диспансерах программа по поэтапному проведению цитологического скрининга женского населения начиная с первичных звеньев (СУБ, СВА, ФП, ФАП, женские консультации и т.д.). Подготовлены методические рекомендации с инструкцией по проведению профилактических медицинских осмотров отдельных категорий взрослого населения путем выборочных (скрининговых) обследований.

Организация выполнения данной программы осуществляется совместной работой гинекологов и цитологов КазНИИОиР, специализированным консультативно-диагностическим отделом, а также областными и городскими онкодиспансерами. Для эффективности скрининга по выявлению ранних форм рака шейки матки в РК внедрен метод Пап-теста с оценкой результатов по современной классификации «Бетesda». Все лаборатории были оснащены необходимыми реактивами и оборудованием. Для обучения цитологов и гинекологов были привлечены ученые из Японии и России, проведены многократные семинары, мастер - классы, конференции и тематические усовершенствования для специалистов всех регионов Республики. Созданы алгоритмы обследования с последующим лечением выявленной патологии.

Результаты исследования

Результаты обследования женщин за период 2009-2011 гг. свидетельствуют, что метод Пап-теста способствует более дифференцированной оценке ранней патологии, фоновых процессов (включая вирусные заболевания) шейки матки.

За 3 года было охвачено цитологическим исследованием 1 487 580 женщин целевой группы, что составило 94,4%. Общереспубликанский показатель цитологических заключений LSIL (CIN I, слабая дисплазия) составил 2,2% (у 33 217 женщин), что соответствует мировым данным. При анализе заключений HSIL (CIN II, CIN III, Ca in situ) был выявлен в 0,6 % (у 8 500 женщин).

Количество выявленных женщин с преинвазивным раком и раком шейки матки I-ой стадий заболевания составило 0,02% (362 человека).

Анализ результатов скрининга свидетельствует о большом разбросе числа выявленной ранней онкопатологии (LSIL, HSIL) по отдельным регионам, что требует более тщательной работы на всех уровнях обследования женщин - начиная с забора, фиксации, доставки и оценки

2009-2011ж.аралығында жатыр мойының қатерлі ісігінің скрининг жұмысының анализдерінің қортындысы жүргізілді. Пап-тест әдісімен тексеру кезінде жатыр мойының ісігі анықталды. Әдістемелен зерттеулер барысында шалғай ауылдарда қыйындықтар туындады.

В работе проведен анализ результатов скрининга рака шейки матки по РК за 2009-2011г.г. Отмечена динамика выявления заболевания шейки матки по методу Пап-тест, выявлены сложности проведения скрининга в отдаленных регионах, определены пути повышения эффективности скрининговых исследований.

Uterine cervix cancer is the most common gynaecological cancer type in Kazakhstan and one of the leading cause of death among female cancer patients. Method of screening – conventional cytology (pap-test) with reporting results according to Bethesda system (2001). The low quality of pap-test affected sensitivity and specificity of screening test, that's why we consider to introduce liquid based cytology together with new methods of personnel motivation at the next step.

цитологического материала.

Дальнейшее повышение эффективности цитологического скрининга в ранней диагностике рака шейки матки, в Республике Казахстан, возможно путем решения следующих задач: это качественное и квалифицированное получение материала из шейки матки и цервикального канала подготовленными акушер-гинекологами, начиная с первичных звеньев обследования, не теряет своей актуальности вопрос по подготовке кадров методике цитологического исследования по Папаниколу с внедрением жидкостной цитологии по РК и интерпретации цитологических данных.

Список литературы

1. Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Д., Махатаева А.Ж., Сейсенбаева Г.Т. Показатели онкологической службы Республики Казахстан в 2009-2010 году (статистические материалы). Алматы, 2008-2010г.г.
2. Статистические данные мединформа за период 2009 – 2010г.г. и 6 мес. 2011г.
3. Шибанова А.А. Цитологический метод в выявлении гинекологической патологии при профилактических обследованиях женщин. Алматы, 2009г.
4. Davey E, Barratt A, Irwig et al. Effect of study design and quality on unsatisfactory rates, cytology classifications, and accuracy in liquid-based versus conventional cervical cytology: a systematic review. Lancet 2006; 376: 122–32.
5. Sankaranarayanan R, Gaffikin L, Jacob M et al. A critical assessment of screening methods for cervical neoplasia. Int J Gynecol Obstet 2005; 89: S4–12.
6. Solomon D, Davey D, Kurman R et al. The 2001 Bethesda System. Terminology for reporting results of cervical cytology. JAMA 2002; 287 (16): 2114–8.

Эндоскопическая тактика в рамках программы скрининга колоректального рака в РК

Ахметжанов О. Т., Калиева Ж. Ж.

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии (КазНИИОнР)

По прогнозам экспертов ВОЗ, в следующие два десятилетия абсолютное число случаев колоректального рака в мире увеличится в 2 раза в результате роста населения в целом и его старения, как в развитых, так и развивающихся странах. Скрининг предопухоловой патологии и ранних форм рака у бессимптомного населения и своевременное лечение - единственный эффективный метод профилактики развития колоректального рака и снижения смертности от этой патологии. Эндоскопическое исследование кишечника - колоноскопия - является наиболее оптимальной методикой скрининга колоректального рака.

В рамках скрининговой программы показанием к колоноскопии является положительный IFOB тест у подлежащей скринингу группы населения.

Пациент подлежащий колоноскопии по программе скрининга колоректального рака обращается в областной онкодиспансер или диагностический центр по месту жительства в кабинет колоноскопии. Накануне исследования пациенту сообщается время проведения процедуры, объясняется порядок подготовки и выдается на руки инструкция подготовки к исследованию (см. приложение 1), а также форма согласия на проведение колоноскопии (см. приложение 2).

В назначенное время пациент обращается в кабинет колоноскопии, где подписывает согласие на проведение колоноскопии.

Врач проводит процедуру, в случае необходимости делается седация.

Врач должен владеть методикой тотальной колоноскопии и иметь соответствующий сертификат.

За один рабочий день на одну ставку врач должен выполнить 3 - 4 колоноскопии.

Состав и рекомендуемая площадь помещений кабинета колоноскопии:

- кабинет врача 10 м²
- процедурная со сливом 18+2 м²
- кабина для раздевания 2 (2X2) 4 м²

В кабинете для проведения колоноскопии в рамках скрининга д.б. эндовидеостойка с двумя видеоколоноскопиями.

Кабинет колоноскопии д.б. оборудован автоматической моечной машиной для обработки эндоскопов.

Оценка результатов колоноскопии проводится по нижеприведенной форме:

Колоноскопия (50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68 и 70 лет):

- 1 - без патологии (KS1),
- 2 - визуально видимые метапластические изменения слизистой (KS2),
- 3 - хронические воспалительные заболевания кишки (KS3),
- 4 - наследственные заболевания толстой кишки и аномалии ее развития (KS4),
- 5 - экзифитное образование (KS5): а - одиночное (KS5a), б - множественные (KS5б),
- 6 - инфильтративно-язвенное образование (KS6),
- 7 - больше данных за рак (без морфологической верификации) (KS7),

Мақалада эндоскопиялық әдістің колоноскопиялық жоспарланған кодтары арқылы жасалған стандарттандырылған нәтижелері скринингтік бағдарламаның көлемінде сипатталады.

The article presents the endoscopic tactics in a screening program for colorectal cancer; with a standardized evaluation of the results of colonoscopy according to the developed codes.

В статье представлена эндоскопическая тактика в рамках программы скрининга колоректального рака, со стандартизированной оценкой результатов колоноскопии по разработанным кодам.

8 - рак, верифицированный патоморфологически (KS8),

9 - колоноскопия не проведена по причине отказа пациента или по причине медицинских противопоказаний колоноскопии (KS9).

При KS2 - KS7 берется биопсия подозрительных участков. На каждый микропрепарат заполняется специальное направление на патоморфологическое исследование утвержденного образца. В направлении обязательно указывается ФИО, возраст, адрес места жительства и контактный телефон. Биопсийный материал направляется в лабораторию и архивируется в лаборатории в обязательном порядке. При отрицательном результате биопсии, пациенты с KS3 - KS4 направляются к гастроэнтерологу. При отрицательном результате биопсии, пациенты с KS5 - KS7 направляются к онкологу-колопроктологу для решения вопроса о дальнейшей тактике лечения (эндоскопическая полипэктомия, радикальная операция, наблюдение). KS8 - при положительном результате биопсии пациент направляется к районному онкологу для проведения специализированного лечения. KS9 - пациент отправляется к участковому врачу для проведения альтернативных методов исследования.

Результаты биопсии толстой кишки, полученной в результате колоноскопии, оцениваются в соответствии с общепринятыми международными стандартами и классификацией ВОЗ. Морфологическое исследование биопсийного материала проводится в патоморфологической лаборатории ООД/ГОД.

Список использованной литературы

1. Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Ж. и соавт. Показатели онкологической службы Республики Казахстан, статистические материалы 2001-2010гг.
2. Скрининг колоректального рака в г. Москве: возможности и проблемы А.И. Парфенов, ЦНИИ Гастроэнтерологии, Москва
3. Эндоскопический скрининг в своевременной диагностике колоректального рака П.А. Никифоров, УНЦ МЦ УД Президента РФ, Москва
4. Распространенность КРР и полипов толстой кишки среди взрослого населения г. Москвы (по результатам исследования «МУЗА») С.И. Прилепская, КДП №121, Москва

Результаты маммографического исследования женщин в Кызылординской области

Толеутайұлы К., Байқадамов А.Х., Толеутай У.К., Қайнарбаева Л.К., Ербошаев С.У., Абдикерова А.Е.
Кызылординский областной онкологический центр, ВШОЗ

Введение

Ежегодно в мире с 2000 года выявляется более 1 млн. новых случаев рака молочной железы (РМЖ). Из 10 млн. новых случаев злокачественных опухолей различных органов, выявляемых сегодня на земле, 10-12% приходится на молочную железу. Ежегодно умирает – около 410 000 женщин в мире от рака молочной железы.(1)

В рамках выполнения приказа МЗ РК №16 от 11.01.2005 г. «Об утверждении Правил проведения профилактических медицинских осмотров женщин репродуктивного возраста за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета», №607 от 15.10.2007г. «О совершенствовании профилактических медицинских осмотров отдельных категорий взрослого населения», приказа МЗ РК от 10 ноября 2009 года № 685 «Об утверждении Правил проведения профилактических медицинских осмотров целевых групп населения» и приказа МЗ РК от 16 марта 2011 года № 145 «О внесении изменений в № 685 «Об утверждении Правил проведения профилактических медицинских осмотров целевых групп населения» в области начата профилактическая маммография. Маммографическому скринингу предшествовала активная просветительная работа с использованием СМИ (телевидение, областные и районные газеты, календары женского здоровья).

Маммография наиболее эффективный метод ранней диагностики патологии молочных желез, позволяющий выявлять очаги опухоли от 0,3 см и косвенные признаки начинающего патологического процесса.

Целью исследования

явилось изучение возможностей маммографического скрининга в ранней диагностике предопухолевых и опухолевых заболеваний молочных желез. При этом приглашались на скрининг женщины в возрасте от 50 до 60 лет, хотя иногда приглашались женщины до 75 лет и моложе 50 лет.

Материалы и методы

Был проведен анализ 78031 маммографических исследований с 2007-2011 гг.

Результаты исследований

В области имеются 11 маммографических установок, 3 из них в областном центре. С 2007 по 2011 гг. Запланировано 88630, проведено 78031 (88,0%) маммографических исследований. В условиях областного онкологического центра проведены 11873 маммографических исследований. Среди 78031 маммографических исследований выявлены следующие патологические процессы: подозрение на рак молочной железы у 294 женщин (0,4%), рак у 130 (0,16%), фиброаденома молочной железы у 1669 (2,13%) и другие формы мастопатии у 21573 (27,60%). Из 11873 исследований проведенных в условиях онкологического центра профилактическая маммография проведена 11119 (93,6%), а 754 (6,35%) женщинам - диагностическая маммография.

С второй половины 2011 года начата вторичная читка маммограмм в условиях областного онкологического

Кызылорда облысында маммографиялық тексерулердің қорытындылары

К. Толеутайұлы, А.Х. Байқадамов, У.К. Толеутай, Л.К. Қайнарбаева, С.У. Ербошаев А.Е. Абдикерова

Кызылорда облыстық онкология орталығы, Жоғарғы қоғамдық денсаулық сақтау мектебі

Соңғы бес жыл көлемінде 78031 әйелге маммографиялық тексеру жүргізілген. Онда мынадай патологиялық өзгерістер анықталған. Атап айтқанда, сүт безі қатерлі ісігіне (сбкі) күдіктену-294 (0,4%) әйелде, сбкі -130 (0,16%), сүт безінің фиброаденомасы - 1669 (2,13%) және басқа мастопатия түрлері - 21573 (27,60%). Осындай жұмыстардың арқасында сүт безі қатерлі ісігін ерте анықтау соңғы бес жылда 63,4 пайыздан 73,5 пайызға жақсарып отыр.

The results of Kyzylorda oblast mammography tests

K. Toleutaiuly, A.H. Baikadamov, U.K. Toleutai, L.K. Kainarbayev, S.U. Yerboshayev, A.E. Abdikerova

Kyzylorda oblast oncological center; The high school of health protection

Within last five years, carried out 78031 mammography tests. Found out the following pathological changes. Suspicious for neoplasm of mammary gland -294 (0,4%) women, nomg -130 (0,16%), fibroadenoma of mammary gland - 1669 (2,13%) and other types of mastopathy - 21573 (27,60%). Thanks to these testings the percentage of early detected mammary gland neoplasms improved from 63,4 to 73,5 percents.

центра. Вторичная читка маммограмм проведена 2285 женщинам, при этом у 9 (0,4%) было заподозрено рак молочной железы.

Женщины в возрасте от 20 до 49 лет проходили обследование в смотровом кабинете поликлиник (фельдшерско-акушерском пункте, семейной врачебной амбулатории или женской консультации и пр.), которое включает осмотр и пальпацию молочной железы, утвержденной приказом областного управления здравоохранения № 209 1.04. 2005 года «О совершенствовании ранней диагностики патологии молочной железы акушер - гинекологами».

В период с 2007 по 2010 гг. В Кызылординской области заболеваемость раком молочной железы находится почти на одном уровне. Так например, заболеваемость РМЖ на 100 тыс. населения в 2007 году составлял 11,5 то аналогичный показатель в 2010 году составил 11,8. (по РК - 20,6 на 100 тыс. населения).

Хотя показатель РМЖ в Кызылординской области был ниже, чем в РК, однако на протяжении всего периода отмечался интенсивный рост заболеваемости РМЖ в Кызылординской области, особенно после внедрения маммографического скрининга.

Нами проанализированы данные по запущенным стадиям РМЖ в регионе за пятилетний период.

Высокие показатели запущенности в III или IV стадии

заболевания имело место в 2007 году, когда он достигал 36,6% от общего числа выявленных случаев. После внедрения профилактической маммографии процент выявления РМЖ в поздней стадии снизились до 26,5% и улучшились показатели ранней диагностики рака молочной железы с 63,4 до 73,5%.

В стратегии борьбы с РМЖ в настоящее время высока роль вторичной профилактики, т.е. выявления опухолей молочной железы в той стадии, когда она может быть излечена существующими методами лечения. существующая организация, техническая оснащенность и методология обследования не могут обеспечить раннее выявление РМЖ. Внедрение современного маммографического скрининга с 2006 года существенно уменьшил процент запущенности РМЖ. Однако, имеющаяся одиннадцать маммографов в области все еще недостаточно для полноценного обследо-

вания, особенно жителей села. Для дальнейшего улучшения ранней диагностики РМЖ необходимо: адекватное финансирования программы, кадровое обеспечение, достаточное обеспечение современными маммографическими приборами городских поликлиник и пропаганда целесообразности ранней диагностики.

Таким образом, современная технология скрининга рака молочной железы и дообследования успешно реализуется на практике при комплексном использовании клинического, маммографического и цитологического методов исследования.

Список литературы

1. Рожкова Н.И. *Современные технологии скрининга рака молочной железы. Радиология: наука и практика.* Астана, 2009., 262-269.

Цитологический скрининг по ранней диагностике рака шейки матки

Л.М. Якупова

Западно-Казахстанский областной онкологический диспансер, г. Уральск

Актуальность

Одной из главных задач практического здравоохранения является профилактика и ранняя диагностика рака шейки матки (РШМ). В этом плане важна эффективная диагностика начальных стадий рака, предопухолевых и фоновых заболеваний ШМ во время скрининга в различные периоды жизни женщины.

Материалы и методы

В 2009 году было проведено цитологическое исследование шейки матки 18 614 женщин ЗКО, в 2010 году - 15 980, за 8 месяцев 2011 г. - 17 061 женщин независимо от анамнестических данных.

Результаты

В 2009 году было выявлено 279 случаев с поражениями ШМ (Д I—III, carcinoma in situ, инвазивный РШМ), что составляет 1,5%. CIN I – 196 (1,05%), CIN II – 40 (0,2%), CIN III – 30 (0,16%), carcinoma in situ, РШМ – 13 (0,06%). Число неинформативного материала составило 615 случаев (3,3%).

Всего в 2009 г. выявлено и взято на учёт с диагнозом рак шейки матки 52 пациентки (из них 13 пациенток скринингового возраста), заболеваемость составила 9,1 на 100 тыс. населения. По стадиям заболевания: I-II ст. - 44 (84,6%), III ст. - 6 (11,5%), IV ст. - 2 (3,8 %).

В 2010 году было выявлено 260 случаев с поражениями ШМ (Д I—III, carcinoma in situ, инвазивный РШМ), что составляет 1,6%. CIN I – 183 (1,1%), CIN II – 30 (0,2%), CIN III – 24 (0,15%), carcinoma in situ, РШМ – 23 (0,14%). Число неинформативного материала составило 1392 случая (8,7%).

Всего в 2010 г. выявлено и взято на учёт с диагнозом рак шейки матки 55 пациенток (из них 23 пациентки скринингового возраста), заболеваемость составила 9,1 на 100 тыс. населения. По стадиям заболевания: I-II ст. - 45 (81,8%), III ст. - 9 (16,4%), IV ст. - 1 (1,8%).

За 8 месяцев 2011 года выявлено 236 случаев с поражениями ШМ (Д I—III, carcinoma in situ, инвазивный РШМ), что составляет 1,4%. CIN I – 154 (1%), CIN II – 50 (0,3%), CIN III – 11 (0,06%), carcinoma in situ, РШМ – 22 (0,12%). Число неинформативного материала составило 1461 случаев (8,5%). Всего выявлено и взято на учёт 52 случая РШМ (из них 22 случая скринингового возраста). Заболеваемость составила 8,5 на 100 тыс. населения. По стадиям заболевания: I-II ст. - 41 (78,8%), III ст. - 8 (5,3%), IV ст. - 1 (1,9%).

За 8 месяцев 2010 года выявлено 232 случая с поражениями ШМ (Д I—III, carcinoma in situ, инвазивный РШМ), что составляет 1,6%. CIN I – 171 (1,2%), CIN II – 29 (0,2%), CIN III – (0,14%), carcinoma in situ, РШМ – 11 (0,07%). Число неинформативного материала составило 1339 случаев (9,3%). Всего за 8 месяцев 2010 г. выявлено и взято на учёт 33 случая РШМ (из них 11 пациенток скринингового возраста). Заболеваемость составила 8,5 на 100 тыс. населения. По стадиям заболевания: I-II ст. - 28 (84,8%), III ст. - 4 (12,1%), IV ст. - 1 (3%). Прирост выявляемости

Жатыр мойны рагін ерте диагностикалаудағы цитологиялық скрининг

Денсаулықсақтау тәжірибесінің ең негізгі міндеті профилактика және жатыр мойны рагін ерте диагностикалау. Бұл жоспарда ракті бастапқы сатыда тиімді диагностикалау маңызды. Скрининг кезінде ісіктен бұрынғы жатыр мойнының айналасындағы ауруларды әйелдердің әр түрлі өмір сүру кезеңінде болғанын анықтайды.

Әдістер мен мәліметтер. 2009-2011 жылдар 51655 әйелдердің жатыр мойнына цитологиялық зерттеулер жүргізілді.

Анамнездік мәліметтерге қарамастан.

Қорытындылар. Барлығы 2010 жылы анықталды және бақылауға жатыр мойны рагі диагнозымен 55 науқас (оның ішінде 23 науқас скрининг жасында) ауру құрады 9,1 100 мың тұрғындарға. Ауру сатысы бойынша: I-2 ст. – 45 (81,8%), III ст. – 9 (16,4%), IV ст. I (1,8%).

2009-2010 жж аралығында барлық анықталғандар және бақылауға алынғандар жатыр мойын рагі диагнозы бойынша 140 науқас (олардың 67 науқас скрининг жасында).

Цитологический скрининг по ранней диагностике рака шейки матки

Одной из главных задач практического здравоохранения является профилактика и ранняя диагностика рака шейки матки. В этом плане важна эффективная диагностика начальных стадий рака, предопухолевых и фоновых заболеваний ШМ во время скрининга в различные периоды жизни женщины.

Материалы и методы. За 2009-2011 гг. было проведено цитологическое исследование шейки матки 51655 женщин независимо от анамнестических данных.

Результаты. Всего в 2010 г. выявлено и взято на учёт с диагнозом рак шейки матки 55 пациенток (из них 23 пациентки скринингового возраста), заболеваемость составила 9,1 на 100 тыс. населения. По стадиям заболевания: I-II ст. - 45 (81,8%), III ст. - 9 (16,4%), IV ст. - 1 (1,8%).

Всего за период 2009-2011 гг. выявлено и взято на учёт с диагнозом рак шейки матки 140 пациенток (из них 67 пациенток скринингового возраста).

составил 57,5%.

В 2007 РШМ I-II ст. составлял 62,1%, в 2008 г. - 70,3%, в 2009 – 82,7%, в 2010 – 81,8%. В целом отмечается повышение ранней диагностики РШМ.

Вывод

Результаты анализа диагностики поражений шейки матки у женщин во время скрининга показывают высокую эф-

фективность проводимых исследований. За счёт цитологических исследований возросла ранняя и своевременная диагностика рака шейки матки (рака in situ, I-II ст.). Выявление различных неопухолевых заболеваний важно для активного лечения.

Имеются реальные пути снижения и ликвидации распространенных злокачественных опухолей у женщин. Однако основным критерием цитологического скрининга РШМ является консультативный характер работы врача-цитолога и ответственность гинеколога за качество материала. То есть, заказывая консультацию цитолога, гинеколог несет ответственность за чувствительность теста! Информативность цитологических исследований в значительной степени зависит от адекватности материала. В адекватном материале высока вероятность выявления предопухолевых состояний эпителия шейки матки.

Оптимальная организация всех этапов скрининга и профессиональное выполнение всех процедур и оценок позволит сберечь здоровье женщин и сохранить генофонд нашей страны.

Список использованных источников

1. Подистов Ю.И., Лактионов К.П., Петровичев Н.Н. *Современные диагностические возможности в определении предрака и рака шейки матки (Обзор литературы)* // Научно-практический журнал РФ «Клиническая лабораторная диагностика». - 2003. - №3.
2. Кайрбаев М.Р., Исакова Ж.К., Шибанова А.И., Козбагарова Р.Г., Мухаметгалиев Н.А. *Скрининг рака шейки матки (методические рекомендации)* Методические рекомендации основаны на документе ВОЗ «Comprehensive Cervical Cancer Control: a guide to essential practice», WHO 2006.
3. *Годовые отчёты за 2007-2011 гг. ГККП Западно-Казахстанского областного онкологического диспансера.*

Распространенность основных форм злокачественных опухолей у детей в Казахстане

Жумашев У.К.

Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы

УДК: 614,2:616 – 006.4:616 – 053.2(574)

В отечественной литературе мало работ, посвященных эпидемиологии злокачественных новообразований у детей. Отдельными работами являются исследования, проведенные в России Дурновым Л.А., Заридзе Д.Г., Ли Н.А., которые показали, что уточненная заболеваемость злокачественными новообразованиями у детей примерно в 30%, а в некоторых регионах на 50% выше, чем та, которая устанавливается на основании официальных отчетов [Аксель Е.М., Двойрин В.В. 1993; Дурнов Л.А. 1995; Заридзе Д.Г. и соавт. 1993].

Углубленное эпидемиологическое изучение заболеваемости и смертности от злокачественных опухолей детского населения Казахстана является актуальной задачей современной онкологии. Поскольку, целенаправленных эпидемиологических исследований показателей заболеваемости и смертности детского населения от злокачественных опухолей с учетом определенных компонентов онкологической помощи влияющих на их уровень не проводились. Поэтому, одной из центральных задач данного исследования является ранжирования злокачественных опухолей по степени значимости отдельных компонентов состояния онкологической службы детского населения. Подобные исследования в Казахстане, проводится впервые, и получаемые результаты представляют определенный практический и теоретический интерес. Важными моментами при этом являются: единая методика расчета показателей и критерий (стандарты) для их оценки. Критерии оценки могут иметь различный уровень: региональный, казахстанский, европейский, мировой. В результате введения критериев оценки медико-статистических показателей при изучении злокачественных новообразований в практику детских онкологических отделений и центров станет возможным получение сравнимой информации, получаемой внутри страны и за рубежом [Duncan M.H. et al 1986; Мерабишвили В.М., Старинцев В.В. 1995].

Материалы и методы исследования

При изучении статистики отдельных форм злокачественных опухолей детского населения в Казахстане использовано материалы 2951 больных за 1997-2006 гг. и из них лейкозы – 739, опухоли головного мозга – 563, лимфомы – 466 с использованием современных методов санитарной статистики [Двойрин В.В., Дурнов Л.А. 1995; Заридзе Д.Г. и соавт. 1993].

Результаты исследования и обсуждение

Злокачественные новообразования у детей и взрослых существенно отличаются по их частоте и виду. В структуре злокачественных новообразований всего населения на долю детей приходится в среднем 10,2%.

Лейкозы. За 1997-2006 гг. в республике зарегистрировано 739 больных детей лейкозами, что составляет

Анализировано 2951 больных детей зарегистрированных за 1997-2006 годы в Казахстане. Из них Лейкозы – у 739 (25% - первое место), опухоли головного мозга – у 563 (19,1% - второе место), Лимфомы – у 466 (15,8% - третье место), опухоли мягких тканей – у 291 (9,9% - четвертое место), опухоли костей – у 270 (9,2% - пятое место), и далее по рангу нефробластома – у 207 (7,0%), нейробластома – у 114 (4,0%), опухоли глаз – у 106 (3,6%), опухоли яичко – у 57 (1,9%), опухоли печени – у 48 (1,7%), опухоли яичников – у 47 (1,6%) и Лангергансо-клеточные гистиоцитозы – у 43 (1,5%) больных детей.

Выявлено неравномерное распределение больных злокачественных опухолей у детей в различных областях Республики, что обусловлено с неполноценностью учета больных детей. Следовательно необходимо, улучшение онкологической помощи больным детского населения путем повышения выявляемости и ранней диагностики, а также налаживания полноценности учета злокачественных опухолей детского населения.

Қазақстандағы балаларда кездесетін қатерлі ісіктердің кездесу жиілігі

Жұмашев У.Қ.

С.Ж. Аспандияров атындағы Қақтың ұлттық медицина университеті, Алматы қ.

Қазақстанда 1997-2006 жылдар арасында қатерлі ісікпен ауырған 2951 науқасты сараптау кезінде, олардың: 739 – Лейкоз (25% - бірінші орында), 563 – мидың ісіктері (19,1% - екінші), 466 – қатерлі лимфомалар (15,8% - үшінші), 291 – жұмсақ тіннің ісіктері (9,9% - төртінші), 270 – сүйектің ісіктері (9,2% - бесінші орында), және ары қарай 207 – бүйректің ісіктері (7,0%), 114 – нейробластома (4,0%), 106 – көздің ісіктері (3,6%), 57 – ұлдардың аталық безінің ісіктері (1,9%), 48 – бауырдың ісіктері (1,7%), 47 – қыз балдардың аналық безінің ісіктері (1,6%) және 43 – гистиоцитоз ісіктері (1,5%) анықталған. Республикадағы науқастардың әртүрлі көрсеткіші олардың толық есепке алынбай, ісіктің әрқелкі анықталуын көрсетеді. Сондықтан республикадағы балалар онкологиялық жұмысын жандандырып, оларда кездесетін қатерлі ісіктерді дер кезінде анықтауды әрі жүйелі есепке алуды жақсарту керек.

Prevalence of the basic forms of malignant tumours at children in Kazakhstan

Zhumashev U.K.

Kazakh national medical university after S.D. Asfendijarova, of Almaty

Analyse 2951 sick children registred material for 1997-

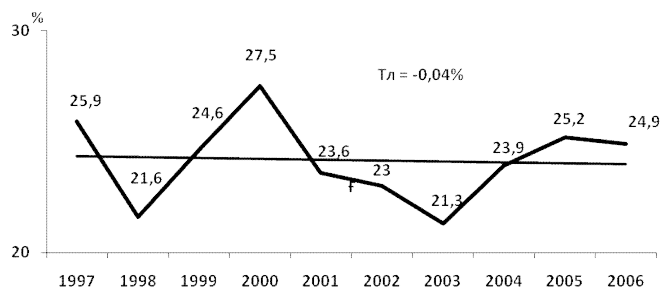


Рисунок 1- Динамика удельного веса больных лейкозом детского населения Казахстана (1997-2006 гг.).

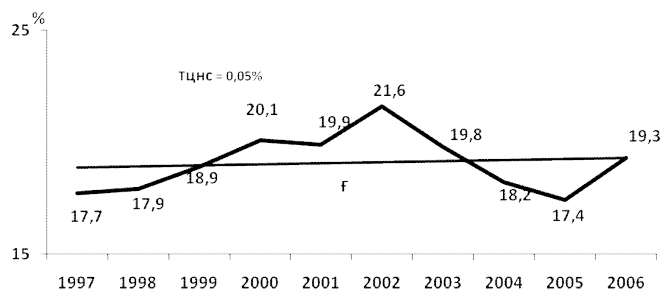


Рисунок 2- Динамика удельного веса больных опухолями ЦНС детского населения Казахстана (1997-2006 гг.).

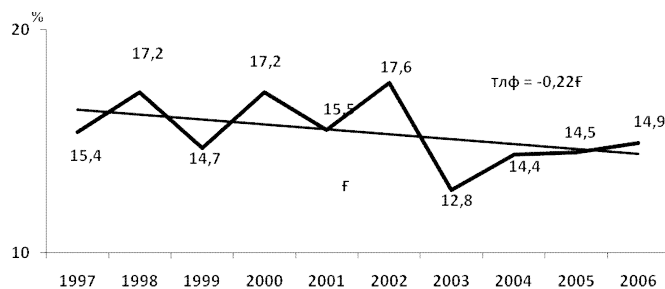


Рисунок 3- Динамика удельного веса больных лимфомами детского населения Казахстана (1997-2006 гг.).

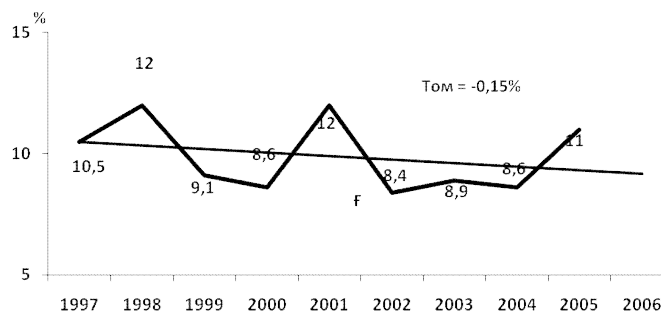


Рисунок 4- Динамика удельного веса больных опухолями мягкой ткани детского населения Казахстана (1997-2006 гг.).

25,0±0,8% и в структуре злокачественных опухолей детского населения занимает первое место. Распределение удельного веса лейкозов в динамике остается относительно стабильной (рисунок 1) с небольшой тенденцией к снижению ($Tл = -0,04\%$). Подобное снижение удельного веса лиц заболевших лейкозами обусловлено в основном недоучетом этих больных в различные годы в республике. Так удельный вес детей лейкозами в 1998 (21,6±2,4%) и 2001-2004 годах (23,6±2,4%, 23,0±2,4%, и 21,3±2,4%, соответственно) были ниже, чем среднереспубликанских данных.

Опухоли ЦНС. Данная форма опухоли в республике зарегистрировано 563 и составил в среднем 19,1±0,7% в структуре злокачественных опухолей детского населения, а занимает второе место и имеет тенденции к росту ($Tцнс = 0,05\%$) в результате улучшения диагностики и учета их в 2000-03 годах в республике (рисунок 2).

Лимфомы. За изучаемый период в республике зарегистрировано 466 больных детей со злокачественными

2006 in Kazakhstan. From them leukaemia - at 739, central nervous system - at 563, Lymphoid neoplasms- at 466, sarcoma of soft fabrics - at 291, tumours of bones - at 270, Wilms' tumor - at 207, neuroblastoma - at 114, tumours of eyes - at 106, Langerhans cell histiocytosis - at 43, tumours of sexual glands at boys - at 57, hepar tumours - at 48 and tumours ovary - at 47 sick children. It is established, that in structure of malignant tumors at children the first place occupies leukaemia (25 %), the second place tumors central nervous system (19,1 %) the third Lymphoid neoplasms (15,8 %) and further on a rank soft fabrics (9,9 %), bones (9,2 %), a tumour of kidneys (Wilms' tumor 7,0 %), etc.

Non-uniform distribution of sick malignant tumors at children in various areas of Republic that is caused with inferiority of the account of sick children is revealed. Hence it is necessary, improvement of the oncological help by the patient of the children's population by increase of detestability and early diagnostics, and also adjustment of full value of the account of malignant tumors of the children's population.

лимфомами (с лимфомой Ходжкина и Неходжкинской лимфомой), что составил в среднем 15,8±0,7% в структуре злокачественных опухолей детского населения и занимает третье место, при этом имеет тенденции к снижению ($Tлф = -0,22\%$) в результате недоучета их в 1999 и 2004-05 годах на территориях республики (рисунок 3).

Опухоли мягкой ткани у детей в республике за 1997-2006 гг. зарегистрировано всего 291 больных злокачественными опухолями мягкой ткани, а в структуре злокачественных опухолей детского населения в среднем составил 9,9±0,4% и занимает четвертое место. При этом доля больных с данной формой опухоли у детей имеет тенденции к снижению ($Том = -0,15\%$) в результате недоучета их, в 1999-2000 и 2002-2004 годах в целом по республике (рисунок 4).

Опухоли кости. Данный вид опухоли у детей в республике за 1997-2006 гг. зарегистрировано всего 270 больных злокачественными опухолями кости, а в структуре злокачественных опухолей детского населения в среднем составил 9,2±0,4% и занимает пятое место. В динамике доля больных с данной формой опухоли у детей имеет тенденции к росту ($Ток = 0,14\%$) (рисунок 5).

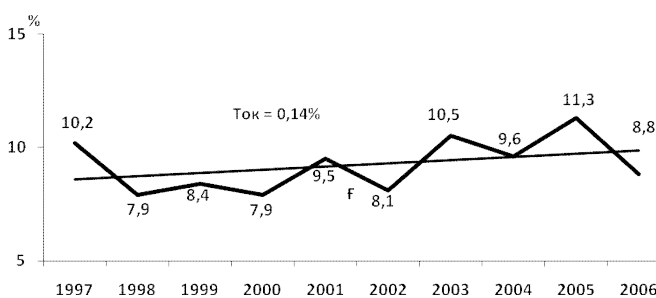


Рисунок 5- Динамика удельного веса больных опухолями кости детского населения Казахстана (1997-2006 гг.).

Обобщенные показатели злокачественных опухолей детского населения Казахстана по нозологическим единицам представлена на рисунке – 6, где установлены определенные закономерности характерные для нашей республики.

Среди злокачественных опухолей различных органов и тканей наиболее часто диагностируется лейкозы (25,0%), опухоли центральной нервной системы (19,1%) и лимфомы (15,8%) которые составляют 59,9% всех онкологических больных детей. Из остальных форм злокачественных опухолей относительно чаще выявляются у детей опухоли мягкой ткани (9,9%) и костей (9,2%), опухоли почек (нефробластома 7,0%). Сравнительно реже нейробластома

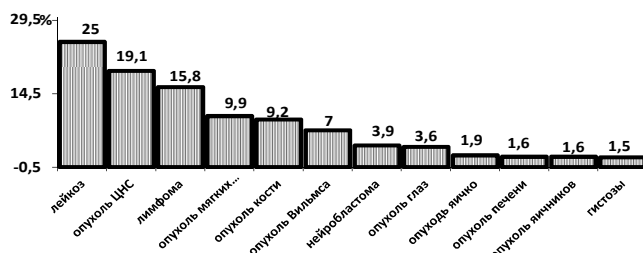


Рисунок 6- Динамика удельного веса больных злокачественными опухолями детского населения Казахстана (1997-2006 гг.).

(3,9%), опухоли глаз (3,6%), а крайне редко встречаются опухоли яичко, печени, яичников и др. Кроме того такие как «типичные» опухоли взрослых - рак желудка, кишечника, молочной железы и др. чрезвычайно редко.

Таким образом, при анализе экстенсивных показателей злокачественных опухолей у детей в Казахстане выявлено: в структуре злокачественных опухолей у детей первые пять место занимает Лейкозы - $25,0 \pm 0,8\%$, второе место ЦНС - $19,1 \pm 0,7\%$, лимфомы третье место $15,8 \pm 0,7\%$, опухоли мягких тканей четвертое - $9,9 \pm 0,4\%$, и опухоли костей $9,2 \pm 0,4\%$ пятое место. Кроме того выявлено неравномерная доля больных злокачественных опухолей у детей в различных областях оказались неодинаковой, что обусловлена с неполноценностью учета больных детей в отдельных регио-

нах Казахстана. Следовательно, необходимо улучшение онкологической помощи больным детского населения путем повышения выявляемости и ранней диагностики, а также налаживания полноценности учета злокачественных опухолей детского населения нашей Республики.

Литература

1. Аксель Е.М., Двойрин В.В. Заболеваемость злокачественными новообразованиями детского населения России. // Матер. Симпозиума по детской онкологии Москва, 20-22 окт. 1993;
2. Двойрин В.В., Дурнов Л.А. Сравнительная заболеваемость злокачественными новообразованиями детского населения стран мира. // М: ОНЦ РАМН. - 1995. С. 70-71.
3. Заридзе Д.Г., Ли Н.А., Мень Т.Х. Заболеваемость детей злокачественными опухолями в четырех областях Казахстана, прилегающих к ядерному полигону // Мед. Радиология - 1993. №11
4. Duncan M.H., Wiggins C.H., Samet J.M., Key C.R. Childhood cancer epidemiology in Mexican American Indians, Hispanic Whites and Nonhispanic Whites, 1970-1982. // J.N.C.I. - 1986- V.76.-R6;
5. Мерабишвили В.М., Старинский В.В. Организация раковых регистров в России // Проблемы современной онкологии (тезисы докладов IV Всероссийского съезда онкологов). Ростов н/Д, 1995. С. 70-71.

Заболеваемость раком молочной железы в Южно-Казахстанском регионе

Досанова Р.Е.

Южно-Казахстанский консультативно-диагностический медицинский центр

Введение

Отмечается тенденция к росту заболеваемости рака молочной железы (РМЖ). По данным ВОЗ, в мире ежегодно заболевают около 1 миллиона женщин раком молочной железы. По данным ЮНЕСКО, ведущей причиной смерти среди молодых женщин в 28 индустриальных странах за последние 10 лет является рак молочной железы. По данным экспертов, в общей структуре онкологической заболеваемости рак молочной железы становится все более серьезной проблемой для казахстанских женщин и занимает 2 место в общей структуре онкопатологии. В целом, как и во всем мире, в Казахстане наблюдается устойчивое увеличение случаев этого заболевания в среднем на 1 - 2% в год, ежегодно выявляется более 3 тыс. случаев РМЖ. Распространенность РМЖ убеждает в необходимости внедрения в практику эффективных методов и международных стандартов профилактики, диагностики и лечения доброкачественных и злокачественных заболеваний молочных желез [Биртанов Е.А., 2011].

Материалы и методы исследования

Материалом исследования послужили данные Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии, касающиеся рака молочной железы.

Результаты исследования

Анализ ретроспективных данных показателей заболеваемости раком молочной железы показал рост контингента больных данной категории за изучаемый период. Так с 2004 года отмечается постепенное увеличение количества случаев выявления РМЖ у женщин от 18528 до в 2008 году – 22965.

За изучаемый период в Казахстане впервые зарегистрировано 28 707 случаев рака молочной железы. Распределение женщин по возрастным группам - до 30 лет – 262 (0,9%) больных, 30–39 лет – 2 090 (7,3%), 40–49 – 7 484 (26,1%), 50–59 лет – 7 466 (26,0%), 60–69 лет – 6 306 (22,0%) и в 70 лет и старше – 5 099 (17,8%). Высокий

Казақстан және Оңтүстік Қазақстан облысында әйелдері арасында барлық онкологиялық аурулардың ішінде сүт безі рагі екінші орында. Осы аурудың тұрақты жағдайда көбеюі 4 сатысы және өлімнің жоғарғы көрсеткіші кеш анықтау салдарынан.

Денсаулық сақтау саласының ұйымдастырушыларына қажеттілікке байланысты табысталды.

Аудан орталықтарында нақтылы ұйымдасқан - әдістемелік іс шараларын жүргізу, сүт безі рагін ерте анықтау және профилактикалар жүргізу.

Рак молочной железы занимает второе место среди всех онкологических заболеваний у женщин в Казахстане в Южно-Казахстанской области (ЮКО). Устойчивое увеличение случаев этого заболевания с 4 стадией и высокие показатели смертности вследствие позднего выявления указывают на необходимость организаторам здравоохранения принять обоснованные организационно-методические мероприятия по раннему выявлению и профилактике рака молочной железы в районных центрах.

Breast cancer ranks second among all cancers in women in Kazakhstan, South Kazakhstan region. Steady increase in cases of breast cancer with a 4-stage and high rates of mortality due to late detection, indicate the need for policy-makers to make informed organizational and methodological measures for early detection and prevention of breast cancer.

удельный вес больных приходился на возрастную группу 40–59 лет (52,1%). Среднегодовые возрастные показатели заболеваемости раком молочной железы имели уни-модальный рост с пиком в 60–69 лет – 115,8±3,60/0000.

Показатель заболеваемости в 30–39 лет в 26,4 раза выше показателя до 30 лет, а в 40–49 лет показатель в 3,8 раза выше. Заболеваемость в 50–59 лет в 1,5 раза выше, чем в 40–49 лет. При этом имеющиеся различия в

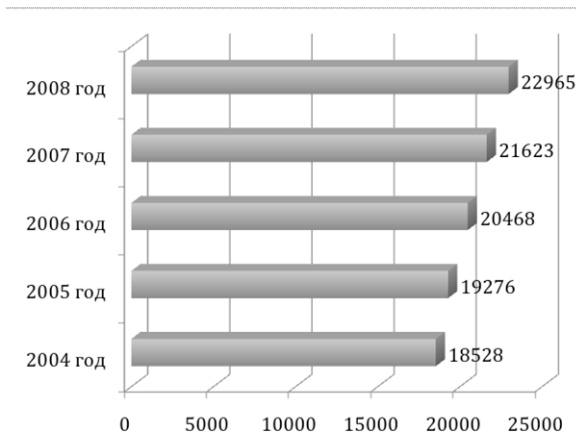


Рис.1- Заболеваемость РМЖ в РК за период 2004-2008 гг.

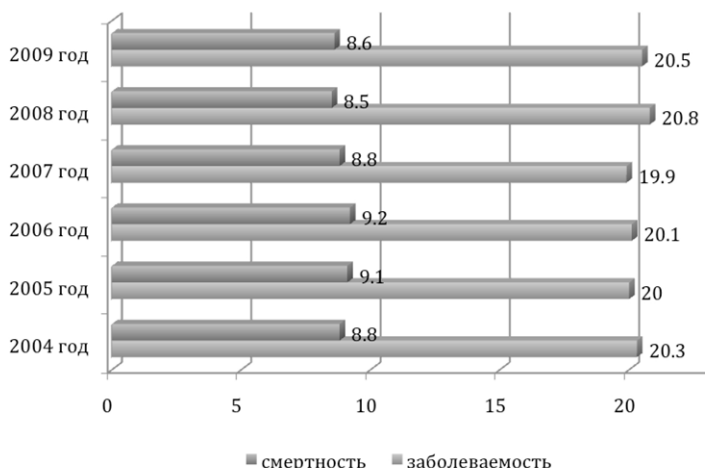


Рис.2 - Заболеваемость и смертность от РМЖ в РК

возрастных показателях заболеваемости РМЖ статистически значимы ($p < 0,05$). В возрастных группах старше 50 лет показатели заболеваемости раком молочной железы не имели статистически значимых различий ($p > 0,05$).

В разрезе областей по Казахстану РМЖ высокие показатели определяются в Павлодарской области, г. Алматы, в Восточно-Казахстанской области в сравнении с Южно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской областью. Возможно, это связано с недостаточной диагностикой на раннем этапе заболевания, информированностью населения. Это подтверждают статистические данные по Южно-Казахстанской области. Так, в городе Шымкенте показатели высокие и имеют тенденцию к росту, тогда как в районах данные низкие (рис.5).

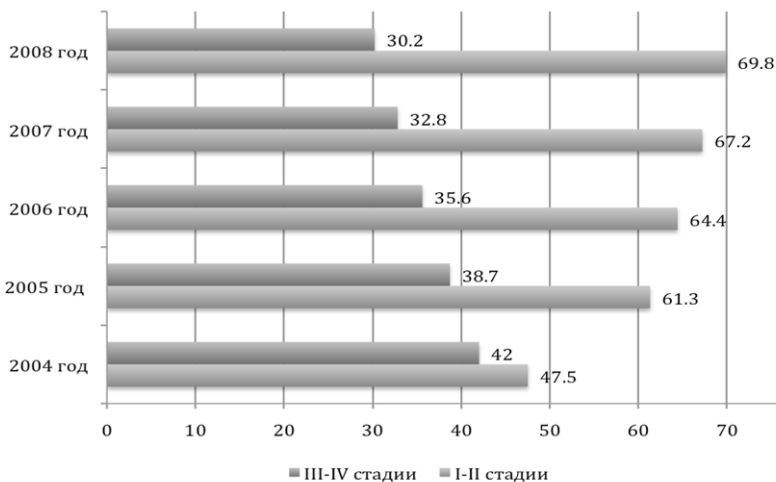


Рис. 3 - Удельный вес показателей ранней и поздней диагностики РМЖ в РК

Таблица – Сравнительные данные некоторых показателей по РК и ЮКО за 2008 и 2009 годы

	годы	Заболеваемость РМЖ (на 100 тыс.нас.)	Ранг	Удельн. вес I-II ст., %	Удельн. вес IV ст., %	Смертность от РМЖ, ‰
РК	2008	20,8	2	60,8	6,3	8,5
	2009	20,5	2	71,1	6,4	8,6
ЮКО	2008	9,6	1	73,9	9,0	5,2
	2009	10,7	2	80,5	8,6	5,3

Таким образом, заболеваемость РМЖ в области ниже, чем в республике в 2 раза как в 2008, так и в 2009 году. Удельный вес I-II стадии РМЖ несколько (на 2,2 и 6,6%) выше в ЮКО, чем в республике, IV стадии — также на 2,7 и 2,4% выше, т.е. запущенных форм РМЖ выше в области. Смертность от РМЖ в ЮКО ниже, чем в республике.

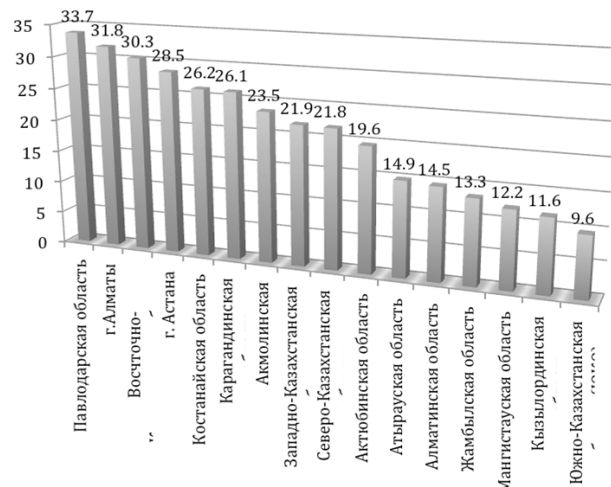


Рис. 4 - Заболеваемость РМЖ в разрезе областей РК за 2008г на 100 тыс. нас

Выводы

Статистические данные в разрезе Республики Казахстан и Южно-Казахстанской области позволяют указать на недостаточную информированность и раннюю диагностику рака молочной железы среди населения в районных центрах.

Литература

1. Биртанов Е.А. Мат. круглого стола «Новые разработки и технологии в диагностике и лечении рака молочной железы – европейские стандарты» АО «Национальный медицинский холдинг». - Астана, 2011.
2. Демографический ежегодник Казахстана. Статистический сборник. – Астана, 2009. – 637 с.
3. Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья и здравоохранения. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. – 180 с.
4. Харченко В.П., Рожкова Н.И. Маммология. Национальное руководство. – М.: Гэотар-Медиа, 2009.
5. Давыдов М.И., Летагина В.П. Практическая маммология. - М., 2005.
6. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2008, 2009 гг. (статистические материалы). - Алматы, 2009, 2010.

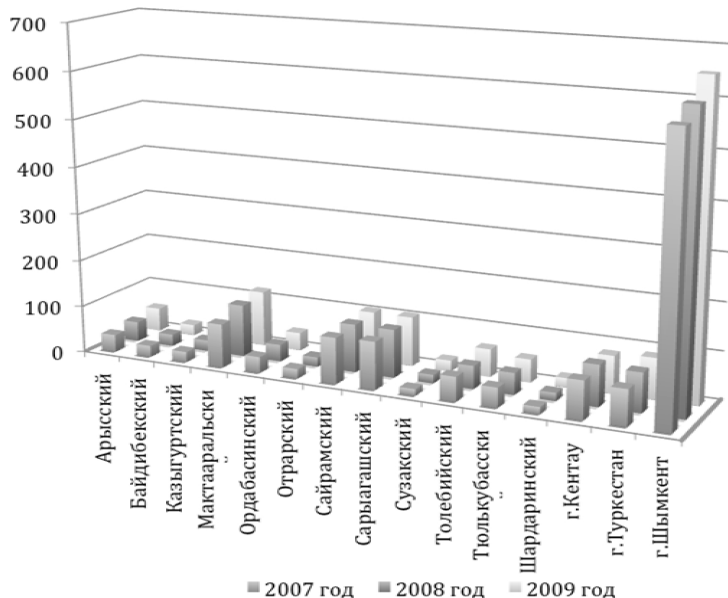


Рис. 5 - Заболеваемость РМЖ в Южно-Казахстанской области по районам за 2007-2009гг.

Динамика показателей онкологической заболеваемости области

Бектурсынов С.М., Голованев Г.А.
ГККП «Областной онкологический диспансер»
г.Талдыкорган

Онкологические заболевания остаются одной из самых актуальных проблем современной медицины Казахстана.

Актуальность

Анализ динамики заболеваемости злокачественных новообразований играет огромное значение для определения потребности населения страны в онкологической помощи и разработке перспективных планов технического и лекарственного обеспечения подготовки кадров и планирования всего комплекса противораковых мероприятий. В связи с чем, профилактика, раннее выявление и лечение злокачественных новообразований, является одним из важных и сложных разделов современной медицины, которая определяется их сложностью, масштабностью и социальной значимостью.

Цель

Анализ динамики заболеваемости злокачественными новообразованиями населения Алматинской области

Материалы и методы исследования

При анализе результатов исследования установлено, что в течение последних 5 лет отмечались своеобразные колебания в структуре заболеваемости. Если в 2007 году отмечалось снижение показателей заболеваемости, то в 2008 году отмечалось его повышение, а в 2009 году вновь снижение. В структуре онкопатологии лидирующую позицию занимает рак легкого, составляет 12,6 на 100 000 населения (РК 20,5), на втором месте рак желудка 10,8 % (РК 20,5) и на 3 месте остается рак молочной железы, заболеваемость

Мәселенің маңыздылығы. Соңғы жылдары қатерлі ісіктерімен аурушандықтың және өлім-жітімінің құрылымының өзгеруі орын алуда.

Мақсаты- 2006-2010 ж.ж. аралығында қатерлі ісік аурушандығына баға беру, оның бағытын анықтау. Қатерлі дертімен ауырған адамдардың құрылымында бірінші орынға өкпе 12,6 100 000 тұрғынға шаққанда (РК 20,5), екінші асқазан 10,8 (РК 20,5), үшінші сүт безі қатерлі ісігі 10,4 (РК 17,4).

Соңғы бес жыл көлемінде ауру мөлшері 10,0 % 2010 жыл өлім-жітім 3,6 төмендеді

которой равна 10,4 (РК 17,4). В структуре смертности 42 % занимает рак легкого, желудка, пищевода.

Выводы

1. За последние 5 лет в структуре заболеваемости злокачественными заболеваниями по Алматинской области отмечается снижение уровня заболеваемости на 10,0 % в 2010 году в сравнении с 2005 годом, показатель смертности снизился на 3,6 %.

2. За отчетный период показатель пятилетней выживаемости увеличился с 48,1 % до 54,7 %, он наиболее отчетливо характеризует работу онкологической службы областного онкологического диспансера г.Талдыкорган и указывает на качество организации онкологической службы области. Таким образом, только слаженная работа всех подразделений здравоохранения, позволяет улучшить все показатели онкологической службы и значительно улучшить качество жизни онкологических больных.

Организация деятельности специализированных консультативно-диагностических отделений онкологических диспансеров

Нургазиев К.Ш., Байпеисов Д.М., Сейтказина Г.Д., Жылкайдарова А.Ж.
Казахский НИИ онкологии и радиологии, г.Алматы

Введение

Доказано, что скрининг-исследования являются одним из основополагающих принципов раннего выявления заболеваний. В Казахстане с 2008 года внедрены скрининговые осмотры целевых групп населения, направленных на профилактику и раннее выявление предопухолевых и опухолевых заболеваний молочной железы, шейки матки.

Полученные результаты выявили ряд проблем и показали необходимость систематизации проводимых мероприятий, как с позиций медицинской результативности, так и экономической эффективности. В связи с этим появилась необходимость проведения структурных преобразований в онкологической службе с выделением подразделения, обеспечивающего качество внедрения скрининговых осмотров.

Цель

- определить задачи, направления работы, структуру и функциональные обязанности сотрудников специализированных консультативно-диагностических отделений онкологических диспансеров.

Материалы и методы

Рассматриваются положения приказа Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 12 августа 2011 года № 540 «Об утверждении «Положения о деятельности организаций здравоохранения, оказывающих онкологическую помощь населению Республики Казахстан».

Результаты

Региональные специализированные консультативно-диагностические отделения (далее – рСКДО) являются структурными подразделениями соответственно республиканской, областной, региональной, городской онкологической организации и обеспечивают постановку организационно-методической работы по вопросам проведения скрининговых программ, направленных на снижение смертности от онкологических заболеваний.

Структурными подразделениями рСКДО являются следующие кабинеты (отделы):

1) маммографический кабинет (отдел) скрининга рака молочной железы – осуществляет организацию мероприятий для проведения маммографических скрининговых осмотров среди женщин по раннему выявлению рака молочной железы в регионе. В рентгеномаммографическом кабинете скрининга рака молочной железы проводится повторная интерпретация маммограмм, сделанных по скринингу в медорганизациях уровня ПМСП, двумя врачами-рентгенологами (лучевой диагностики молочных желез), архивирование скрининговых маммограмм, по показаниям – уточненная лучевая диагностика с применением инвазивных процедур (биопсии) на выявление рака молочной железы;

2) цитологический кабинет (отдел/лаборатория) скрининга рака шейки матки – осуществляет организацию ме-

Мақалада «Қазақстан Республикасының халқына онкологиялық жәрдем көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарының жұмысы туралы Ережесін» бекіту туралы» 16 тамыз 2010 жылғы Қазақстан республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің № 540 бұйрығына сәйкес онкологиялық диспансерлер базасында құрылған онкологиялық диспансерлерінің арнайы кеңес-диагностикалық бөлімдер мамандарының қызметтік міндеттері мен структурасы, жұмыс бағыты, мақсатары ұсынылған

В статье представлены задачи, направления работы, структура и функциональные обязанности сотрудников специализированных консультативно-диагностических отделений онкологических диспансеров, организованных на базе онкологических диспансеров в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 12 августа 2011 года № 540 «Об утверждении «Положение о деятельности организаций здравоохранения, оказывающих онкологическую помощь населению Республики Казахстан».

Objectives, work directions, structure and functional duties of employees for specialized advisory-diagnostic units are presented. These units are organized in oncologic dispensaries according to the MOH Order # 540, August, 12, 2011 «About the statement «Activity of the health care organizations rendering the oncologic help to the population of Republic Kazakhstan».

роприятий для проведения скрининговых осмотров среди женщин целевых групп на выявление рака шейки матки в регионе путем проведения цитологических исследований. Цитологический кабинет (отдел/лаборатория) скрининга рака шейки матки является одновременно централизованной цитологической скрининговой лабораторией, где сконцентрированы все профилактические цитологические исследования (Пап-тест) в области/городе женщин, обследованных по скринингу. На базе цитологического кабинета (отдела/лаборатории) скрининга рака шейки матки проводится окрашивание мазков, интерпретация цитогамм и их архивирование, создаются кольпоскопические смотровые кабинеты для проведения по показаниям уточняющей диагностики на рак шейки матки;

3) кабинет (отдел) скрининга колоректального рака – осуществляет организацию мероприятий для проведения скрининговых осмотров среди населения на раннее выявление колоректального рака в регионе. В составе кабинета (отдела) скрининга колоректального рака находится эндоскопический (колоноскопический) кабинет, где проводится по показаниям уточненная углубленная диагностика на колоректальный рак.

4) кабинет (отдел) скрининга рака предстательной железы – осуществляет организацию мероприятий для проведения скрининговых осмотров среди мужчин на раннее выявление рака предстательной железы;

5) эндоскопический кабинет (отдел) скрининга рака желудка – осуществляет организацию мероприятий для проведения скрининговых осмотров среди населения целевых групп на раннее выявление рака желудка в регионе. В составе эндоскопического кабинета (отдела) находится эндоскопический (гастроскопический) кабинет, где проводится по показаниям уточненная диагностика – видеогастроскопия с биопсией;

6) организационно-методический кабинет (отдел), являясь структурным подразделением СКДО, обеспечивает постановку всей организационно-методической работы по вопросам организации скрининговых программ среди населения на раннее выявление онкологических заболеваний.

Задачами региональных СКДО (областных, региональных, городских онкологических диспансеров) являются:

1) осуществление организационно-методического руководства по всем вопросам, связанным со скрининговыми программами в области, регионе, городе;

2) координация работы гинеколога, цитолога, рентгенолога, маммолога, уролога, хирурга-проктолога, врача эндоскопического кабинета, патоморфолога, главного акушера-гинеколога города/области, главного рентгенолога города/области, главного хирурга города/области, главного уролога города/области, мультидисциплинарных групп по проведению качественного обследования женщин и мужчин города/области в рамках скрининга и контролю лечения;

3) проведение углубленного и уточняющего обследования населения, направленного в рамках выполнения скрининга;

4) организация и проведение архивирования скрининговых маммограмм и цитологических микропрепаратов с обязательным созданием маммографического и цитологического архива на базе СКДО.

5) проведение анализа состояния скрининговых программ на территории обслуживания и разработка ежегодных и перспективных планов их развития;

6) планирование и организация методической работы для скрининговых программ на территории обслуживания;

7) осуществление связи и координация планов работы с республиканским СКДО на базе Республиканского онкологического центра;

8) оказание организационно-методической помощи лечебно-профилактическим организациям, проводящим работу по скрининговым осмотрам;

9) определение обеспеченности врачебными кадрами, составление перспективных планов по повышению квалификации врачей, работающих в скрининговых программах;

10) разработка и проведение мероприятий по повышению квалификации врачей СКДО, лечебно-профилактических организаций по онкологии, планирование и руководство санитарно-просветительной работы по скрининговым программам на обслуживаемой территории;

11) составление статистических отчетов по скринингу с предоставлением их в республиканский СКДО в установленные сроки.

Оснащение рСКДО проводится в соответствии с Примерным перечнем оборудования и медицинского инструментария, согласно перечисленному списку. Ниже представлены перечень минимального оборудования для кабинетов (отделов) скрининга рака молочной железы, шейки матки, простаты, пищевода, желудка и колоректального рака.

Минимальное оборудование для рентгеномаммографического кабинета (отдела) скрининга рака молочной железы:

1) маммограф (дигитальный) с приставками для при-

цельной маммографии и под прямым увеличением, с набором кассет, проявочной машиной;

2) роллер-негатоскопы, лупы; маммографические негатоскопы (со шторками);

3) аппарат ультразвукового исследования последнего поколения с поверхностным датчиком для проведения исследований молочных желез (10МГц и выше), оснащенный доплером, программами объемной визуализации;

4) дигитальная приставка для стереотаксической биопсии;

5) рентгенаппарат специального назначения для проведения рентгенограмм микро- и макропрепаратов, полученных в результате трепан-биопсии, операционного материала;

Минимальный перечень оборудования и аппаратуры для оснащения кабинета (отдела) скрининга рака шейки матки:

1) автомат для окраски цитологических препаратов или автоматизированная система для ранней диагностики рака шейки матки (Pap-тест);

2) аппарат для жидкостной цитологии;

3) центрифуга "Cytospin";

4) вытяжной шкаф для цитологических исследований;

5) аппарат для получения дистиллированной воды;

6) микроскоп бинокулярный с иммерсией и с выводом изображения на экран (с фотографирующим устройством);

7) холодильник.

Минимальный перечень оборудования и аппаратуры для оснащения кабинета (отдела) скрининга рака предстательной железы:

1) аппарат ультразвукового исследования последнего поколения оснащенный доплером, программами объемной визуализации, с трансректальным датчиком для проведения исследований простаты;

2) цистоскоп;

3) пистолет для пункционной биопсии;

Минимальный перечень оборудования и аппаратуры для оснащения эндоскопического кабинета отдела скрининга колоректального рака и скрининга рака желудка:

1) видеоэндоскопическая стойка с высокой разрешающей способностью и широкоформатным монитором, общий для гастроскопа и колоноскопа;

2) видеоэндоскоп с функцией увеличения (2 шт.);

3) колоноскоп с видеостойкой (общей);

4) цифровая аппаратура для записи эндоскопических исследований (компьютер, DVD);

5) набор инструментов для забора морфологического материала, петлевой биопсии, эндоскопической остановки кровотечений;

6) электрохирургический блок, совмещенный с эндоскопической стойкой;

7) аппарат для мойки и дезинфекции эндоскопов и инструментов;

8) стол для проведения эндоскопических исследований;

9) медицинский столик для медикаментов;

10) отсос медицинский;

11) шкаф для хранения инструментов и аппаратов;

12) холодильник.

Оборудование и аппаратура для оснащения дополнительных подразделений должно проводиться в соответствии с имеющимися нормативными документами. Перечень может быть существенно расширен в зависимости от использования методик исследований.

Предложенный порядок работы рСКДО с дальнейшим приведением в соответствие штатной структуры отдела (отделения) позволит повысить качество и эффективность проводимых скрининговых осмотров.

Программа ранней диагностики рака простаты в РК

Нургазиев К.Ш., Нурғалиев Н.С., Ишкинин Е.И.

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии (КазНИИОиР),

г. Алматы, Республика Казахстан

Введение

Широкое распространение рака предстательной железы (РПЖ) ставит его в ряд наиболее важных социальных проблем современности. Болезнь практически не возникает раньше 40 лет и становится все более частым явлением с каждым последующим десятилетием жизни. Существует настоятельная необходимость в разработке методов, которые могли бы обеспечить раннее выявление заболевания и значительно повысить эффективность лечения. Несмотря на многие усилия, ожидать полного предотвращения развития рака или радикальных шагов в борьбе с болезнью на распространенных стадиях, по крайней мере в ближайшем будущем, к сожалению, не приходится. На данный момент способов полного излечения распространенного рака простаты нет. Ряд исследований показали, что, несмотря на успехи фармакологии в разработке антиандрогенных препаратов, за последние 50 лет применения гормональной терапии не было отмечено выраженного снижения смертности от рака простаты. Надежды сократить число смертей от рака простаты основаны на двух тактиках: ранней диагностике и эффективном лечении болезни в ее начальной стадии.

Рак предстательной железы - одна из ведущих причин смерти мужчин пожилого возраста от злокачественных опухолей в мире. В структуре заболеваемости среди всех ЗН в мире, РПЖ занимает 2-ое ранговое место (13,6%). Ежегодно выявляется 903.452 больных РПЖ. В структуре смертности среди всех ЗН в мире, РПЖ занимает 6-ое ранговое место (6,1%). Ежегодно умирает 258.381 больных РПЖ (по данным Globocan 2008). По прогнозам ВОЗ к 2030 гг. заболеваемость и смертность от РПЖ во всем мире возрастет в 2 раза

В последние годы имеется тенденция к увеличению заболеваемости раком предстательной железы в нашей республике. Если в 2001 году с впервые в жизни установленным диагнозом РПЖ взято на учет 534 мужчин (3,6 на 100000 населения), то в 2010 г – 677 (4,2 на 100000 населения); сохраняется высокая смертность среди больных раком простаты, которая в динамике нарастает: в 2001г – 296 человека (2,0 на 100000 населения) в 2010 г - 352 (2,2 на 100000 населения). В структуре смертности ЗН у мужчин, РПЖ занимает 5-е ранг. место (5%); Отношение заболеваемости к смертности у больных РПЖ в РК - 1,86. Для примера в среднем в мире этот показатель равен 3,1; а в Европе 7,1. Показатель одногодичной летальности у больных РПЖ на сегодняшний день в РК равен 22,1%. Всего на учете состоит 2618 больных РПЖ. Несмотря на то, что это сравнительно частая онкопатология (в структуре заболеваемости ЗН у мужчин, РПЖ занимает 6-е ранг. место - 5%), у больных РПЖ - самые низкие показатели 5-летней выживаемости среди всех онкологических нозологий. Всего 32,4% больных переживают 5-ти летний рубеж. При анализе заболеваемости РПЖ в РК выясняется, что отмечается высокая запущенность при впервые установленном диагнозе на протяжении последних 10 лет – в 2001г в III-IV стадии выявилось 76,1% больных РПЖ, в 2010г в III-IV стадии выявилось 63,3% больных [1]. Из этого становится совершенно очевидным факт, что заболеваемость РПЖ в нашей стране намного выше за счет не выявленного локализованного рака.

Простата безінің қатерлі ісігі — орта және кәрі жастағы еркектерде кездесетін онкологиялық жаңа түзілімдердің ішінде жиі кездесетін аурулардың бірі. Диагнозды қойғаннан кейінгі науқастардың бірінші жыл ішіндегі өлімі 30% құрап отыр, яғни бұл дерттің бастапқы сатыларында анықталудың өте төмен екендігін көрсетеді. Есепте тұрған науқастардың жалпы саны 2198. Қазақстандағы простата безінің қатерлі ісігіне шалдыққан науқастардың ішінде 69% 3-4 сатысында анықталады. Бұған қарап біздің елімізде простата безінің қатерлі ісік дертіне шалдығуының анықталмаған жергілікті рак есебінен әлдеқайда жоғары екендігі анық. Простата безінің қатерлі ісігінің өсу тенденциясын, жаңадан есепке алынған науқастардың ішінде асқынған түрлердің көп екендігін ескеріп (шамамен 70%), елімізде простата безі қатерлі ісігінің скрининг бағдарламасын енгізу жоспарланып отыр. Бұл бағдарламаның енгізілуі дерттің ерте сатыларында анықталуына жәрдем жасап, науқастарды толық емдеп шығуға, болмаса өмірін максималды ұзартуға жағдай туғызады. Анықталған қауіпті топтағы еркектерде әрі қарай дерттің бар-жоғын тексеру үшін тікелей зерттеу жүргізіледі.

В последние годы отмечается рост интереса к разработке и проведению широкомасштабных скрининг-программ, направленных на раннюю диагностику рака простаты. Его целью в первую очередь является снижение смертности через повышение ранней диагностики и улучшения результатов лечения. Разработан пилотный проект проведения скрининга рака простаты в Восточно-Казахстанской области. В данной статье представлено обоснование программы ранней диагностики рака простаты, ее характеристика, а также ожидаемые результаты.

In recent years there has been increasing interest in the development and implementation of large-scale screening programs aimed at early detection of prostate cancer. It's goal in the first place is to reduce mortality by improving early detection and improved treatment outcomes. A pilot project of screening for prostate cancer in the East Kazakhstan region. This paper presents a study of screening for prostate cancer, their characteristics, as well as the expected results.

Таким образом, в РК отмечается тенденция к росту заболеваемости, высокие показатели смертности от РПЖ. Последняя обусловлена поздней диагностикой РПЖ и большим числом наблюдаемых пациентов с местнораспространенными и диссеминированными формами РПЖ, лечение которых требует больших медицинских ресурсов и экономических затрат [2].

Международный опыт проведения скрининговых исследований

В мире было произведено 2 крупных мультицентровых рандомизированных исследований скрининга рака

простаты: Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian (PLCO) Cancer Screening Trial, было проведено в США и European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC) в Европе. Исследование Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian (PLCO) Cancer Screening Trial, было проведено в США в 10 штатах, включало 76693 пациента в возрасте 55-74 лет; скрининг проводился с использованием исследования крови на простат-специфичный антиген (ПСА) (4 штата) и пальцевого ректального исследования (6 штатов). Первые годы активного скрининга в США продемонстрировали выраженный рост заболеваемости, что стало отражением диагностики большого числа occultных форм, но уже к 1995 году показатели значительно снизились и до настоящего времени колеблются в одних и тех же пределах. Параллельно отмечен некоторый рост смертности в доскрининговые годы с последующим стойким снижением, сохраняющимся до настоящего времени. Так, с 1975 по 1987 годы сохранялся ежегодный рост смертности на 0,9%, а за период 1987-1991 – на 3%. Однако при сравнении до-скрининговой (1987 – 1992) и пост-скрининговой (1993- 1997) 5-ти летки видно что общая смертность от РПЖ снизилась с 34.000 человек до 19.000. Снижение началось с 1991 года и составило около 0,4% ежегодно, а с 1994 года темп снижения увеличился до 4,1% ежегодно [3]. Достоверно доказан факт снижения выявляемости запущенных форм РПЖ в скрининге, отношение локализованных форм РПЖ к распространенным растет. В США за период с 1991 по 2006 год обнаружение метастатического рака предстательной железы снизилось с 21,6 до 7,0 заболевших на 100000 мужчин и составляет 12% от всех впервые выявленных случаев [4].

В исследование European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC) вошло 162243 мужчины в возрасте 55- 69 лет, скрининг только на основании ПСА проводился каждые 4 года. После 9 лет наблюдения уровень смертности от РПЖ в группе скрининга был ниже на 20%, а при 10- летнем надлюдении на 30% меньше смертность чем в контрольной группе, при дальнейшем наблюдении показатель будет увеличиваться. Однако существует большой риск гипердиагностики, многие исследователи ставят под сомнение необходимость проведения широкомасштабного популяционного скрининга, в виду больших экономических затрат. Так чтобы предотвратить 1 смерть от рака простаты, необходимо обследовать (NNS) - 1,410 пациентов; необходимо лечить (NNT) – 48 пациентов [5]. Отдел ERSPC в Швеции добился снижения смертности от рака простаты в скрининговой группе за 14 лет наблюдения до 44% среди всех мужчин, и на 77% у мужчин моложе 60 лет [6].

Цель исследования

За последние годы затраты на лечение РПЖ только возросли. Поэтому разработка и внедрение в клиническую практику программ ранней диагностики РПЖ является не только важной медицинской, но большой социальной и экономической задачей государственного значения. В соответствии с Государственной программой развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011 – 2015 годы, утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 29 ноября 2010года № 1113 *“усиление профилактических мероприятий, скрининговых исследований, совершенствование диагностики, лечения и реабилитации основных социально-значимых заболеваний”*. а также учитывая общую ситуацию по выявляемости рака предстательной железы в РК (тенденция к росту заболеваемости, высокая запущенность, низкие показатели 5-летней выживаемости) необходимо начать подготовку к проведению программы по ранней диагно-

стике (скрининга) рака предстательной железы в нашей республике.

Материалы и методы исследования

С целью определения эффективности предлагаемой программы по ранней диагностики решено начать ее в виде пилотного проекта в ВКО.

- Вид скрининга: популяционный скрининг в Восточно-Казахстанской области (ВКО)

- Контингент – мужчины 46 – 64 лет (в ВКО - 147.302). Целевые группы 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 лет, т.е. на обследование приглашаются мужчины данных возрастных групп).

- Метод скрининга: иммунно- ферментный анализ (ИФА) крови на ПСА

- Уточняющая диагностика: пальцевое ректальное исследование (ПРИ), трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ), секстантная пункционная биопсия, гистологическое исследование

- Интервал: 1 раз в 2 года (75.000 в год)

- Срок действия: постоянно

- Интерпретация гистологических заключений: в соответствии с общепринятыми международными стандартами и классификацией с указанием суммой баллов по Глиссону.

Обоснование места проведения пилотного скрининга РПЖ

Степень готовности РК к проведению скрининговой программы РПЖ можно отразить с помощью выполнения в регионах метода скрининга (ИФА анализ крови на ПСА) и уточняющей диагностики: ПРИ, ТРУЗИ, секстантная пункционная биопсия, гистологическое исследование в регионах. К сожалению не все регионы РК готовы к проведению скринингового исследования по причине недостаточной оснащенности мед. организаций и онкодиспансеров в РК аппаратами для ИФА ПСА, аппаратами с ТРУЗИ датчиками и пистолетами для пункционной биопсии. Также в связи с низкой плотностью населения в РК 5,7 чел./км² (184 место в мире) и наличием отдаленных районов нецелесообразно проведение повсеместной скрининговой программы. Решено провести пилотный проект скрининга РПЖ в ВКО. В этой области, показатели заболеваемости (7,7 на 100.000 человек) и смертности (3,9 на 100.000 человек) почти в 2 раза превышают среднереспубликанские. По смертности от РПЖ, ВКО находится на первом месте в РК, а по заболеваемости на втором. ВКО по численности населения и площади в 10 раз меньше нашей республики, отмечается такая же низкая плотность населения - 5,0 чел./км². В состав области входят: 15 районов, 10 городов (59% населения в области), 30 поселков, 870 сельских населённых пунктов. В плане материально- технической базы и кадровых ресурсов ВКО лучше всех областей готова к проведению скрининга. В ВКО уже накоплен успешный опыт раннего выявления РПЖ.

Обоснование контингента скрининга РПЖ

Проведен анализ частоты встречаемости РПЖ в той или иной возрастной категории мужчин в РК с 2006 по 2010гг. представлены на рис. №1

Рис.№1 Впервые выявленные случаи РПЖ в РК 2006 – 2010гг.

Учитывая, что больных с РПЖ в возрастной группе до 45 лет выявляется незначительное количество, за нижнюю границу скрининга взят возраст 46 лет. За верхнюю границу скрининга взят возраст 64 года, с учетом средней продол-

жительности жизни у мужчин в РК - 63,6 года. На возраст 70 – 72 года приходится пик заболеваемости РПЖ. Программа ранней диагностики направлена на выявление рака в доклинической стадии. Считается, что от момента появления до развития клинических проявлений в среднем проходит 10 лет. Целесообразно выявление рака простаты у мужчин с ожидаемой продолжительностью жизни не менее 10 лет. В РК городские мужчины в среднем не доживают до пенсии, поскольку ожидаемая продолжительность жизни у них составляет всего 62,8 лет, в сельской местности аналогичные показатели у мужчин составляют 64,7 лет.

Обоснование метода скрининга

Общепринятыми методами диагностики при проведении скрининга являются определение ПСА и ПРИ [7]. Но, учитывая географические особенности, отдаленность районов, нехватку кадров решено проводить исследование только на основании ПСА [8]. Тест характеризуется хорошей воспроизводимостью, высокой чувствительностью, неинвазивностью, сравнительно небольшой стоимостью и позволяет обследовать многочисленные группы мужского населения [9]. Выполнение теста не требует непосредственного контакта исследуемого с врачом, что делает анализ еще более привлекательным для массового применения. Обычно верхней границей нормы считают ПСА=4,0 нг/мл, однако, в последние годы прослеживается тенденция к детальному обследованию лиц с меньшим уровнем ПСА вплоть до 2,5 нг/мл. Для того, чтобы дифференцировать повышение ПСА, вызванное воспалительными процессами, от увеличения ПСА, обусловленного злокачественной опухолью предстательной железы, рекомендуется повторное выполнение теста после курса антибактериальной терапии. Противовоспалительное лечение в течение 3–4 нед обычно приводит к нормализации ПСА у больных простатитом; при раке предстательной железы уровень антигена под влиянием антибактериальных препаратов не уменьшается. Особое внимание следует обратить на то, что у части больных раком предстательной железы уровень ПСА не превышает нормальных значений. Согласно данным ряда исследователей [10], доля больных раком предстательной железы, имеющих ПСА ниже 4 нг/мл, может достигать 23%, поэтому в нашем исследовании при значениях ПСА>3 нг/мл больной будет направляться к урологу или онкоурологу, где и будет проводиться дальнейшее обследование (ПРИ-пальцевое ректальное исследование; ТРУЗИ; биопсия простаты)

Сборные данные исследований [11]

Если учесть, что количество мужчин в предполагаемом исследовании возрастной группы 46–64 в ВКО около 150.000 человек, то с учетом прохождения скрининга только целевых групп, за год подлежат ИФА анализу ПСА 75.000 мужчин. Ожидаемое количество повышенного количества ПСА (>3 нг/мл) составит 15.000 (т.е. 20%), им потребуется проведение биопсии простаты.

Выводы

При положительных результатах проведенной пилотной программы скрининга в ВКО, а также после дооснащения материально-технической базы, и обучения специалистов занимающихся диагностикой РПЖ, во всех регионах РК, будет внедрена республиканская программа по скринингу РПЖ. Были сделаны важные выводы, имеющие и клиническое и экономическое значение:

Скрининг РПЖ снижает смертность от социально-значимого заболевания

Скрининг РПЖ экономически эффективен, несмотря на затраты;

Скрининг РПЖ и выявление заболевания на ранних

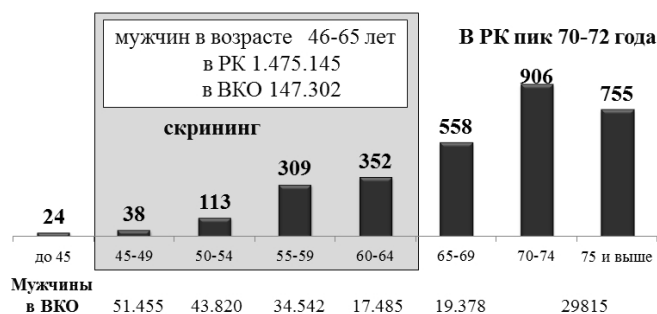


Таблица №1. Чувствительность и прогностическая ценность методов скрининга РПЖ и их сочетаний.

Метод	Чувствительность %	Прогностическая ценность положительного результата %
ПСА	78	29
ПРИ	51	27
ТРУЗИ	52	24
ПСА + ПРИ	93	23
ПСА + ТРУЗИ	94	22
ПРИ + ТРУЗИ	69	21
ПСА + ПРИ + ТРУЗИ	100	20

стадиях экономически эффективнее лечения РПЖ на поздних стадиях;

Лечение РПЖ, эффективное с позиций медицины, приводящее к сохранению жизни и восстановлению работоспособности, экономически целесообразно.

Преимущества скрининга РПЖ для РК:

- Снижение смертности от рака предстательной железы.

- Совершенствование подготовки медицинских кадров, развитие медицинской науки

- Повышение онконастороженности, доступности, качества, преемственности медицинской помощи на уровне ПМСП

- Усиление межсекторального и межведомственного взаимодействия по вопросам охраны здоровья граждан

Преимущества скрининга РПЖ для медицинских организаций:

- Улучшение материально-технической базы организаций здравоохранения

- Выявление ранних стадий РПЖ, снижение уровня выявляемых поздних стадий.

- Наличие простых методов обследования (ПСА, пальцевое исследование предстательной железы)

- Консолидация урологов общей лечебной сети и онкоурологов

- Выявление и учет прочих заболеваний простаты

Преимущества скрининга РПЖ для пациентов:

- Тестирование на ПСА может помочь в выявлении рака простаты на ранней стадии

- Тест ПСА относится к неинвазивным и быстроисполнимым

- В случае успешного лечения в результате получения положительного (то есть подозрительного) теста ПСА будут более высокие шансы на излечение и возможно продлят жизнь.

- Если опухоль будет обнаружена на ранней стадии и лечение будет успешным, есть вероятность того, что удастся избежать развития метастазов опухоли

Ожидаемые результаты скрининга РПЖ

Достоверного изменения структуры заболеваемости следует ожидать не ранее, чем через 5 лет планомерного осуществления программы.

Реального уменьшения смертности от РПЖ можно добиться не менее чем через 10 лет планомерного

скрининга.

Рост уровня 5-летней выживаемости

Высокий риск гипердиагностики (NNS - 1,410; NNT – 48 пациентов, ERSPC).

В первые годы скрининга увеличение числа пациентов с местнораспространенным и диссеминированным РПЖ и, соответственно, возрастают затраты на их лечение. В последующем в основном выявляются локализованные формы. Доля локализованных форм РПЖ увеличится с сегодняшних 30-40% до 50-60% и выше, а суммарные затраты на лечение последовательно снизятся.

При повторных скринингах – тенденция к смещению более благоприятных стадий заболевания и морфологических степеней злокачественности

Уменьшение частоты осложнений и инвалидности от рака простаты

В последующих турах агрессивный РПЖ встречается реже, чем в 1ом туре

Список использованной литературы

1. Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Ж. и соавт. Показатели онкологической службы Республики Казахстан, статистические материалы 2001-2010гг.
2. Illic D., O'Connor D., Green S., Wilt T. Screening for prostate cancer: a Cochrane systematic review. *Cancer Causes Control.* – 2007. – Vol.18. – P.279-285.

3. Wolf Andrew M.D., Wender R.C., Etzioni R. B. et al. American Cancer Society Guideline for the Early Detection of Prostate Cancer: Update 2010 // *CA Cancer J. Clin.* – 2010. – Vol. 60. – P.70-98.
4. Horner M., Ries L., Krapcho M. et al. SEER Cancer Statistics Review, 1975–2006. Bethesda, MD: National Cancer Institute 2009.
5. Schröder F.H., Hugosson J., Roobol M.J. et al. ERSPC Investigators. Screening and prostate cancer mortality in a randomized European study // *N. Engl. J. Med.* – 2009. – Vol.360. P.1320-1328
6. Hugosson J., Carlsson S., Aus G, Bergdahl S, Khatami A. et al. Mortality results from the Göteborg randomised population-based prostate-cancer screening trial. *Lancet Oncol.* 2010 Aug;11(8):725-32. Epub 2010 Jul 2.
7. Polascik T.J., Oesterling J.E., Partin A.W. Prostate specific antigen: A decade of discovery – what we have learned and where we are going // *J. Urol.* – 1999. – Vol. 162, №2. – P. 293–306.
8. Brawer M.K. The Diagnosis of Prostatic Carcinoma // *Cancer (Philad.)*. – 1993. – Vol. 71. – №3. – P. 899–905.
9. Djulbegovic et al 2010 Screening for prostate cancer: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials *BMJ.* 2010; 341: c4543.
10. Carter HB, Kettermann AE, Ferrucci L, Landis P, Track BJ, Metter EJ. Prostate specific antigen testing among the elderly: when to stop. *J Urol* 2008;179 (Suppl):600, abstract 1751.
11. Roobol MJ, Grenabo A, Schroder FH, Hugosson J. Interval cancers in prostate cancer screening: comparing 2- and 4-year screening intervals in the European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer, Gothenburg and Rotterdam. *J Natl Cancer Inst* 2007;99(17): 1296–303.

Программа ранней диагностики колоректального рака в РК

Нургазиев К.Ш., Ижсанов Е.Б., Кузикеев М.У., Лаишул С.В. Джуманов А.И.

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии (КазНИИОнР),
г. Алматы, Республика Казахстан.

Введение

По данным эпидемиологических исследований в последние десятилетия в большинстве цивилизованных стран мира отмечается неуклонное увеличение показателей заболеваемости населения колоректальным раком (КРР). КРР является широко распространенной в мире патологией, ежегодная заболеваемость достигает 1 миллиона случаев, а ежегодная смертность превышает 500.000. Сегодня в большинстве стран Европы, Азии, США КРР занимает первое место среди злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта, является второй по частоте злокачественной опухолью у мужчин (после бронхолегочного рака) и третьей – у женщин (после бронхолегочного рака и рака молочных желез). По прогнозам экспертов, абсолютное число случаев КРР в мире в следующие два десятилетия увеличится в результате роста населения в целом и его старения как в развитых, так и в развивающихся странах. Показатели заболеваемости КРР сегодня достигают 85-90 на 100 тыс. населения, возрастая с 24,9 на 100 тыс. населения в возрастной группе до 50 лет – до 249,7 на 100 тыс. населения среди пациентов старше 60 лет.

В структуре смертности от злокачественных новообразований лиц обоего пола КРР занимает второе место.

Степень риска возникновения КРР меняется от страны к стране и даже в пределах одной страны. Она также разнится между отдельными лицами в зависимости от особенностей диеты, стиля жизни и наследственных факторов.

Согласно базе данных Globocan Международного Агентства по изучению рака (IARC) заболеваемость КРР в 2008 году в мире составила 663904, а смертность – 320397 случаев среди мужчин и соответственно 571204 и 288654 случаев среди женщин. В 2008 году КРР составил 9,8% всех случаев рака в мире у лиц обоего пола. Чаще всего он регистрируется в Северной Америке, Австралии, Новой Зеландии и в различных частях Европы. Вследствие этого КРР рассматривается как болезнь урбанизированного образа жизни. В Республике Казахстан в 2010 году выявлено 2568 больных КРР, умерло 1555. КРР занимает 5-ое место в структуре онкозаболеваемости и 3 место в структуре онкосмертности.

Чаще всего КРР возникает из аденом толстой кишки, и в отдельных случаях у пациентов с генетически детерминированными синдромами полипоза или воспалительными заболеваниями кишки. Имеются сообщения, полученные при проведении колоноскопии в рамках скрининга, о том, что распространенность аденоматозных полипов составляет 18-36%.

Благодаря высокой частоте обнаружения предопухолевых состояний и хорошей выживаемости в случае ранней диагностики, КРР рассматривают как идеальную модель для скрининга. Только 60% больных с распространенными опухолями выживают в течение 5 лет после постановки диагноза.

Учитывая ситуацию по КРР в РК, а именно: низкую 5-летнюю выживаемость (44,7%), позднюю диагностику (57,8% выявляется в 3-4 стадиях) в Государственную про-

Қазіргі таңда әлем елдерінің көпшілігінде алдыңғы қатарлы медицина ұйымдарының ұсыныстарына сәйкес колоректалды обыр ауруын ерте анықтау скринингтік бағдарламалар енгізіліп, жүзеге асырылып келеді. Ондай бағдарламаның басты мақсаты ауруды ерте анықтауды есейтіп, емдеу нәтижелерін жақсарту арқылы өлім ахуалын төмендетуге бағытталған. 2011 жылдан бастап КРҚІ ерте анықтау бойынша скринингтік бағдарламасы енгізілген ТМД елдері арасында Қазақстан тұңғыш мемлекет.

Аталған мақалада колоректелды қатерлі ісігін ерте анықтау бағдарламасының негіздемесі, оның мазмұны мен күтілетін нәтижелері ұсынылған.

В последние годы в большинстве развитых стран мира разрабатываются и проводятся различные скрининг-программы по ранней диагностике колоректального рака (КРР), согласно рекомендациям ведущих медицинских организаций. Целью таких программ в первую очередь является снижение смертности через повышение ранней диагностики и улучшения результатов лечения. Казахстан – первая страна в СНГ, где с 2011 года введена скрининговая программа по ранней диагностике КРР.

В данной статье представлено обоснование скрининга колоректального рака, его характеристика, а также ожидаемые результаты.

Last years in the majority of the developed countries are implemented various screening programs on early colorectal cancer detection (CRC) according to recommendations of the leading medical organizations. The purpose of these programs is a decreasing of mortality rate through increasing of early detection and improvement of treatment results. Kazakhstan is the first country among CIS which implemented the CRC screening program since 2011.

The justification of the esophagus and stomach cancer early detection program, its characteristic and expected results is presented at the submitted article.

грамму развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы, утвержденную Указом Президента Республики Казахстан от 29 ноября 2010 года № 1113, включен скрининг КРР.

Целью

исследования является определение основных характеристик программы по раннему выявлению предопухолевых заболеваний и рака толстой и прямой кишки, когда лечение наиболее эффективно и малозатратно, способствует в комплексе с другими методами снижению смертности больных.

Материалы исследования

Международные рекомендации, исследования специалистов в области профилактики, ранней диагностики, организации оказания онкологической помощи.

Методы

- исторический, контент-анализ.

Результаты исследований

Даны следующие характеристики скрининга колоректального рака в Казахстане.

Вид скрининга: популяционный скрининг

Целевая группа: мужчины и женщины 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 лет.

Методы скрининга: иммунохимическое исследование кала на скрытую кровь – iFOBT-тест + тотальная колоноскопия.

Уровень проведения скрининга: начиная с медицинского пункта в сельской местности и в поликлинике на уровне города.

Интервал: 1 раз в 2 года

Срок действия: постоянно

Определен алгоритм действий медицинских работников первичной медико-санитарной помощи.

Иммунохимическое исследование кала на скрытую кровь – iFOBT-тест (гемокульт-тест) проводится всем мужчинам и женщинам целевой группы. При положительном тесте пациент направляется на тотальную колоноскопию. Наличие патологического образования прямой кишки и нижних отделов сигмовидной кишки, выявленного в процессе ректосигмоскопии, не исключает наличия опухоли в вышестоящих отделах толстого кишечника. Колоноскопия проводится в клинко-диагностическом центре или онкологическом диспансере с взятием биопсии.

Исследование материала биопсии толстой кишки, полученного в результате эндоскопического исследования проводится патоморфологами по месту взятия в соответствии с общепринятыми международными стандартами и классификацией ВОЗ (Лион, 2000 г.).

Безусловно, важная роль в активном выявлении ранних форм КРР остается за профилактическими осмотрами, что, как правило, комбинируется с эндоскопическими методами. Однако стоимость таких скрининговых мероприятий чрезвычайно высока, кроме того, инвазивный характер исследований не позволяет использовать их повсеместно. Это заставляет искать простые лабораторные (неинвазивные) методы скринингового типа.

Традиционно к таким методам относится бензидиновая проба на скрытую кровь в кале (FOBT, гемокульт-тест). Это биохимический метод, основанный на оценке псевдопероксидазной активности гемоглобина.

Предложенный в последние годы метод иммуноферментного определения гемоглобина человека в кале (iFOBT), по данным ряда авторов, отличается высокой диагностической значимостью: чувствительность составляет 60-77,7% при специфичности 95%. Высокая специфичность теста связана с тем, что iFOBT не выявляет кровь из опухолей, находящихся в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, не реагирует с пероксидазой растительного происхождения и гемоглобином из пищи животного происхождения (как в случае ложно-положительного результата при FOBT). Он достаточно прост в выполнении, не требует от пациента соблюдения особой диеты, является неинвазивным и экономически выгодным по сравнению с эндоскопическими методами. Это позволяет рассматривать iFOBT как копрологический тест скринингового типа. В та-

блице представлен сравнительный анализ теста кала на скрытую кровь на основе гваяковой смолы и iFOBT.

Таблица. Сравнение тестов кала на скрытую кровь для скрининга на КРР

Критерий ВОЗ	Гваяковый	Иммуно-химический
Не требует посещения врача	Да	Да
Хорошо организуемый	Да	Да
Быстрый и удобный забор материала	Да	Да
Специфичен для кишечных кровотечений	Нет	Да
Применим к популяционному скринингу	Да	Да
Метод, доступный контролю качества и объективному анализу	Да	Да

В дополнении, следует отметить следующие преимущества iFOBT:

- специфичен для человеческого гемоглобина и не зависит от диеты и приема лекарств;
- отмечены высокие показатели участия и восприятия населением по сравнению с обычной сдачей кала на исследование;
- достаточно одного или двух образцов кала, а не трех, как при гваяковой пробе;
- имеет сопоставимые или превосходящие характеристики (чувствительность, специфичность);
- имеются автоматизированные платформы для проверки тестов, которые более доступны контролю качества, пропускная способность гораздо выше и конечный результат основывается на концентрации гемоглобина.
- возможность централизации всего колоректального скрининга в одной центральной лаборатории.

Несмотря на большой выбор имеющихся и разрабатываемых неинвазивных скрининговых методов, до настоящего времени «золотым стандартом» ранней диагностики КРР является колоноскопия с тотальным осмотром толстой кишки и терминального отрезка подвздошной кишки. Это исследование позволяет получить информацию о локализации новообразования, установить протяженность поражения, определить форму роста опухоли, оценить ее подвижность, а иногда – судить о взаимосвязи с другими органами.

Результаты

Опыт проведения скрининговых программ в европейских странах позволяет ожидать выявления ранних форм КРР и снижения смертности на 25-30%. Однако следует отметить, что достоверного изменения структуры заболеваемости и смертности следует ожидать не ранее, чем через 5-10 лет планомерного осуществления программы.

Литература

1. Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Ж. и соавт. Показатели онкологической службы Республики Казахстан, статистические материалы 2001-2010 гг.
2. Практическое руководство Всемирного гастроэнтерологического общества (ВГО) и Международного союза по профилактике рака пищеварительной системы: Скрининг колоректального рака (WGO Practice Guidelines 2008).
3. World Health Organisation & World Organisation of Digestive Endoscopy. Am J Gastroenterology 2002; 97:2499-2507.
4. Recommendations for a colorectal cancer screening programme in Ireland. 2008.

Цитологический метод в ранней диагностике рака молочной железы

Якупова Л.М.

Западно-Казахстанский областной онкологический диспансер», г. Уральск, Казахстан

Актуальность

Общеизвестно, что рак молочной железы уверенно лидирует среди заболеваемости и причин смертности женского населения. В настоящее время успехи в обеспечении здоровья населения во многом зависят от проведения массовых профилактических осмотров. Активное выявление и проведение динамического наблюдения и лечения пациенток с изменениями структуры тканей молочной железы не только приводит к снижению числа случаев заболеваемости раком молочной железы, но способствует выявлению рака на более ранних стадиях, что коррелирует со значительным повышением выживаемости от этого заболевания.

Проведение эффективных массовых профилактических осмотров, как показывает опыт многих стран, невозможен без использования цитологического метода, получившего полное признание и широкое распространение в последние годы. На современном уровне цитологическое исследование является одним из эффективных методов диагностики на любом этапе прогрессии опухоли и в этом плане дает возможность: показать характер и степень выраженности пролиферации клеток; диагностировать злокачественные опухоли при любой локализации в любой стадии процесса.

Материалы и методы

По Западно-Казахстанской области (ЗКО) в 2009 году было проведено 16 201 маммографических исследований женщин, в 2010 году - 14843, г. за 8 месяцев 2011 г. - 12011 женщин, с цитологическим исследованием пунктатов выявленных образований молочной железы. Всего с 2009 г. по сентябрь 2011 г. было проведено 6 882 цитологических исследований тонкоигольных пунктатов образований молочной железы амбулаторных больных (1740 женщин).

Результаты

Цитологически установлены ФКМ – у 501 женщины, фиброаденома - 231, киста – 270, мастит - 292, атипическая пролиферация - 26, внутрипротоковая папиллома - 13, РМЖ – 271, из них рак молочной железы скринингового возраста у 67 женщин (22% от общего числа с первично установленным диагнозом РМЖ), саркома – 1, неинформативный материал – 135.

Всего по области выявлено и взято на учёт с диагнозом рак молочной железы в 2009 г. 122 пациентки (22 пациентки скринингового возраста), заболеваемость РМЖ составила 19,7 на 100 тыс. населения. По стадиям заболевания: I-II ст. - 90 (73,8%), III ст. - 28 (23,0%), IV ст. - 4 (3,2%).

В 2010 г. – выявлено и взято на учёт 87 пациенток (25 пациенток скринингового возраста). Заболеваемость составила 13,9 на 100 тыс. населения. По стадиям заболевания: I-II ст. - 77 (88,5%), III ст. - 9 (10,3%), IV ст. - 1 (1,15%). Выявляемость РМЖ I-II ст. возросла на 14,7%.

За 8 месяцев 2011 г. – всего выявлено и взято на учёт 97 пациенток, из них 20 женщин скринингового возраста. Заболеваемость составила 15,9 на 100 тыс. населения. По стадиям заболевания: I-II ст. - 81 (83,5%), III ст. - 13 (13,4%), IV ст. - 3 (3,1%).

Сүт безі рагін ерте диагностикалаудың цитологиялық әдісі

Сүт бездері тіндерінің құрылысында өзгерістері бар науқастарға белсенді анықтаулар жүргізу, динамикалық қозғалыстарын бақылау арқылы емдеу сүт безі рагін бастапқы сатысында анықтауға мүмкіндік береді және өмір суру мүмкіндігін жорғалатады.

Зерттеудің мақсаты - Сүт безі рагін бастапқы сатыда анықтау.

Зерттеудің әдісі мен мәліметтері - Цитологиялық зерттеулердің пунктатарының көмегі арқылы, маммографиялық зерттеудің көмегімен сүт безіндегі өспелер анықталды.

Цитологиялық зерттеулер анғұрлым жоғары сенімді, қатерлі жаңа өспелерді нақты делелдеп, сонымен қатар көп жазғайда гистогенезіде анықтайды (шығу тегі, тиісті тіні) және деңгейі нақтыланған ісік, келесі бақылау және ем жүргізу үшін де өте маңызды. Активное выявление и проведение динамического наблюдения и лечения пациенток с изменениями структуры тканей молочной железы способствует выявлению рака молочной железы на более ранних стадиях и приводит к значительному повышению выживаемости от этого заболевания.

Цель исследования – выявление рака молочной железы в ранней стадии.

Материал и методы исследования - С помощью цитологического исследования пунктатов, выявленных с помощью маммографического исследования образований молочной железы.

Цитологическое исследование позволяет с достаточно высокой достоверностью не только констатировать наличие злокачественного новообразования, но и в большинстве случаев определить гистогенез (происхождение, тканевую принадлежность) и степень дифференцировки опухоли, что весьма важно для проведения последующего лечения и прогноза.

В 2007 год было взято на учёт 132 женщины РМЖ, стадии заболевания: I-II ст. – 82 (62,1%), III ст. – 39 (29,5%), IV ст. - 10 (7,6%), в 2008 г.- 135 женщин: I-II ст. – 95 (70,3%), III ст. – 35 (25,9%), IV ст. - 4 (2,9%). Возросла ранняя диагностика РМЖ - I-II ст. составляет более 80%.

Вывод

Цитологический анализ производится в первую очередь для того, чтобы получить ответ на вопрос о наличии злокачественного новообразования. В процессе дифференциальной диагностики определяется характер патологического процесса и устанавливаются воспалительные, реактивные, пролиферативные или предраковые поражения, а также доброкачественные опухоли. Несравненное преимущества перед другими методами имеет цитологическое исследо-

вание в выявлении рака начальных стадий.

Цитологическое исследование позволяет с достаточно высокой достоверностью не только констатировать наличие злокачественного новообразования, но и в большинстве случаев определить гистогенез (происхождение, тканевую принадлежность) и степень дифференцировки опухоли, что весьма важно для проведения последующего лечения (химио- и лучевое воздействие) и прогноза.

Список использованных источников

1. *Ивашков Е.А., Ефименко М.В. Методы клинической цитологии.* - М., 2003.
2. *Шабалова И.П., Джангирова Т.В., Волченко Н.Н. и соавт. Цитологический атлас «Диагностика заболеваний молочной железы».* - М., 2005.
3. *Н.Н. Волченко МНИОИ им. П.А. Герцена Журнал «Маммология».* - 2006. - №1.
4. *Годовые отчёты за 2007-2011 г. ГККП Западно-Казахстанского областного онкологического диспансера. Цитологический метод в ранней диагностике рака молочной железы.*

Итоги работы передвижной маммографической установки по Семейскому региону

Кузнецова Т.В.

Региональный онкологический диспансер г.Семей

В 2010 году Региональным онкологическим диспансером, при содействии с Корейским Агентством по Международному Сотрудничеству, была получена передвижная маммографическая станция на базе а/м Hyundai, оснащенный аналоговым маммографом «Mammomat 1000» (Сименс) и оцифровщиком «Carrula XI II» (Япония), лаборантской станцией, специальными врачебными мониторами для просмотра изображений во всех ракурсах отдельно для каждой из молочных желез и системой электронного архивирования данных. Данная передвижная станция (ПС) предназначена для обслуживания женского населения подлежащего скрининговому маммографическому осмотру, проживающему в отдаленных районах нашего региона, которые не оснащены стационарными маммографическими кабинетами. Не секрет, что расстояния между населенными пунктами нашего региона измеряется порой сотнями километров, а проведение профилактических скрининговых осмотров женского населения в возрасте от 50 до 60 лет требует регулярного мониторинга. За весенне – летний период 2011 года на ПС было обследовано более 1418 женщин. Совершались выезды в Бородулихинский район п.Жезкент, г.Шульбинск, участвовали в масштабных оздоровительно-диагностических мероприятиях, которые организовывались по бесплатному обслуживанию населения, желающего пройти профилактический осмотр не зависимо от места жительства и возраста с выдачей результатов непосредственно после проведения процедуры.

г. Шульбинск

Обследовано	Выявлено РМЖ
63	-

Бородулихинский район п.Жезкент

Обследовано	Выявлено РМЖ
282	2

г. Семей (день открытых дверей) 18.08.2011 года

Обследовано	Выявлено РМЖ
99	-

Қозғалмалы маммографиялық бекетте алшақ аудандарды 1418 әйел адам қаралды. 4 дәлелденген обыр анықталды. Тәжірибеде осы медициналық техниканы пайдалану және қайта жабдықтау керектігі дәлелденді.

In the process of working on mobile mammographic station 1418 women were observed in far districts. 4 cases of the detected cancer were revealed. Necessity of usage and reequipping of medical machinery is detected.

ЛПУ левобережья г. Семей

Обследовано	Выявлено РМЖ
974	2

Хочется отметить, что непревзойденное качество оцифрованных снимков позволяет обнаружить минимальные патологические изменения на ранних стадиях развития опухоли, дифференцировать доброкачественные образования от злокачественных. Более того, женщины отмечают щадящую функциональность аппарата, современный дизайн и располагающий интерьер кабинета, оснащенность даже самыми мелкими удобствами. Вместе с тем приходится убеждаться в несоответствии современной медицинской техники мирового уровня нашим реалиям региона г.Семей. Естественно, наличие одной передвижной станции не решает всех проблем по охвату женской части населения профилактическим маммографическим осмотром такого большого региона.

Анализируя проделанную работу мы осознаем, что необходимо оснастить маммографическим оборудованием хотя бы узловые населенные пункты нашего протяженного региона, что позволило бы более качественней и полнее охватывать женское население медицинским обслуживанием, что конечно же скажется на здоровье не только Семейского региона, но и внесет свою лепту в дело оздоровления всей нации в целом.

Концептуальный взгляд на оптимизацию дифференциальной диагностики карциномы и опухолеподобных патологий поджелудочной железы

Бердаuletов С.Б., Аязбаев Ш.У.
Мангистауская областная больница. Актау

Актуальность

Дифференциальная диагностика опухоли и опухолеподобных патологий поджелудочной железы (ПЖ), особенно протокового рака или аденокарциномы головки ПЖ и псевдотуморозного панкреатита является актуальной. В клинической практике встречаются случаи длительного наблюдения больных без специального лечения у онкологов с диагнозом рак ПЖ с последующим снятием их с диспансерного учета и наоборот. С указанным негативным явлением связаны психологическая нагрузка больных и их близких, потеря работы, установление инвалидности и т.д. Дифференциальная диагностика опухоли и опухолеподобной патологии ПЖ нередко становится непреодолимой дилеммой. Известны единичные случаи установления наличия рака ПЖ во время хирургической операции и опровержения указанного диагноза через несколько месяцев.

Цель исследования

Определение диагностических возможностей магнитно-резонансной томографии и компьютерной томографии (КТ) при опухолях ПЖ.

Материалы и методы

В 2010 году в Мангистауской областной больнице начали выполнять перфузионную КТ поджелудочной железы с целью дифференциальной диагностики рака ПЖ и псевдотуморозного панкреатита и вскоре столкнулись со следующими трудностями. Имевшийся двухсрезовый компьютерный томограф не позволял выполнить КТ-перфузии по следующей методике: получение 1 изображения в секунду после болюса 40-50 мл контраста при длительности сканирования 45 сек и в связи с этим оказался невозможной определение средней времени транзита, объема кровотока и панкреатического кровотока. Стандартная платформа PC Advantage 4,0 не имела программу (протокол) перфузии

Обсуждаются подходы к дифференциальной диагностике опухолевых заболеваний поджелудочной железы с использованием перфузионной компьютерной томографии.

This paper is discussed approaches to differential diagnostics of tumoral diseases of a pancreas with using of perfusion computer tomography.

для ПЖ.

Результаты и обсуждение

Основным методом диагностики патологии ПЖ является КТ. Нативная КТ информативна не только в 64%. По данным Г.Г.Кармазановского и соавторов в диагностике опухолей ПЖ приоритетна КТ с болюсным контрастным усилением. Во многих клиниках с этой целью используют динамическую болюсную КТ, в частности, КТ по Станфордскому протоколу, предусматривающей получение изображений поздней артериальной и портоинозной фаз (40 сек, 80 сек). По данным ряда авторов, КТ в артериопаренхиматозную и портальную фазу не информативны только в 6% и 9% соответственно.

В мировой литературе пока крайне ограничено число сообщений о диагностической ценности КТ-перфузии поджелудочной железы (рСТ). рСТ- кратковременный болюс контрастного вещества, во время прохождения которого получают повторяющиеся через одинаковый промежуток времени один или несколько срезов.

В настоящее время используются многосрезовые КТ и программные пакеты с Perfusion. На подобных КТ-системах можно выполнить перфузионную КТ и установить диагностическую ценность перфузионных характеристик различных истинных опухолей и опухолеподобных патологий поджелудочной железы.

Компьютерная и магнитно-резонансная томография в уточняющей диагностике рака пищевода

Аязбаев Ш.У., Бердаuletтов С.Б., Шантемиров С.Б., Мукантаев Т.Е.

Мангистауская областная больница,

Медицинский колледж «Мейирбике»,

Мангистауский областной онкологический диспансер, г.Актау

Актуальность проблемы

Несмотря на снижение заболеваемости, рак пищевода (РП) остается одной из частых форм онкологической патологии в Мангистауской области.

Основным методом лечения РП является хирургический. Нередко операции по поводу РП завершаются пробной торакотомией. В связи с этим, несомненно, актуально определение операбельности больных с карциномой пищевода.

Цель

Изучение диагностических возможностей компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) в уточняющей распространенности РП.

Материалы и методы

Проведен ретроспективный анализ КТ, МРТ 18 пациентов с III стадией РП, оперированных в Мангистауской областной больнице и областном онкологическом диспансере в течение 1991-2010 годов. КТ, МРТ выполнены на аппаратах CT Max 640 (General Electric), CT 6800 (Shumadzu), Hi Sheed NX/I (General Electric), MR Max (General Electric), Achieva (Philips) с напряженностью магнитного поля 1.5Т. Нативные и динамические болюсные томографические исследования проводились по собственной методике с пероральным использованием газообразующей смеси. Одновременно осуществлялось КТ желудка.

Результаты

При КТ опухоль пищевода была обнаружена у всех 18 больных с РП. Сравнительно хуже визуализировалась опухоль ретроперикардального сегмента пищевода. КТ не позволила с уверенностью определить степень инвазии стенки пищевода (П) и, только в случае распространения опухоли в окологиеводную жировую клетчатку, можно было высказать мнение об инвазии и паразофагеальном распространении опухоли. В 11 (61%) случаях РП при КТ выявлено исчезновение разделительной жировой прослойки между опухолью П и грудным отделом аорты. Во время операции у 2 (11%) из них установлена интимная спаянность или сращение опухоли П с аортой. В остальных случаях потеря жировой прослойки не означала опухолевую инвазию. Уменьшение и исчезновение triangle fat space, сочетавшееся с широким контактом опухоли и аорты (ширина контакта до 45 градусов обозначен нами термином «проблема 9-12»), имели место в 7 (39%) случаях. Проблема «9-12 часов» при КТ означала инвазию аорты опухолью. Интраоперационно, интимное сращение опухоли с аортой обнаружено в 12 (66,7%) случаях. У 1 (5,5%) пациента удалось выделить пищевод и завершить операцию резекцией первичной пластикой. КТ-заключение о прорастании опухоли и перикард при операции не было подтверждено. При операции у 3 (16,7%) больных выявлено вовлечение в опухолевый процесс непарной вены,

Использование компьютерной и магнитно-резонансной томографии имеют ограниченные диагностические возможности в уточняющей диагностике рака пищевода. Вместе с тем, их применение позволяет снизить уровень эксплоративных хирургических операций по поводу рака пищевода.

A computer and a magnetic resonance tomography have limited diagnostic possibilities in specifying diagnostics of a esophagus cancer. At the same time, their application allows to lower level of explorative surgery for esophagus cancer.

что не установлено при КТ. По КТ в 1 (5,5%) предположено прорастание опухолью непарной вены и данное предположение оказалось достоверным. Наличие при КТ увеличенных окологиеводных лимфатических узлов 5 (27,8%) подтверждено в 2 (11%) случаях и при КТ не обнаружены 7 (39%) случаев поражения лимфатических узлов групп 110, 111, 1, 3. КТ предположение верхней границы РП соответствовала истине в 14 (77,8%) случаев.

МРТ выполнена 5 (27,8%) больным с РП. На МРТ опухоль П отображается сравнительно хуже, чем при КТ, но данный метод лучше демонстрирует взаимоотношение опухоли 11 и аорты, как в аксиальной, так и косо-сагиттальной проекции (аортозофагеальной плоскости). При МРТ в 1 (5,5%) случае обнаружен увеличенный паразофагеальный лимфатический узел и в 2 (11%) случаях не диагностирован увеличенный медиастинальный лимфатический узел.

Выводы

КТ, МРТ имеет ограниченные диагностические возможности в уточняющей диагностике РП. Кроме КТ, МРТ пока не существуют более информативных методов визуализации РП, позволяющих формировать предоперационную концепцию данной патологии. КТ, МРТ позволяют, в определенной степени, определить резектабельность онкобольных с карциномой пищевода и, тем самым, снизить уровень эксплоративных хирургических операций по поводу РП.

Использованная литература

1. Бердаuletтов С.Б., Аязбаев Ш.У., Ораз А.Ж. Место компьютерной томографии в выработке предоперационной концепции у больных раком пищевода. Ж. Здравоохранение Казахстана. – 1996 - № 3. - С. 32-34
2. Аязбаев Ш.У., Бердаuletтов С.Б., Мукантаев Т.Е., Муратов К.К. Сравнительная оценка КТ-диагностики рака пищевода. Сб. тезисов Респ. научно-практической конференции «Актуальные проблемы клинической хирургии». – Актобинск, 21-22 сентября 2001 - С.49-52.
3. Аязбаев Ш.У., Ораз А.Ж., Шарыгин Р.Р., Досбаев А.С., Шантемиров С.В. Магнитно-резонансная томография в мониторинге консервативной терапии рака пищевода. Сб. тезисов научно-практической конференции. Туркестан, 2002. С. 314-318.

Диагностическая колоноскопия в амбулаторной практике

Бектурсынов С.М., Менисов Б.К.

ГККП «Областной онкологический диспансер»

г.Талдыкорган

Ценность колоноскопии в диагностике доброкачественных, а также злокачественных заболеваний толстой кишки не вызывает сомнения. В данное время по всему миру, в том числе и в республике Казахстан на фоне урбанизации и старения населения отмечается рост заболеваемости колоректальным раком. В связи с этим, колоноскопия как метод диагностики всех патологий толстого кишечника, в том числе и рака имеет неоспоримые объективные преимущества перед другими диагностическими методами (Никифоров Н.Н. с соавт.2005 г.)

Показанием к колоноскопии является появление клинических признаков, прямо или косвенно указывающих на поражение толстой кишки, а также наличие известных факторов риска по развитию злокачественных заболеваний, включающих возраст больных, превышающий 50 лет. Однако в амбулаторной практике имеются определенные препятствия относительно технической сложности проведения манипуляций и возможность развития тяжелых побочных эффектов и осложнений. В областном онкологическом диспансере г.Талдыкорган мы проводим колоноскопические исследования амбулаторным пациентам с 2008 года. Подготовку кишечника проводим лаважным методом с применением препарата «Фортранс», которое не всасывается в кишечник, достигается эффективный лаваж при пероральном приеме, не сопровождается существенными побочными явлениями. Основные больные к нам обратились по поводу подозрения на опухоль толстого кишечника. Пациенты с различными формами поражения толстой кишки, подтверждают его высокую эффективность и получают хороший результат в 95 % случаев. При этом ухудшения состояния пациентов отмечено не было. Медикаментозное сопровождение колоноскопии в большинстве случаев не проводится.

За 2 года (2008 – 2010) нами проведено 257 исследований толстой кишки, возраст пациентов был от 40 до 75 лет. Преобладали мужчины - 240 (68,21%). В результате анализа полученных данных полипы и полиповидные образования толстой кишки выявлены у 58 пациентов (22,6%), рак толстой кишки у 144 пациентов (55,7%), т.е. онкологическому

Қазіргі таңда әлемде және де Қазақстан Республикасында колоректальды обырдың көрсеткіштерінің ұлғаюы байқалады.

Осыған орай, тоқ ішектің қатерлі, қатерсіз өспелерін анықтауда колоноскопия басқа зерттеу әдістерінен басым екендігі, баға жетпестігі мүмкінсіз.

Колоноскопияға көрсеткіш – тоқ ішектің зақымдалуының клиникалық белгілерінің пайда болуы, сонымен қатар осы белгілердің қауіп-қатер факторы, яғни, 50 жастан асқан адамдарда болуы.

Тоқ ішекті зерттеуге дайындауда Фортранс препараты қолданамыз. Бұл препаратты қолдану арқылы зерттеудің нетижелілігін арттырдық.

Диспансерде 2008 -2010 ж.ж. аралығында 257 зерттеу жүргізілген. Шағымданушылар негізінен 40 – 75 жас аралығындағылар. Жынысқа бөлсек ер адамдардың үлесі басым – 240 (68,2%).

2 жылдың зерттеу нәтижелерін қорытындылай келе, тоқ ішектің обыры 144 (55,7%), тоқ ішектің қатерсіз өспелері - 58 (22,6%) екендігін анықтау мүмкін болды.

Сөзімді қорытындылай келе, колоноскопия тоқ ішектің өспелерін, обыралды патологияларын анықтауда ең басты әдіс екендігін тағы да бір рет айта кетуім керек!

Бұл әдісті жалпы емдеу желісінің емханаларына енгізудің болашағы зор!

учреждению из общей лечебной сети в основном направляются на подозрение рака, НЯК и болезни Крона у 37 (14,3%).

Таким образом, амбулаторная колоноскопия является важным методом в диагностике заболеваний толстой кишки, выявления предраковой патологии, и рака прямой и ободочной кишки имеют перспективы внедрения в поликлинические учреждения ПМСП РК.

Первичная и отсроченная хирургическая реабилитация больных раком молочной железы

Танжарыков Е.С.

Городской онкологический диспансер г. Алматы

Введение

Рак молочной железы (РМЖ) стойко удерживая «пальму первенства» среди других злокачественных новообразований у женщин, последние годы в нашей республике занимает 2-е место при доле 11,5% в 2008 году (10,8% в 2007 году) в структуре всех злокачественных опухолей, хотя в течение предыдущих 3-х лет (2004-2006) находился на 3-ьем месте [1].

Радикальная мастэктомия в модификации Маддена и Пейти является наиболее часто выполняемым оперативным вмешательством при РМЖ. Это связано с тем, что большое количество больных с впервые выявленным РМЖ имеют стадию заболевания, при которой выполнение органосохраняющего лечения невозможно [2]. Радикальная мастэктомия является инвалидизирующей операцией с утратой молочной железы, которая ассоциируется с женственностью, физической привлекательностью и сексуальностью. Потеря же этих качеств приводит к серьезным психологическим травмам, которые приводят к необратимым изменениям в социальной жизни пациентки.

Одним из важнейших и эффективных реабилитационных мероприятий является реконструкция молочной железы, которая может выполняться как одномоментно с мастэктомией, так и отсроченно [3].

Одним из перспективных направлений психосоциальной реабилитации больных РМЖ является разработка методик мастэктомии с сохранением кожи, ареолы и соска (сосково-ареолярного комплекса) в виде подкожной мастэктомии [4]. Обоснованием для широкого применения данной методики послужили работы по исследованию риска развития местных рецидивов при сохранении большей части кожи молочной железы во время мастэктомии. Результаты убедительно доказали отсутствие увеличения частоты местных рецидивов при возникновении рецидива после мастэктомии с сохранением кожи, такой же, как и после стандартной радикальной мастэктомии [5,6].

Материал и методы

В Городском онкологическом диспансере за период с 2009 по 2011 гг. выполнено 8 операций по восстановлению молочной железы, удаленной по поводу рака. В 2 наблюдениях проведена первичная реконструкция молочной железы, а еще в 6 наблюдениях - отсроченная реконструкция.

Результаты

При первичной реконструкции пациентам выполнялась подкожная мастэктомия с сохранением ареолы и соска. Дополнительно выполнялась лимфаденэктомия. Во всех наблюдениях имплантаты размещались под кожей. Операция завершалась дренированием ложа имплантата.

Отсроченная операция по реконструкции молочной железы является двухэтапной. На первом этапе выполняется иссечение рубца, мобилизация кожи и большой грудной мышцы и установка экспандера. Через 10 суток после

Первичная и отсроченная хирургическая реабилитация больных раком молочной железы

Танжарыков Е.С.

Городской онкологический диспансер г. Алматы

В работе представлены результаты внедрения одно- и двухэтапных реконструктивных операций при раке молочной железы с применением органосохраняющей техники в виде подкожной мастэктомии и моделирования молочной железы с помощью современных эндопротезов, что позволило добиться хороших эстетических результатов.

установки экспандера производится его растяжение путем введения через порт стерильного изотонического раствора. Катетер, призванный для подачи жидкости в полость экспандера, выводится через кожный прокол наружу. Период растяжения 2-2,5 месяца. После достижения необходимого объема выполняется второй этап реконструкции, заключающийся в замене экспандера на постоянный эндопротез.

Послеоперационный период протекал гладко. Серьезных послеоперационных осложнений не наблюдалось. Во всех случаях достигнут хороший эстетический результат.

Заключение. Применение методов первичной и отсроченной хирургической реабилитации у больных РМЖ, подвергнутых калечащей операции в виде экстирпации органа с использованием имплантатов позволяет выполнять одноэтапные и двухэтапные реконструктивные вмешательства с хорошим эстетическим результатом.

Литература

1. Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Д., Игусинов С.И. и др. Показатели онкологической службы в Республике Казахстан. Алматы, 2009 – С. 85.
2. Коренькова Е.В., Боровиков А.М. Пластика молочной железы как средство коррекции психосоциальных нарушений // Материалы Первого междунар. симп. по пластической и реконструктивной хирургии в онкологии. – М., 1997. – С. 152.
3. С.Н. Блохин, С.М. Портной, К.П. Лактионов и др. Злокачественные опухоли молочных желез: варианты выполнения первичной пластики в условиях химиолучевой терапии // Материалы Первого междунар. симп. по пластической и реконструктивной хирургии в онкологии. – М., 1997. – С. 135.
4. Downess K.J., Glaff B.S., Kanchwala S.K. et al. Skin-sparing mastectomy and immediate reconstruction is an acceptable treatment option for patients with high-risk breast carcinoma // Cancer. – 2005. – 1/103 (5). – P. 906-913.
5. Nevman L.A., Kuerer H.M. Presentation treatment and outcome of local recurrence after skin-sparing mastectomy and immediate breast reconstruction // Ann. Surg. Oncol. – 1998. – Vol. 5 (7). – P. 620-626.
6. Slavin S.A., Schnitt S.J., Duda R.B. et al. Skin-sparing mastectomy and immediate reconstruction: oncologic risk and aesthetic results with early-stage breast cancer // Plast. Reconstr. Surg. – 1998. – 102 (1). – P. 49-62.

Трудная интубация трахеи. Пути решения проблемы

Кусаинов Б. Р.

Цель

Найти оптимальное решение проблемы обеспечения и поддержания проходимости верхних дыхательных путей и снизить вероятность развития связанных с ней отрицательных клинических исходов.

По определению американской ассоциации анестезиологов трудная интубация это «клиническая ситуация, при которой опытный анестезиолог сталкивается со сложностями проведения масочной вентиляции и/или интубации больного более чем в двух (по некоторым авторам – трех) попытках или в течение более 10 мин». При обычной анестезии частота трудной интубации трахеи составляет от 1,8 до 2,5%, а в акушерской практике достигает 7,9%. На сегодняшний день проблема обеспечения проходимости дыхательных путей и достижения адекватного газообмена является одной из актуальных проблем для анестезиологов-реаниматологов. От правильного и своевременного предупреждения или устранения критической гипоксии напрямую зависит качество и конечный результат оказания медицинской помощи пациентам. По данным анализа судебных исков в США, проведенного ASA за период 1987-1995 гг., тяжелые последствия трудной интубации трахеи являются второй по частоте причиной подачи исковых заявлений. Кроме того, в 57% случаев трудной интубации наступила смерть или тяжелое гипоксическое повреждение головного мозга.

Материалы и методы

Материалом для написания этой статьи послужили пациенты, подвергшиеся оперативному вмешательству, как в плановом, так и в экстренном порядке в КазНИИ ОиР. В большинстве случаев материал набран на пациентах отделения опухолей головы и шеи. Причинами возникновения трудностей при интубации могут быть как врожденные, так и приобретенные состояния. В большинстве случаев трудности интубации могут быть предсказаны во время элементарного предоперационного обследования пациента. Однако даже наиболее скрупулезное обследование не всегда позволяет предсказать трудную интубацию, поэтому каждый анестезиолог должен быть готов к потенциальным трудностям в любое время и при их появлении следовать заранее подготовленному плану действий. Трудную интубацию можно условно разделить на ожидаемую (прогнозируемую) и неожиданную (например, в экстренной ситуации). В обоих случаях эксперты различных анестезиологических ассоциаций предлагают схожие алгоритмы действий. Причины трудной прямой ларингоскопии и трудной интубации трахеи делят на клинические, анатомические и связанные с патологией верхних дыхательных путей.

Клинические причины

Указания на трудную интубацию трахеи во время предыдущих анестезий: храп, обструктивное сонное апноэ, стридор, невозможность лежать на спине, акромегалия, беременность (III триместр), нарушения гемостаза, сахарный диабет I типа, ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит.

Анатомические причины: аномалии гортани, макроглоссия, глубокая, узкая ротоглотка, выступающие вперед резцы и клыки, короткая толстая шея, микрогнатия, увеличение передней и задней глубины нижней челюсти, ограниченное раскрытие рта.

Тәжірибе де, өз жаттығу тәжірибесі де осы бапты мақсат, тыныс бекітуірек және теріс клиникалық нәтижелердің дамытуды ықтималдығының төмендетуі жалпылау, анестезиологтердің әріптестері және өткізгіштіктің ұтымды бекітуірек қамтамасыз етуінің шешім болып табылады. Материал КазНИИ ОиР бас және мойынның ісіктерінің бөлімшесі емделушілерінде жинаған. Барлық қиын интубациялар жақтың қарысуы бұл ауыздың ашуын шектеу, төменгі жақтардың операциядан кейінгі стриктуралар және тыртық деформациялары қайтадан жедел кірісу ұшырайтын емделушілер (болжалатын) күтілетінге осы жағдайда жіктеледі; сол сияқты (шұғылы) күтпеген жайт паталогийінің клиника - анатомиялық ерекшеліктерінің салдары жедел кірісу тұңғыш рет ұшырайтын емделушілерінде жоғарғы тыныс бекітуірек пайда болатын ауыр интубациялар. Малампати бойынша клиникалық тесттің қолдануы кризистік ахуалдағы анестезиологтің әсерлерінің тиімділіктің жоғарылатуы үшін кеңірдекке және қадам сайын алгоритмді өндіруге қиын интубацияны болжауға мүмкіндік береді.

Целью данной статьи, является обобщение, как своего практического опыта, так и опыта коллег анестезиологов и решение оптимальных путей обеспечения проходимости дыхательных путей и снижение вероятности развития отрицательных клинических исходов. Материал набран на пациентах отделения опухолей головы и шеи КазНИИ ОиР. Все трудные интубации делятся на ожидаемые (прогнозируемые) в данном случае это пациенты, подвергшиеся повторному оперативному вмешательству (ограничение открывания рта, послеоперационные стриктуры и рубцовые деформации нижних челюстей, тризм; так и неожиданные (экстренные) тяжелые интубации, возникающие, как следствие клинко-анатомических особенностей и паталогий верхних дыхательных путей у пациентов впервые подвергшихся оперативному вмешательству. Применение клинического теста по Малампати позволяет прогнозировать трудную интубацию трахеи и выработку пошагового алгоритма для повышения эффективности действий анестезиолога в критической ситуации.

The purpose of given article, generalization, both the practical experience, and experience of colleagues of anesthesiologists and the decision of optimum ways maintenance of passableness of respiratory ways and decrease in probability of development of negative clinical outcomes is. The material is typed on patients of branch of tumors of a head and a neck of KazNII OiR. All difficult intubations share on expected (predicted) in this case they are patients, подвергшиеся to repeated operative intervention (restriction of opening of a mouth, postoperative structure and cicatricial deformation of the bottom jaws, (masticatory spasm); and the unexpected (emergency) heavy intubations arising, as consequence of kliniko-anatomic features and pathology the

Патология верхних дыхательных путей: врожденные и приобретенные заболевания костных, хрящевых и мягкотканых структур, окружающих верхние дыхательные пути; отсутствие зубов, мосты, протезы; травмы, переломы костей лицевого черепа, шейного отдела позвоночника; ожоги, инфекции, отеки, гематомы лица, рта, глотки, гортани и шеи. Для выявления вышеперечисленных причин трудной прямой ларингоскопии и интубации трахеи анестезиолог должен всегда, кроме экстренных случаев (пациент в бессознательном состоянии), проводить осмотр пациента перед предстоящей операцией на предмет трудной интубации. Существуют специфические тесты для скрининга при прогнозировании сложной интубации. Перед интубацией необходимо учитывать результаты предыдущей манипуляции.

Результаты

С помощью ряда клинических тестов можно попытаться предсказать вероятность трудной интубации трахеи. Один из таких тестов, широко используемых в настоящее время, был предложен Mallampati и модифицирован. Samsoon и Young [1]. Тест заключается в следующем: пациент сидит напротив анестезиолога и по его просьбе широко открывает рот. При осмотре ротовой полости анестезиолог классифицирует увиденную картину на 4 степени: степень 1 – визуализируются небные дужки, мягкое небо и язычок. Степень 2: визуализируются небные дужки и мягкое небо, однако преддверие полости рта скрыто основанием языка. Степень 3: визуализируется лишь мягкое небо. Степень 4: мягкое небо не видно. С клинической точки зрения, степень 1 предсказывает легкую интубацию трахеи, тогда как степени 3 и 4 свидетельствуют о значительной вероятности сложной интубации. На результаты теста Mallampati влияют способность пациента открыть рот, размер и подвижность языка и других структур ротоглотки, а также подвижность атлантоокципитального сочленения. Расстояние между подбородком и щитовидным хрящом измеряется от щитовидной вырезки до кончика подбородка при разогнутой голове. В норме это расстояние составляет > 6,5 см; оно зависит от ряда анатомических факторов, одним из которых является расположение гортани. При расстоянии между подбородком и щитовидным хрящом > 6 см, интубация трахеи выполняется, как правило, без проблем. Однако если это расстояние < 6 см, интубация может быть неосуществимой [2]. Учитывая результаты обоих тестов (модифицированный тест Mallampati и расчет расстояния между подбородком и щитовидным хрящом), Ferek предлагает расценивать предполагаемую интубацию трахеи как сложную при степенях 3 и 4 по Mallampati и расстоянии между подбородком и щитовидным хрящом < 7 см и считает, что данный подход позволяет прогнозировать большинство сложных интубаций [3]. Для измерения расстояния между подбородком и щитовидным хрящом могут быть использованы маркер или карандаш длиной 7 см, а также палец анестезиолога; при измерении важно определить, превышает ли это расстояние 7 см. Расстояние между подбородком и грудиной измеряется от кончика подбородка до яремной вырезки грудины при разогнутой шее и зависит от ряда факторов, основным из которых является способность больного разогнуть шею. Этот тест также может оказаться полезным для предсказания трудной интубации трахеи, прогнозируемой при расстоянии между подбородком и грудиной < 12,5 см [4]. Разгибание шеи в атлантоаксиальном сочленении можно оценить, если попросить больного согнуть шею, наклонив ее вниз и вперед. Вслед за этим шея больного удерживается в данном положении, а пациента просят поднять голову, что позволяет понять, насколько осуществимо разгибание шеи. При нормальной

top respiratory ways at patients for the first time subjection operative to intervention. Application of the clinical test on Mallampati allows to predict a difficult intubation to a trachea and development of step-by-step algorithm for increase of efficiency of actions of the anesthesiologist in a critical situation.

подвижности в атлантоаксиальном сочленении проблем с интубацией трахеи чаще всего не возникает, в то время как ограничение движений служит еще одним признаком сложной интубации. Способность выдвигать вперед нижнюю челюсть позволяет оценить ее подвижность. Если больной выдвигает нижнюю челюсть настолько, чтобы нижние зубы оказались впереди верхних, затруднений с интубацией трахеи ждать не приходится, тогда как в ситуации, когда он не может выровнять их в одну линию, интубация обещает быть сложной [5]. Wilson и соавт. изучили сочетание различных факторов, предрасполагающих к сложной интубации, с подсчетом общего количества баллов [6]. Данная шкала учитывает ограничения в открытии рта и разгибании шеи, выступающие верхние зубы, а также неспособность выдвинуть вперед нижнюю челюсть. Хотя в большинстве случаев этот метод может предсказать трудную интубацию, он часто приводит к ложноположительным результатам, когда интубация расценивается как сложная, а оказывается легкой. Этот недостаток шкалы сдерживает ее широкое распространение.

Рентгенологическое исследование не используется в качестве рутинной скрининговой методики сложной интубации, однако в ряде ситуаций оно может оказаться полезным для оценки анатомических особенностей нижней челюсти. В случае выявления высокого риска трудной интубации трахеи анестезиолог должен сделать в истории болезни запись с перечислением признаков, указывающих на возможную трудную интубацию. При этом необходимо указать план предполагаемых действий по обеспечению проходимости дыхательных путей. Результаты опроса анестезиологов в РК, позволяют заключить, что отсутствие четкого основного и резервного плана действий в случае трудной интубации является характерным для значительного числа специалистов. В связи с чем есть четкое убеждение в необходимости формулирования пошагового алгоритма для повышения эффективности действий анестезиолога в критической ситуации. Ведение пациента с проблемами проходимости дыхательных путей не заканчивается установкой интубационной трубки в трахею. Необходимо иметь стратегию экстубации пациента, причем она должна быть логически связана с тактикой интубации пациента в каждом конкретном случае. Поскольку всегда после экстубации существует вероятность развития различных осложнений, некоторые из которых могут потребовать проведения реинтубации, всегда более сложной и часто связанной с имеющейся уже гипоксией, гиперкапнией, нарушениями гемодинамики. Кроме того, она выполняется персоналом, находящимся в стрессовом состоянии, поэтому реинтубация всегда должна рассматриваться как процедура высокого риска, и к ней должны быть готовы. Каждый случай возникновения проблем с обеспечением проходимости дыхательных путей на любом этапе ведения пациента в предоперационном периоде должен быть документирован в истории болезни. Необходимо осуществлять сбор информации для дальнейшего анализа причин развития данных ситуаций и разработки методов их профилактики. Рекомендуются информирование пациента о сложившейся трудной интубации и о необходимости в дальнейшем информировать анестезиолога об имевших место трудностях интубации.

Заключение

На основании вышеизложенного материала необходимо внести коррективы в предоперационный осмотр пациента анестезиологом. Все данные осмотра пациента, анамнеза, а также результаты специфичных тестов для выявления предстоящей трудной интубации должны быть зафиксированы документально. Для осуществления данной задачи необходимо сделать поправки в бланках, листах предоперационного осмотра (консультации) анестезиологом, а также в листе протокола анестезии путем внесения отдельной графы, например, «предполагаемая трудная интубация», где будут четко отражены причины трудности интубации и план по обеспечению проходимости дыхательных путей. Графа «экстубация» должна отражать возникшие проблемы при экстубации трахеи. Наряду с информированием пациента о возникших трудностях интубации, необходимо внесение соответствующей информации в выписных эпикризах. Все операционные и реанимационные залы должны быть оснащены всеми нужными инструментами,

расходными материалами, а также оборудованием. Врачи-анестезиологи периодически должны повышать квалификацию путем посещения лекций, посвященных проблемам трудной интубации.

Литература

1. Samsoon G.L.T., Young J.R.B. Difficult tracheal intubation: a retrospective study // *Anaesthesia*. 1987; 42: 487-490.
2. Patil V.U., Stehling L.C., Zaunders H.L. *Fiberoptic Endoscopy in Anesthesia*. Chicago: Year Book Medical Publishers, 1983.
3. Frerk C.M. Predicting difficult intubation // *Anaesthesia*. 1991; 46: 1005-1008.
4. Savva D. Prediction of difficult trachea intubation // *Brit. J. of Anaesthesia* 1994; 73: 149-153.
5. Calder I., Calder J., Crockard H.A. Difficult direct laryngoscopy in patients with cervical spine disease // *Anaesthesia*. 1995; 50: 756-763.
6. Wilson M.E., Spiegelhalter D., Robertson J.A., Lesser P. Predicting difficult intubation // *Brit. J. of Anaesthesia* 1988; 61.

Эпидуральная анестезия при операциях на толстом кишечнике у онкологических больных

Кусаинов Б. Р.

Эпидуральная анестезия (ЭА), как компонент анестезиологического пособия, находит все большее применение при оперативных вмешательствах в онкологии, при этом оптимальным условием является развитие эпидурального блока до начала операции (принцип предупреждающей анальгезии). Возникают и новые методики ее использования, что обусловлено как появлением современных препаратов (ропивакаин – нарופן в различных концентрациях), так и совершенствованием технического оснащения (длительная инфузия местных анестетиков в эпидуральное пространство). При этом достигается адекватная ноцицептивная защита пациента, позволяющая значительно уменьшить или исключить полностью применение наркотических анальгетиков и, соответственно, избежать их отрицательных эффектов. Стабильная блокада ноцицептивной импульсации из операционной раны, обусловленная проведением ЭА с катетеризацией эпидурального пространства, гарантирует снижение влияния операционного стресса и позволяет продолжить комплексную антиноцицептивную защиту в послеоперационном периоде.

Цель работы

- обобщение клинического опыта применения ЭА в периоперационном периоде реконструктивно-восстановительных операций на толстом кишечнике.

Материалы и методы

В 2007-2009 гг. в КазНИИ онкологии и радиологии выполнено 112 реконструктивно-восстановительных операций на толстом кишечнике. У 48 больных (42,86%) оперативное вмешательство выполнено в условиях многокомпонентной внутривенной анестезии с ИВЛ и миоплегией. Во второй группе, 64 больных (57,14%), перед операцией был установлен эпидуральный катетер и проводилось комбинированное обезболивание.

Результаты

Интраоперационная гемодинамика у больных, оперированных в условиях ЭА, была более устойчивая, в раннем послеоперационном периоде продленная ИВЛ в этой группе проводилась только

у 3-х больных длительностью до 1 часа, в то время как в первой группе ИВЛ проводилась всем больным от 1 часа до 5 часов. Все больные второй группы отмечали более эффективное обезболивание (оценка по балльной шкале). Отмечено, что перистальтика и выделительная функция кишечника также восстанавливались раньше, чем в первой группе.

Осы зерттеулер мақсат, анестезиялық оқу құралының компоненті ретінде эпидурал жансыздандыруын қолдануды клиникалық тәжірибенің бағасы сонымен бірге ерте операциядан кейінгі кезеңде болып табылды. ЭА қолдану емделушінің қорғауының бірдей ноцицептивонийына жетуге мүмкіндік береді есірткі анальгетиктердің қолдануын санды кішірейтуге мүмкіндік беретін. Бұдан басқа, ИВЛ емделушілердің болуды уақытының кішірейтуі, сонымен бірге бұрышы және ішектердің бөлгіш функциясының қалпына келтіруін ертелеу атап өтеді. Біз ЭА өткізу сезімсіздендіруді тиімді әдіс реконструктивтігі - қалпына келтіргіш операцияларда онкология ауруларында болып табылғанын санаймыз.

Целью данного исследования, являлась оценка клинического опыта применения эпидуральной анестезии, как компонента анестезиологического пособия, а также в раннем послеоперационном периоде. Применение ЭА позволяет достигать адекватной ноцицептивной защиты пациента, позволяющей уменьшить количество применения наркотических анальгетиков. Кроме того, отмечается уменьшение времени пребывания пациентов на ИВЛ, а также более раннее восстановление перистальтики и выделительной функции кишечника. Мы считаем, что проведение ЭА является эффективным методом обезболивания при реконструктивно-восстановительных операциях у онкологически больных.

Objective of this research, the estimation of clinical experience of application epidural anesthetics, as components anestesiologies grants, and also in the early postoperative period was. Using ЭА allows to reach adequate noiception protection of the patient, allowing to reduce quality applications of narcotic analgetics. Besides, reduction of time of stay of patients on ИВЛ, and also earlier restoration peristalticum and secretory function of intestines is marked. We consider that procommand ЭА is an effective method of anesthesia at reconstructively-regenerative operations at oncology patients.

Выводы

Считаем, что проведение периоперационного обезболивания на основе ЭА является эффективным методом обезболивания при реконструктивно-восстановительных операциях у онкологических больных.

Применение Севофлурана в хирургии опухолей

ГОЛОВЫ И ШЕИ

Кусаинов Б.Р.

Современная ингаляционная анестезия нашла широкое применение в различных разделах хирургии. В настоящее время в клинической практике наиболее часто используются изофлуран и севофлуран.

Цель исследования

- оценить результаты применения севофлурана в хирургии опухолей головы и шеи.

Пациенты и методы

Исследование выполнено у 84 больных (средний возраст $54,8 \pm 5,2$ года), оперированных в плановом порядке по поводу опухолей головы и шеи в КазНИИ ОиР

Среди проведенных вмешательств преобладали комбинированные операции по поводу новообразований гортани, ротоглотки, дна полости рта, языка, верхней и нижней челюсти, слюнных и щитовидной желез, в том числе с первичной пластикой перемещенным кожно-мышечным лоскутом, а также различные варианты шейных лимфодиссекций. Большая часть пациентов отнесена к III классу ASA. Всем больным проводили комбинированную общую анестезию с ИВЛ. За 30 минут до операции внутримышечно вводили анальгетик периферического действия кетопрофен в дозе 1,5 мг/кг. Премедикация на операционном столе включала внутривенное введение атропина (0,01 мг/кг) и фентанила (0,0015 мг/кг). Введение в анестезию осуществляли пропофолом (2 мг/кг), поддержание анестезии – севофлураном в дозе 1,3 – 1,5 МАК и дробным введением фентанила (0,00075 мг/кг на травматичных этапах операции). Миорелаксанты (дитилин 2 -3 мг/кг) использовали только на этапе интубации трахеи. Средняя продолжительность операций составила 90 ± 25 минут. В динамике регистрировали показатели гемодинамики, пульсоксиметрии и капнометрии, проводили исследование периода ранней постнаркозной адаптации.

Результаты

Во всех случаях отмечали гладкое течение анестезии, стабильные показатели гемодинамики, пульсоксиметрии и капнометрии. На этапе индукции анестезии регистрировали снижение уровня САД на $18 \pm 3,5\%$ по сравнению с исходным уровнем, $p < 0,05$. На последующих этапах анестезии отмечали устойчивые показатели ЧСС и САД в пределах безопасного уровня. Средний расход фентанила для поддержания анестезии составил 0,0015 мг/кг. Дополнительного использования миорелаксантов, транквилизаторов и гипотензивных препаратов не требовалось. Высокая управляемость анестезии на основе севофлурана обеспечивала быстрое постнаркозное пробуждение. Восстановление самостоятельного дыхания отмечали через $6 \pm 2,2$ минут после окончания операции, кашлевого рефлекса – через $9 \pm 3,0$ минут, сознания – через $11 \pm 2,5$ минут. Экстубацию трахеи проводили после санации верхних дыхательных путей на фоне восстановления адекватного дыхания. При оценке активности ЦНС через 10 минут после экстубации трахеи по тесту Bidway получены следующие данные: у 69 (82,1%) больных – 0 баллов, у 10 (11,9%) – 1 балл и у 5 (6%) больных – 2 балла. В течение анестезии и

Осы зерттеулер мақсат, тамақ булау анестетиктарының қолдануды клиникалық тәжірибенің бағасы бас және мойынның ісіктері бар емделушілерінде болып табылды. Емделушілер көбінесе ASA бойынша III және II сыныпқа жатқызған. Барлық жағдайлардағы гемодинамиктер, пульсоксиметрия және капнометрия жансыздандыруды тегіс ағым, тұрақты көрсеткіштерді белгіледі. Ортақ жансыздандыруды адекваттылық, басқарылу және қауіпсіздік, дербес тыныстың тез қалпына келтіруімен және қорғайтын рефлексдердің қамтамасыз етеді бас және мойынның ісігінің хирургиядағы севофлуранасы қолдану.

Целью данного исследования, являлась оценка клинического опыта применения ингаляционных анестетиков у пациентов с опухолями головы и шеи. Большая часть пациентов отнесена к III и II классу по ASA. Во всех случаях отмечали гладкое течение анестезии, стабильные показатели гемодинамики, пульсоксиметрии и капнометрии. Применение севофлурана в хирургии опухоли головы и шеи обеспечивает адекватность, управляемость и безопасность общей анестезии, с быстрым восстановлением самостоятельного дыхания и защитных рефлексов.

Objective of this research, the estimation of clinical experience application inhalation anesthesia at patients with head and neck tumors was. The most part of patients is carried to III and to II class on ASA. Bo all cases marked a smooth current of anesthesia, stable indicators of haemodynamics, pulsemetrition and cupnometrition. Application sevofluran in surgery of a tumor of a head and a neck provide adequacy, controllability and savety the general anesthesia, with fast restoration of independent breath and protective reflexes.

раннего постнаркозного периода не отмечено серьезных осложнений, связанных с применением севофлурана. Синдром послеоперационной тошноты и рвоты выявлен у 4 (4,8%) больных с манифестацией через 1-2 часа после окончания операции. Всем пациентам назначали комплексное послеоперационное обезболивание (внутримышечное введение кетопрофена по 100 мг 2 раза в сутки трамадола по 100 мг 3 раза в сутки). В послеоперационном периоде 8 (9,5%) больных в течение суток наблюдались в реанимационном отделении. 76 (90,5%) пациентов после операции находились в палате пробуждения в течение 2-3 часов с последующим переводом в хирургическое отделение, что значительно снизило затраты на лечение.

Вывод

Применение севофлурана в хирургии опухолей головы и шеи обеспечило адекватность, безопасность и управляемость общей анестезии, минимальную потребность в наркотических анальгетиках и миорелаксантах, быстрое пробуждение с восстановлением самостоятельного дыхания и защитных рефлексов.